

XIAOERBING SHOU DAO BING CHU

手

到

病

除



千纸鹤

主编 焦 平

小儿病 手到病除



河北科学技术出版社

责任编辑：王辛卯
任继红
封面设计：寇 菁

- 妇女病手到病除
- 老年病手到病除
- 小儿病手到病除



XIAOERBING SHOU DAO BING CHU

手到病除

ISBN 7-5375-3106-4



9 787537 531061 >

ISBN 7-5375-3106-4

R·659 定价:15.00 元

图书在版编目 (CIP) 数据

小儿病手到病除/焦平主编. —石家庄: 河北科学技术出版社, 2004

ISBN 7-5375-3106-4

I. 小… II. 焦… III. 小儿疾病-按摩疗法 (中医) IV. R244.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 100702 号

小儿病手到病除

主编 焦平

出版发行	河北科学技术出版社
地 址	石家庄市友谊北大街 330 号 (邮编: 050061)
印 刷	河北新华印刷一厂
经 销	新华书店
开 本	850×1168 1/32
印 张	7.25
字 数	170000
版 次	2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷
印 数	4000
定 价	15.00 元

<http://www.hkpress.com.cn>

前 言

小儿推拿有着悠久的历史，早在 2000 多年以前就有推拿治疗小儿疾病的记载。迄今为止，虽几经盛衰而不灭，证明它有着旺盛的生命力。

现代社会中，孩子多为独生子女，他们在家庭中的重要性不言而喻。孩子的一举一动都牵动着家长的心，尤其是他们的健康状况更是家长所关注的焦点。父母都希望孩子能够健康快乐地成长，但由于儿童为“稚阴稚阳”之体，“脏腑娇嫩，形体未充”，极易受到病邪侵袭，导致各种疾病。到医院就诊，不外乎是传统的治疗方法如服药、输液等，对成人来说轻而易举，但对儿童而言，则有一定难度。家长经常向医生反映孩子服药及输液时的困难，希望有一种既行之有效，又易于被孩子接受的治疗方法。小儿推拿适应了这种要求，它疗效好，经济实用，操作简单又无副作用，解除了家长的后顾之忧，逐渐受到群众和医务工作者的青睐。

为了继承和发扬祖国医学这一宝贵遗产，在吸收前人经验的基础上，作者结合临床 20 余年的推拿经验，编写了《小儿病手到病除》一书。目的是使小儿推拿在全社会得到推广，使之更好地为广大患儿服务。

此书始终贯穿着简单易学、学以致用的原则。从基础知识讲起，以图文并茂的形式介绍了穴位部位、功能主治、操作方法，能使读者快速入门并熟练掌握推拿手法。又运用中西医结合理论，详细介绍了常见病的基本概念、病因病机、主要表现、常用穴位、推拿手法及随证加减，还编写了预防厌食、感冒、近视眼、鼻炎等病的保健推拿。附有小儿保健推拿、其他疗法、推拿三字经及注释。读者只要辨证取穴，手法得当，均能取得较为理想的疗效。

此书在编写中，我们力求做到简明扼要、切合实用，阅后即可操作。但由于水平有限，在编写的内容及形式上仍存在不足之处，恳请广大读者及医家提出宝贵的意见，以便不断地充实和完善。

作 者

2005 年 8 月

目 录

基础知识篇

小儿推拿的适应证	[3]
小儿推拿的禁忌证	[3]
小儿推拿的特点	[3]
小儿推拿的作用	[4]
小儿推拿穴位的形态	[4]
推拿的治疗原则	[5]
小儿推拿的注意事项	[5]
推拿介质	[6]
推拿作用机理	[7]
推拿手法	[16]
单式法	[16]
推法	[17]
拿法	[19]
揉法	[20]
运法	[22]
捣法	[23]
掐法	[23]
捏法	[24]

摩法	[25]
擦法	[27]
按法	[28]
扯法	[29]
搓法	[29]
刮法	[30]
揉法	[31]
抖法	[32]
提法	[32]
折法	[33]
摇法	[33]
拉法	[34]
复式法	[35]
二龙戏珠	[35]
凤凰展翅	[35]
乌龙摆尾	[36]
双龙摆尾	[37]
丹凤摇尾	[38]
龙入虎口	[38]
苍龙摆尾	[38]
老汉扳僧	[39]
猿猴摘果	[40]
清天河水	[40]
水底捞月	[41]
黄蜂出洞	[41]
黄蜂入洞	[42]
运土入水法	[42]

运水入土法	[42]
打马过河	[43]
揉耳摇头法	[43]
头痛推拿法	[44]
常用穴位	[45]
攒竹	[49]
天庭	[50]
上星	[50]
印堂	[50]
山根	[50]
太阳	[51]
头维	[51]
阳白	[51]
四白	[51]
人中	[52]
承浆	[52]
迎香	[52]
耳门	[53]
百会	[53]
风池	[53]
风府	[53]
天柱骨	[54]
大椎	[54]
肩井	[54]
风门	[55]
肺俞	[55]
脾俞	[55]

肾俞	[56]
命门	[56]
七节骨	[56]
龟尾	[57]
长强	[57]
委中	[57]
承山	[58]
天突	[58]
璇玑	[58]
华盖	[59]
膻中	[59]
膈中	[59]
巨阙	[59]
上脘	[60]
梁门	[60]
石关	[60]
中脘	[60]
下脘	[61]
水分	[61]
建里	[61]
神阙	[61]
丹田	[62]
腹阴阳	[62]
气海	[63]
关元	[63]
血海	[63]
天枢	[63]

肚角	[64]
足三里	[64]
三阴交	[65]
太冲	[65]
解溪	[65]
涌泉	[66]
止泻灵	[66]
脾穴	[66]
胃穴	[67]
肝穴	[67]
大肠穴	[68]
心穴	[68]
肺穴	[69]
小肠穴	[69]
肾穴	[69]
四横纹	[70]
小横纹	[70]
板门穴	[71]
四缝穴	[71]
天河水穴	[71]
小天心	[72]
八卦穴	[72]
阴阳穴	[73]
总筋穴	[73]
三关穴	[74]
六腑	[74]
五指节	[74]

二马穴	[75]
精灵	[75]
威灵	[75]
外劳宫	[76]
合谷	[76]
一窝风	[76]
老龙	[77]
两扇门	[77]
膊阳池	[77]
列缺	[78]
曲池	[78]

疾病治疗篇

感冒	[81]
咳嗽	[84]
发热	[86]
小儿肺炎	[89]
百日咳	[92]
支气管哮喘	[94]
咽炎	[97]
头痛	[99]
呕吐	[101]
婴幼儿腹泻	[103]
细菌性痢疾	[106]
便秘	[108]
腹痛	[110]
厌食	[113]

疳积	[115]
口疮	[117]
鹅口疮	[119]
流口水	[121]
遗尿	[122]
脱肛	[124]
肠套叠	[125]
近视眼	[127]
小儿疝气	[128]
惊风	[130]
夜啼	[132]
营养性贫血	[134]
鼻衄	[137]
婴幼儿手足搐搦症	[139]
维生素 A 缺乏症	[141]
佝偻病	[143]
病毒性心肌炎	[145]
尿频	[148]
尿潴留	[149]
肾盂肾炎	[151]
急性肾炎	[153]
慢性肾炎	[156]
肾病综合征	[158]
小儿斜颈	[160]
面部神经麻痹	[162]
进行性肌营养不良	[163]
小儿痿证	[166]

类风湿性关节炎	[169]
轻微脑功能障碍综合征	[171]
癫痫	[173]
脑性瘫痪	[176]
神经性耳聋	[178]
慢性鼻炎	[180]
过敏性鼻炎	[182]
附录一 小儿保健推拿	[185]
附录二 其他疗法	[190]
附录三 推拿三字经及注释	[197]
参考文献	[217]

◇小儿病手到病除◇

基础知识篇

JICHU ZHISHI PIAN



小儿推拿的适应证

推拿的适应证范围很广，它既可用于某些内科疾病的治疗，又可用于某些外科疾病的治疗。由于临床实践中治疗的病种逐渐增多，适应证范围也不断扩大。本书只编著了儿科常见病和杂病，如厌食、腹痛、小儿急慢性胃炎、单纯性腹泻、细菌性痢疾、便秘、脱肛、疳积、佝偻病、小儿麻痹、感冒、发热、咳嗽、气管炎、惊风、口疮、遗尿、癃闭、百日咳、夜啼、眼睑下垂、面神经麻痹、营养性贫血、进行性肌营养不良、肾炎、肾病综合征、轻微脑功能障碍综合征等，也涉及一部分外科疾病，如先天性斜颈、肠套叠等。

小儿推拿的禁忌证

对骨折、创伤性出血、急慢性肝炎、白血病及其他烈性传染病不宜推拿。

小儿推拿的特点

小儿推拿是以中医传统理论为指导，通过辨证达到施治的目的。操作方法简便易行，且又易学易懂，只要按要求反复实践，很快就能掌握应用。

使用方便，不需要医疗器械，不需要特殊环境，不分城乡，在家庭、托儿所或工厂均可操作。

小儿推拿安全可靠，无痛苦，无副作用，只要辨证正确，按要求认真操作，一般不会产生不良反应和医疗事故。

小儿推拿疗效显著，对常见病、多发病均有较好的疗效，尤其是对消化道疾病疗效更佳。对某些慢性病和疑难病有一定的疗效；对一些高热的急性病，只要用之得当，便能起到快速退烧的作用；对健康小儿推拿某些穴位，可以起到预防保健作用，所以推拿在国内外越来越受到重视。

小儿推拿的作用

小儿推拿是根据中医的传统理论，从整体观念出发，按照“补虚泻实”、“动静结合”，以及“动中结合”（被动运动和自主运动相结合）的原则，运用各种柔硬轻重不同的手法进行操作，起到舒筋活络，宣通气血，缓解痉挛，活血化瘀，消肿止痛，散风除湿，温经散寒等作用，从而达到治疗疾病的目的。

中医认为，人的生命活动必须依靠气血的维护和营养，其中以经络作为气血运行的通路，经络分布周身，四通八达，使气血周流不息，循环无端，以保持阴阳平衡，内外协调，故从经络现象上对人体皮毛、肌肉、筋骨、脏腑等都能反映出正常的生理和病理变化。如果人体某一经络或脏腑失于常态，则必致气血不和，内脏或经脉失于营养，按经络的循行和气血的顺逆，推穴道拿筋骨，就可以达到调整气血的效果，以恢复身体健康。

小儿推拿穴位的形态

穴位的形态是指穴位的形状，我们把它分为点形、线形、面形、环形4种。所谓点形，就是局限于一个点，面积较小，跟针灸穴位一样。如针灸穴位的外劳宫、足三里等都是一个点；线形穴，顾名思义全为一条直线，也就是从某处到另一处，呈一条直线，如后面讲到天河水、六腑等；面形穴位就是比点形穴位面积大，如后面讲的板门穴；环形穴位或弧形穴位，即从某一个穴位

到另一个穴位呈弧形或环形，如八卦穴、运土入水穴等。

推拿的治疗原则

◎正治法：就是正常的常用治法，针对疾病不同的性质，采用与疾病性质相反的手法进行治疗，如塞病用通法、通病用塞法、虚病用补法、实病用泻法等，推而广之，用消食法治食滞，用活血法治瘀血等，都称为正治法，这些治法都能直接消除病因，一般疾病也都是用正治法来治疗。所以，正治法也是平时临床中最常用的治疗方法。

◎反治法：反治法和正治法相反，是采用与疾病性质相同的方法进行治疗的方法，临床有少数情况需要用反治法，如腹中虚胀属气虚者，本来有胀要消胀，但反而用补法进行治疗，使脾气充足，加强运行能力，腹胀就会自消。又如腹泻是由食滞引起的，应该用止泻的手法治疗，但反而用泻的方法去将食滞泻尽，病即自愈。

◎间接治法：间接治法是运用阴阳五行理论来作指导进行间接治疗的方法，如病人有阴虚阳亢之象，可用滋阴法，通过摩下腹法的滋阴作用来达到降火的目的，即滋阴潜阳。又如根据“虚则补其母，实则泻其子”的治法，当病者出现由于肺气虚而产生感冒、易出汗、怕冷等症状时，通过摩上腹法的治疗，就可达到补脾以治肺虚的目的，即培土生金，这些都属于间接法。

小儿推拿的注意事项

室内保持一定的温度，不可过凉或过热，空气要流通，环境要安静。在严寒季节，操作者双手不可过凉，以免使患儿产生恐惧，不能很好合作。

操作者要有责任感，对患儿态度要和蔼，指甲要剪修，每次

操作前要洗手，操作要认真。

患儿的姿势要坐卧舒适，力求自然，也可在患儿睡眠中进行。

推拿上肢时左右手皆可选用，但习惯上多选用左手（无男左女右之分）。

推拿手法要轻重适宜，用力均匀，刚柔相济。

每次推拿时间要根据病人的年龄、病的轻重、体质的强弱而定，一般婴幼儿大约在 10 ~ 15 分钟，大于 3 岁的幼儿约 15 ~ 20 分钟。病情重的推拿时间相对延长，发病短，病情轻的推拿时间稍短。总的说来，推拿的时间长些，其效果就会更好些。

推拿的速度应根据自己的熟练程度而定，一般越快效果越好，或掌握每分钟 100 ~ 200 次，尤其是治疗感冒、腹泻等疾病更需要快些。

推拿介质

推拿时为了减少对皮肤的摩擦，可借助某些辅助药物。如在推拿部位的皮肤上涂些水、酒、油类的液体或撒些粉末，这种液体或粉末统称为推拿介质（也叫推拿润滑剂）。

◎生姜汁：把生姜捣烂如泥，放于器皿中，蘸其汁使用。生姜汁临床较常用，尤其是小儿推拿用得更多，因为小儿皮肤柔嫩，姜汁柔滑，不易擦伤皮肤。同时姜汁有温热发散之功效，有助于驱散外邪，当姜汁不易保存时，可将生姜切碎倒入酒精，浸出姜液使用。

◎滑石粉：滑石粉有润滑作用，携带方便，易存放，是四季常用的润滑剂。

◎刨花水：将木质刨花浸泡于水中，取其浸出的汁作为介质。刨花水十分滑润，故可用于小儿推拿。

◎冷水：以井水为最好，尤其是小儿发热时用冷水推拿还能

起到退烧作用。

◎鸡蛋清：把鸡蛋打一个小洞，取其蛋清使用。另外，亦可把鸡蛋清与白面和成面团，操作者手执面团在小儿的胸、腹、背部做搓摩运动。这是治疗小儿感冒、食积等疾患时常用的方法。

◎白酒：适用于四肢、腰部、腹部穴位，有活血、散风祛寒和除湿的作用。此外对发热的病人还有降温作用，多用于治疗风湿性关节炎。

◎麻油：它是古代常用的润滑剂，我国民间多将它用于刮法或捻法推拿中。

◎鲜葱和姜等量，浸入95%的酒精内，2周后即可使用，常用于小儿外感。

◎肉桂油：将肉桂浸入麻油中，1个月后使用。肉桂芳香而温热，多用于虚寒病证的推拿中。

◎外用药酒：

◇生麻黄20克，桑枝9克，防风6克，乌梢蛇12克，全蝎3克，红花15克，生川乌9克，白芷6克，羌活3克，独活3克，白鲜皮6克，豨莶草9克，用上等白酒1.5升，浸泡2周后取其液应用，用于小儿麻痹和小儿肺炎等。

◇乳香3克，没药3克，血竭10克，樟脑6克，广木香1克，梅冰片0.6克，藏红花3克，生地10克，用上等白酒1升浸泡，取其液应用于急性慢性软组织或韧带损伤。

推拿作用机理

●中医理论对推拿作用机理的认识

◎推拿对心和小肠的作用

在脏腑功能中，心占有重要地位。《素问·灵兰秘典论》说：“心者，君主之官，神明出焉。”指出了心主精神、思维、

言语、情绪、活动。《素问·六节藏象论》说：“心主血脉，心之合脉也。”说明心有生血的功能，能把脾胃输送来的水谷精微，化赤而为血，来供养五脏六腑四肢百骸，那么心气心血充盛，则人健康无恙，反之病则产生。而小肠又与心相表里，功以受盛，化物分别清浊为特长。故能把精华归于五脏，水分归于膀胱。

腹部推拿手法的刺激，可直接促进胃肠蠕动，使脾胃功能增强，继而促进对水谷精微的吸收，增加生血之源，改善心脏本身的营养供给，使心脏保持旺盛的机能，同时由于心血的充盈，有效地避免了心血虚、心气虚等症候的发生，对心脏本身也起到了保养作用，对疾病的发生起到了预防效果。

由于腹部推拿的刺激，小肠的功能也在脾胃功能增强的基础上随之改善，消化吸收和分别清浊的作用得到促进，从而使充分地被吸入之精华归于五脏，使二便保持正常，进而有效地预防机能的失调和起到保健的效能。

在生理上，由于心与小肠的表里关系，在病理状态下出现症状就非常明显，临床上当心火上炎时，不仅出现口舌生疮，舌尖红痛，而且，小便同样出现黄赤，甚至血尿等症状。这时如运用清手厥阴心经穴位或腹部局部按摩，不仅可以清心泄火，而且也能消除因心火过重而移至小肠的热邪，改善热邪存留而带来的一系列症候群，使阴阳归于平衡。

◎推拿对肝胆的作用

《素问·灵兰秘典论》说：“肝者，将军之官，谋虑出焉。”就是指肝有调节情志的功能。《素问·五脏生成篇》说：“故人卧血归于肝，眼受血而能视，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能摄。”就是对肝藏血和调节血液功能的明确论述。胆属腑，与肝相表里，当出现病变时症状也相互牵连和相似。如

《素问·咳论》上说：“肝咳不已，胆受之，胆咳之状，咳呕胆汁。”说明在出现病变时，也是相互影响的。

推拿的各种手法，施用于相应的部位，能疏理肝气，解除瘀痛，保护肝脏的生理功能，如临床上出现肝气郁结，出现季肋胀痛的症状时，常称之为肝失疏泄或条达。运用推拿手法施治于胸腹季肋部位进行疏肝理气的治疗，而应用穴位如疏肝穴可以通过经气的传导起到疏通经络，清肝利胆的作用，使肝火上炎，胆汁上逆的病症得到治疗。

由于推拿利用腹部穴位或肢体、手部穴位均可增强脾胃的功能，从而保证了使充足的水谷精微输入于肝，对肝的生理功能是一种有力的支持。《素问·经脉别论篇》说：“食气入胃，散精于肝，淫气于筋”。所谓“散精”，就是把食物中最精华的东西输到肝脏，来营养全身的筋肉。所谓“淫气”，指的是盛满外溢之气，而推拿手法作用于腹部时，正是促进了这种吸收功能和散精功能，从而使肝脏获得丰富的营养供给，同时也间接地保证了筋脉、肌肉的丰满和结实。

◎推拿对脾胃的作用

《素问·经脉别论》说：“饮食入胃，游溢精气，上输入脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱。”这都说明了脾有运化水谷精微及输布津液的功能，脾又能统摄血液，主四肢肌肉。《灵枢·五味篇》说：“胃者，五脏六腑之海也，水谷入于胃，五脏六腑皆禀气于胃。”这充分说明了胃是五脏六腑营养供给的源泉，为后天之本，两者相互协作，才能完成给养的使命。所以推拿对脾胃治疗的作用，就在于增强脾胃吸收和运化功能，使生血益气之功能更强盛，进而使四肢肌肉及全身各组织得到充足的营养供给，以保证肌肉丰满结实和健壮，也保证水代谢的正常进行。

腹部的软组织推拿，可有效改变消化道的蠕动功能，使紊乱的肠道蠕动恢复正常规律，从而有益于消化和排泄的完成。在促进吸收功能改善和增强的同时，也改变了胃肠道自身营养供给，使胃气旺盛，使肠道津液分泌充足，有效地防止了因肠燥津枯产生的大便秘结和干燥，维持了新陈代谢的正常进行，同时，也阻止了腹中胀气和因粪便在肠腔积存过久而造成自身中毒现象的发生。

推拿在腹部的操作，因有效地增强了脾胃功能，从而对四肢肌肉和全身各组织提供了充足的营养供给，对全身整个机体的旺盛起到了很好的帮助。脾可统血，当脾虚而统摄失职时，出现皮下紫癜或鼻衄乏力，四肢萎软时，由于对脾胃经的推拿操作和腹部的直接推拿可恢复脾阳功能，因而有效地纠正了血液外溢的病象，使之恢复正常。脐腹部的推拿操作，可以引起腹腔深层的摩擦，使腹腔充血升温，对脾肾阳虚，脾虚不运的病人能起到温补脾肾之作用，对水谷的腐熟和水谷精微的运化起到了促进作用，从而改善了脾胃的病理状态，恢复正常的运行。

◎推拿对肺和大肠的作用

祖国医学认为，肺与大肠相表里，肺出现异常，必然影响大肠的功能，故肺居上焦，主气，主宣发肃降，通调水道，下属膀胱，肺主气又司呼吸，又为朝百脉之脏。如果肺气虚，则出现少气无力，久喘不愈，困乏无力，语言低微之症；或因虚而推动无力，则出现气滞血瘀之症；肺火则可热邪熏蒸，不仅失去宣发肃降功能，而且在上能导致心火上炎，在下移热大肠，出现肠燥便秘，腑气不通之症。肺又为娇脏，一旦外邪侵袭，易罹患疾病。然大肠为“传导之官，变化出焉”，如大肠实热，阻塞不通，则可上熏肺胃出现呼吸道病症，所以治疗时可以通过肺治疗大肠，又可通过大肠治疗肺。

推拿对肺与肠的作用，主要是通过“气机”的变化而达到的，因气为肺之所主，而推拿又能促进益气的一系列功能，使该系统机能旺盛，完成肺对周身其他组织的调节，增强血液循环的功能和皮毛的抗邪能力。

由于推拿有促进脾胃功能的作用，从而对脾胃所吸收的谷气与肺吸入的清气组合成真气的过程提供了支持。也就间接地使脏腑之气、卫气得到充实，使全身各部分的生理功能不断增强。《素问·经脉别论篇》说：“引入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水精四布，五经并行，合于四时五脏阴阳，揆度以为常也。”通过推拿手法的操作，促进脾气散精归肺的一系列功能，因而，对肺脏本身增强了营养供给，促进了肺的新陈代谢，使肺的功能保持旺盛。同时，也与推拿对四肢经络的疏通和水道之畅通有直接促进作用，故对通调水道和水精四布的功能，也是一种有力的支持。而这些功能旺盛之后，相对又增强了脾肺功能，也有效地把含有营养成分物质，分别输布五脏六腑，散布于全身，对全身各组织机能，又是一个良好的补益。

◎推拿对肾与膀胱的作用

推拿对全身机能和肾所主管部位的保健，也可起到很大的帮助。其机理主要是通过后天补先天而达到的。由于肾所藏本身之精，是人体赖以生长发育的基础，但人体活动本身，又在不断地消耗着这种物质基础，这就构成生理上不断消耗而又不断补充的新陈代谢过程。在这种过程中，如果消耗过快，会相应发生一些病变，如排尿困难、大便溏泻、耳鸣耳聋、头昏脑胀等。推拿由于促进“后天补先天”的转归，故可迅速对精气之消耗，给予有效的补偿。因而，对排除上述一系列肾虚症状和促进肾所主管部位的功能是非常有效的。

推拿对肾藏精的补充，可起到很大的帮助。其机理是由于肾所藏五脏六腑之精气，主要来源于水谷，是通过脾的转输和经气的推动，而将精微送入肾脏封藏的。推拿在腹部直接作用，能有效地促进消化吸收和转输功能，保证了更多的水谷精微物质充实到肾脏，从而对肾脏本身的补养和对肾精消耗后之填充，起到良好的补给效能。

推拿对肾中命门火的功能也有很好的调补温煦作用。其机理是通过其腹部温补手法的作用，调理后天脾胃之本，而补先天肾阳的不足。故临床对肾阳不足命门火衰者通过脐腹部加之二马、三关、外劳宫穴位的推拿则能使肾阳不足而引起泄泻无度、久治不愈的患儿病愈。

◎推拿对经络的作用

经络的功能主要依靠于经气，而经气的物质源泉则必须依赖于谷气。由于推拿能使脾胃功能旺盛，从而间接地使体内各组织得到充足的营养物质，充实了体内的精津气血，也补益了经气。当经气充盈时，气血运行力增强，活跃了新陈代谢，间接增强了机体的抵抗力。

《内经·气血形成篇》说：“形数惊恐，经络不通，病生于不仁，治之以按摩醪药。”《素问》亦说：“按摩可使筋节舒畅，血脉流通，该按其经络，则郁闭之气可通，摩其蕴聚，则瘀结之肿可散也。”可见推拿有疏通经络的作用，已早见于文献。临床实践证实，当经络阻塞不通而出现麻木不仁等症候时，运用推拿治疗，可迅速解除瘀塞和障碍，使气血流通，经络恢复正常运行。

由于推拿在增进经气营养的基础上，促进了经络传导、运送功能，因而，也有效地发挥了推拿手法施行于体表，而作用渗透于内的治疗作用。这种治疗作用的传导，是通过经络达到的。

《素问·举痛论篇》上说：“寒气客于背俞之脉沉，脉沉则血虚，血虚则痛，其俞络于心，故相引而痛，按之则热气至，热气至则痛止矣。”说明推拿手法虽在体表操作，但可借经气的传导功能，对内脏疾病起到调节和治疗作用。

总之，推拿对经络的作用，主要是通过手法刺激，在促进其功能的基础上，遇有瘀塞或失调时，可排除其障碍，保证经络运行畅通，以达到调整机体、协调阴阳、治愈疾病的目的。

●现代医学对推拿作用机理的认识

◎推拿对血液循环的作用

由于推拿手法在身体外部的压力和推动作用，促进了血液循环，使血循环旺盛。同时，推拿手法的摩擦而产生的“热胀冷缩”的物理原理，可使血管扩张，减少循环中的阻力，保证血液循环的畅通，甚而减轻心脏的负担。同时，由于推拿手法的摩擦，也可大量消化血管壁上的脂类物质和毒素，使血管恢复弹性，管道通畅，促进和改善血液循环，对心脏起到了一定的保护作用。

推拿对血液成分的影响。在推拿作用下，血液中的红细胞和白细胞，血小板的数目均有所增加，尤其是贫血推拿后，在短时间内显著增加，大约3小时后又逐渐下降，在国外有些学者通过腹部推拿试验，也证实了推拿后红、白细胞有不同程度上升，这是推拿对间质细胞的刺激所引起的。在国内有些专家也做过一些试验，推拿不仅升高红细胞，还增加了白细胞的吞噬能力，故对增加免疫力有一定的帮助。

推拿可促进血管扩张，尤其是手法直接作用于皮肤表面上，可使血管明显扩张，故能改善局部营养的供给，改善末梢循环，预防肌肉萎缩。腹部推拿后，使高血压病人不仅改善症状而且降低血压，一般人收缩压下降5~15毫米汞柱，舒张压下降5~10

毫米汞柱。下肢推拿对血压下降时间维持的更长，效果更明显。

◎推拿对淋巴的作用

由于推拿在体表的压力和有节律的移动摩擦，可对淋巴管产生压迫作用，促进淋巴的流动加速。有些学者通过动物实验观察淋巴流动现象，在狗身上做过实验，推拿后比推拿前的淋巴流速提高7倍左右。由于推拿能促进淋巴的功能，所以，也直接促进了肌肉的内吸收及加强消化腺的血液供给。同时，由于促进了淋巴的功能，所以在回流中，对携走组织内的废物和毒素之功能也随之加快，尤其是当组织间隙中有水液积留而出现水肿时，这种作用就表现得相当明显。

淋巴液来自于组织间隙中的组织液，是组织细胞将养料和氧气与废物交换的媒介。由于推拿能促进这种液体的循环，所以，也有力地促进了这一系列新陈代谢的功能，从而提高人体的抵抗能力，保证全身各组织功能的正常运行。

◎推拿对消化系统的作用

由于推拿手法的刺激，尤其是腹部直接推拿，可使支配腹内各器官的神经兴奋，从而促进了胃肠等消化器官机能的旺盛，使胃肠等消化器官蠕动加强。临床上，当患儿出现消化机能降低时，采用较强烈的手法，通过神经的反射机能使胃、肠、肝等脏器的分泌活跃起来，使机能恢复。对食积或便秘、腹泻的效果最明显。

由于推拿手法的下压作用，可产生物理的压力和排挤力，这种力量通过腹壁渗透至胃肠后，可促进食物渣滓的下行移动和排泄，以预防和排除便秘。同时，也由于推按手法的按压，使整个腹腔压力增高，因而对肠道胀气的排出甚为有利。

腹部推拿，可通过指力渗透摩擦作用，增进胃肠壁微血管及淋巴的功能。同时，使这些消化器官的分泌腺分泌较多的消化

液，以加强对食物的消化分解和已消化食物的吸收。

◎推拿对呼吸系统的作用

推拿对呼吸系统的作用，是在促进人体的新陈代谢基础上，随着新陈代谢的增强，而对呼吸机能发生良好的影响，使气机的新陈代谢增强。临床上特别是运用推拿手法在胸部操作的节律性压迫作用或摩擦作用，可使呼吸动度加深，从而对气体交换和对血液及全身的氧气供给提供了支持。对腹部推拿时，则是通过摩擦两肋起到疏通胸膈，排除膈下瘀血，而起到良好的缓解症状的作用。

推拿对代谢的作用。在临床推拿中许多患儿推拿手指穴位心、小肠时，尿量明显增加，使浮肿症状减轻，浮肿消失。按压腹部穴位可使尿量明显增加。这种作用的产生，主要是推拿增强了肾脏机能，加速了利尿过程，同时也对腹腔施加了压力，而使排泄加快。

推拿手法的刺激可促进体内的氧化作用和吸收机能，也可促进血液和淋巴的流通。因此，体内的碳酸和尿酸等产物，迅速地被输送到肺和肾脏等器官而排出体外，促进了体内的新陈代谢。

推拿对皮肤表面的摩擦可使末梢循环旺盛，因而促进汗腺的畅通机能，对汗腺的分泌有很大影响和帮助，从而使体内废物被汗腺送到体外，促进这一部分的代谢。

◎推拿对神经系统的调节作用

推拿的作用，首先与神经系统的各个环节有关。临床中运用推拿手法刺激皮肤外感受器或肌肉本身的感受器，通过神经的传导作用，传向中枢神经系统，在机体中发生各种各样的应答性反应。这种作用的产生，是通过神经本身的反射、操作手法的刺激及肌肉的运动三者结合而获得的。临床上，根据轻重不同的手法，而起到的作用亦不同。如轻手法，有镇静安神和减少神经刺

激的效应，重手法则有兴奋神经与改善神经所支配的肌肉、血管、分泌腺的机能。

推拿借肌纤维的收缩，可使神经得到松弛，从而减轻或解除抽搐和挛缩症状，使神经保持镇静，并得到休息。所以推拿对脑神经衰弱有很大帮助。

推拿刺激皮肤时，可使皮肤中形成类组织胺样的物质，这种物质有对神经发生刺激的作用，使神经产生兴奋。当这种物质随血液循环时，对全身各神经发生连锁性刺激，使各种神经发生兴奋。

推拿手法

单 式 法

推拿常用手法有：推法、拿法、按法、摩法、捏法、揉法、运法等。推法可疏泄积滞，宣化壅塞；拿法可泄热开窍，增益精神；按法可通气缓痛，行气补血；摩法可安神镇痛，散滞解郁；捏法可通经活血，开窍醒神；揉法可活血散结，软坚止痛；搓法可疏肝解郁，调和气血；擦法可疏通腠理，滑利关节；引法可通达经络，开利关节；点法可消肿除满，清醒头目。当然临床实际运用时并非用一种手法，大多采用几种手法同时应用，才能起到治疗目的。

在推拿的手法上，初学者以掌握“轻、柔、稳”三个字为原则，也就是“轻”到不加重局部损伤，或不引起小儿痛苦为原则；“柔”到不加重病人痛苦，但需要达到有效的治疗范围；“稳”到耐心细致，不可粗暴。一般地说，手法过重，往往带来不应有的损伤，手法过轻则达不到应有的疗效。如推拿歌诀曰：“推拿者，一旦临证，知其体相，识其部位，机触于外，巧生于

内，手随心转，法从手出，手法也，求其重而不滞，轻而不浮。刚中有柔，柔中有刚，刚柔相济，稳准熟练。”

推拿疗法之所以能使受伤的组织恢复生理状态，使脏腑机能失调得到纠正，关键在于手法要根据不同的对象，辨证施治。由于伤有轻重，病有缓急，证有虚实，治疗的效果，病愈的时间均有差异，故治疗前先明其病机，察其虚实，确定诊断，再行施术，则可收到预期的临床疗效。

★ 推法

推法是用手向前后左右上下推动，以起到疏泄积滞，宣化壅滞的作用。推法一般分为直推法、分推法、合推法、旋推法。

1. 直推法

直推法又分食中指直推法，拇指直推法，掌推法。

其中以食中指直推法用处最广。其方法是将食中指伸直，着力于皮肤表面或穴位上，呈直线向前推动（图1）。

拇指直推法是一指禅直推法的一种，用拇指的指腹面或桡侧面，着力于皮肤向前推动（图2）。

掌推法是以两手掌根部（拇指侧）相对，着力于皮肤表面或穴位处，由中点向两侧分推，临床常用于腰背部（图3）。

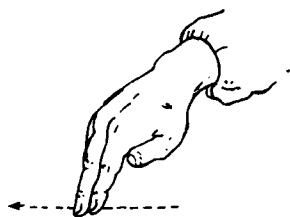


图1 食中指直推法



图2 拇指直推法



图3 掌推法

2. 分推法

拇指分推：以两手拇指末节掌侧对置，自中点向左右两侧推动，临床常用于背腰部、胸部、头部及手腕部（图4）。

3. 合推法

以两手拇指指腹面或桡侧面由外向内推，临床常用于手腕、指节、大椎及肩部（图5）。

4. 旋推法

用拇指、食中指边锋或指腹面压住穴位，做弧形或环形推动，用于手心及脐腰部（图6）。

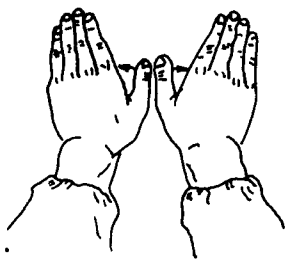


图4 分推法

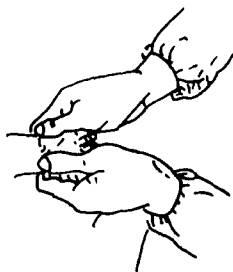


图5 合推法

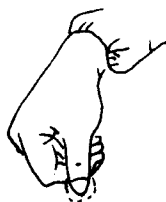


图6 旋推法

〔施治部位〕主要用于胸腹、四肢、头部等点型穴位及患部。其手法主要用于长线形穴位及环形圆形穴位。

〔治疗作用〕推法总的治疗原则是：“疏通经络，祛瘀止痛，调和营卫，退热散寒，健脾和胃，消滞散结”。但由于施治部位较广泛，所以治疗作用随治疗部位不同和推动速度的不同而有差别。如在操作速度上，急推为泄，重推为泄，缓推为补，轻推为补；在操作部位上，用于头部则退热止痛，用于背部则是退热散寒，疏经通络，祛瘀止痛。

〔操作技巧〕

◎在操作时力量的大小必须根据病人的体质情况，由轻到

重，逐渐加压，着力扎实，使指力在被推的路线上透过浅表渗入到肌肉深层。同时，随着人体各部位肌肉厚薄的不同生理特点，分别着力，一般肌肉肥厚部位用力略重，肌肉瘦薄部位用力较轻。

◎推法的速度，视病情虚实，病情轻重而定。一般慢性病、体质较差患儿手法要轻，速度应慢；急性病、外感病、体质健壮者，应速度快，手法适当加重，但不要损伤皮肤。

◎推法操作时，无论是拇指或食指、中指、无名指，均以指腹面平放于穴位表面，如果需要用拇指边锋也要平放，不可用指尖操作。

★拿法

拿法是以一手或两手之拇指及其余四指分开，对称相合用力，以拿定患儿肌肉或关节、肌腱穴位。根据患儿病情需要和体质情况，决定用力的大小和拿提的方向，以便起到泄热开窍，增益精神的作用。拿法一般分为固定拿法、拿提法、拿拨法。

1. 固定拿法

以一手拿定患儿或双手握定肢体两端，再逐渐进行牵拉。临床常用于四肢部位。

2. 拿提法

是用拇、食指或拇、中指的指腹面相对用力拿住某一个部位或穴位向上提，临床常用于腰背部及四肢（图7、图8）。

3. 拿拨法

用拇指或四指拿定后，再将指端嵌入肌肉和肌腱缝中，向内或向外侧拨动，临床常用于肩胛及四肢部位（图9）。

〔施治部位〕肘腕部、肩部、颈部、手部。主要用食指中指和拇指相对用力拿住穴位或部位向上或向左右提拿的一种方法。

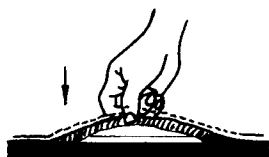


图7 拿提法1



图8 拿提法2



图9 拿拨法

〔治疗作用〕拿法总的治疗作用是：顺气活血、调整肠胃、软坚消瘀、分离粘连、通经活络、消除酸痛、缓和痉挛等。

〔操作技巧〕操作时，用力大小要随时根据被拿部位的肌肉厚薄程度而定，不可用蛮力捏拿。同时，手法要灵活，边捏边移动，在将拿定之部位上提时，提拿的角度以被拿部位的有限生理伸展长度为限。不可强拉硬提，拇指与其他四指向中捏拿时，食指、中指、无名指、小指不是用指甲而是用指腹面捏拿，以避免被拿部位的皮肤被指甲刺伤。

★揉法

揉法是指用手指、掌或拳在人体软组织或穴位的表面作用，形成螺旋形移动。揉法一般分为指揉法（包括拇指揉法、中指或二指揉法、三指并揉法）、掌揉法（包括掌心揉、掌根揉）。

1. 指揉法

（1）拇指揉法：用拇指的指腹面或桡侧边锋压住某一个部位或穴位上做顺时针或逆时针揉动为拇指揉法（图10）。

（2）中指或二指揉法：是用食指或食中指并拢的指腹面压住某一个部位或穴位上顺时针或逆时针揉动为一指禅或二指禅揉法（图11、图12）。



图 10 拇指揉法

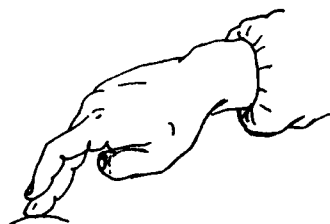


图 11 中指揉法

(3) 三指并揉法：用三指指腹面压住某部位或穴位进行逆或顺时针揉动为三指并揉法（图 13）。



图 12 二指揉法



图 13 三指并揉法

2. 掌揉法

(1) 掌心揉：用手掌心压住某一个部位或穴位做轻柔的旋转揉动，常用于四肢及腹部。

(2) 掌根揉：用掌根部在人体皮肤表面着力做旋转揉动，常用于肩与背腰部（图 14）。



图 14 掌根揉法

〔施治部位〕背部、胸腹、四肢均可使用，多用于点形或面形穴位。

〔治疗作用〕活血化瘀，软坚散结，理气止痛。

〔操作技巧〕

◎操作时必须使掌与被揉部位贴紧，然后，在腕关节的充分摆动中，带动被揉部位皮肤回旋移动，使皮下深层组织充分滑动摩擦，不可使手在病者的皮肤上来回滑动摩擦。

◎用力的轻重必须随着部位的不同而灵活运用，一般在肌肉中厚部位，用力要重，尽量透过皮下组织使力量渗透到肌肉深层，在肌肉较薄的部位，用力要轻，能达到皮下组织回旋滑动即可。

◎揉法的速度一般掌握在每分钟 120 ~ 150 次左右为好，体质较差、久病可适当放慢速度，如身体健壮、新病可适当增加速度至 200 次/分。

★运法

用拇指边锋或食中指指腹面在选定的部位或穴位上做弧形或环形旋转，如运土入水，运八卦等（图 15）。

〔施治部位〕主要用于手掌心或其他部位的环形、圆形穴位，以拇指或食中指操作。

〔治疗作用〕舒畅气机，宽胸利肺，运脾止泻，增液通便。常用于气机不畅之胸闷或便秘、腹泻患者，根据手法的变化，治疗作用不同，疗效各异。

〔操作技巧〕用运法手指一定紧贴皮肤，并且有一定的力度，不可松紧不一，轻重手法悬殊，且不能出现抖动的感觉。



图 15 运法

★ 捣法

捣法有两种方法，第一种是用中指指端叩击穴位或某一部位，第二种是将中指屈曲的第一关节的尺侧棱角叩击穴位或某部位，多用于点形穴位或关节部位、头部病变等（图 16、图 17）。



图 16 捣法 1



图 17 捣法 2

〔施治部位〕 用于头部、手部、背部的点形穴位。

〔治疗作用〕 疏通经络，镇静安神，熄风定惊，活血行瘀。

〔操作技巧〕 操作者首先应练习指力，叩击时要力量均匀而着实，叩击部位要准确，指甲要经常修剪，不可损伤皮肤，叩击时病人感觉有酸胀感或有气行样感觉为好。

★ 掐法

以拇指指甲或其他指甲掐穴，在强烈刺激时应用，如掐精灵、威灵、人中、承浆、合谷等（图 18）。

〔施治部位〕 主要用于手指部、头部、肩部等部位，多用于急救。

〔治疗作用〕 开窍醒神，镇惊熄风。治疗高热惊厥，夜寐不安，四肢抽搐，神昏不省人事，暑痧等症。



图 18 掐法

〔操作技巧〕 用拇指指甲掐住患处或穴位，但经常与揉法合

而用之，如小天心用来清热镇惊时，单用掐法刺激太强，单用揉法则力量太弱，合而用之最为合适。

★捏法

捏法又称捏脊法，可分两种手法。

用拇指桡侧缘顶住皮肤，食中指前按，拇食中三指指端夹住皮肤并同时用力提拿，双手交替移动向前（图19），临床常用于腰背部。

食指屈曲，用食指中节桡侧缘顶住皮肤，拇指端前按，拇食指捏住皮肤并用力提拿，双手交替移动向前（图20）。

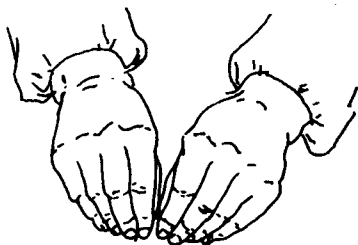


图19 捏法1

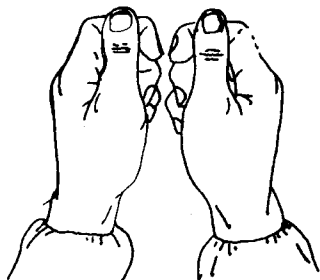


图20 捏法2

〔施治部位〕多用于背部捏脊，或颈部天突部位。

〔治疗作用〕捏法总的治疗作用是“舒筋活络，消除挛缩，促进疲劳肌肉的恢复。”在下肢应用中，除上述作用外，还有减轻腹部胀气、调整胃肠功能的作用，捏法用于指、脚趾关节时，有消肿止痛、增加活动范围的作用。

〔操作技巧〕捏法操作时，拇指和其他四个手指摆放呈相对向中方向，放在被捏肢体或部位的两侧。捏揉时不可过于生板机械，必须在捏动时各指之间相应地进行辗转揉动，既保持向中的压力，又保持一定的柔和性，使手法活而不僵。

捏脊时，先用右手中指指腹面压住大椎穴，食指和无名指指腹面压住旁开1.5寸的两行俞穴（膀胱经），向下擦至尾骨，连擦3遍，然后从尾骨遵前法向上捏，捏至大椎穴，第四遍时，边捏边向左右上方斜提一下，连续捏提到肩胛骨下的膏肓穴为止，连提6遍，然后从命门到肾俞分推10~20遍，最后从上往下沿脊柱两旁下压一遍结束（图21、图22）。

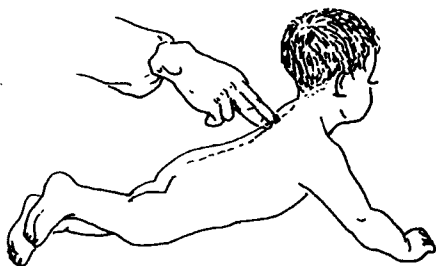


图21 捏脊法1

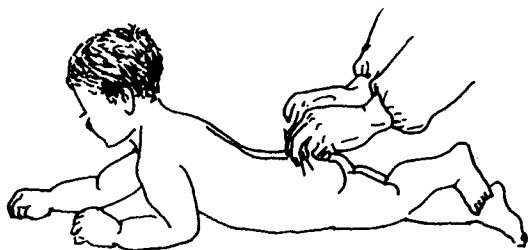


图22 捏脊法2

★摩法

以食、中、无名指指面或掌心在穴位或部位上抚摸并做环旋活动。

摩法有顺摩为补，逆摩为泻；掌摩为补，指摩为泻；缓摩为补，急摩为泻等说法，前人在用摩法时常配以药膏，并又称之为

膏摩。摩法为小儿推拿常用手法之一。摩法较推法用力为轻，而较运法则重（图 23、图 24）。



图 23 指摩法

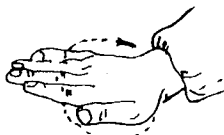


图 24 掌摩法

〔施治部位〕摩法对腹部进行治疗时，往往成为主要手法。摩法本身的节律性和轻柔舒适的特点，很适合消化系统疾病的治疗，所以常施于腹部软组织。

〔治疗作用〕摩法总的治疗作用是：“理气和中，健脾调胃，消积散郁，安神活血，顺气散瘀，生热散寒”。摩法所产生的治疗作用可由于施用部位的不同和操作时力量、速度的区别，产生的作用也随之有所差异。一般讲：急摩为泻，缓摩为补；重摩为泻，轻摩为补。在操作的部位上，用于上腹多是健脾调胃，理气和中，消胀散积；用于脐部多是安神，顺气，活血；用于腹部消胀散郁，解痉止痛，化食消积等。

〔操作技巧〕要根据病人的具体情况而定，尤其是腹部情况。用力时要先轻后重再轻，指部的压力要着实，不可虚浮，必须使指力在被摩的部位上透过皮肤浅表进入肌肉深层，否则不产生效果。

操作时的速度不宜太快，必须保持一定的节律性。太急太快时，柔和性就会降低，节律性就不会持久，指腹与被摩部位皮肤的擦力增大，引起病者腹部不适，但也不能太慢，太慢会失去连接，不能保持节律性。一般保持每分钟动作 70 次左右较为合适。

操作的动作必须要稳，不可用蛮力，动作要保持轻柔温和，使病人很舒适。同时，压按部位要准确，使“病形”不至遗漏，摸到“病形”时动作要加重，使“病形”尽快消散，三者结合灵活运用。

★ 擦法

用拇指外侧缘或食中指、无名指、小指掌面在体表来回擦抹，或用手掌大鱼际、小鱼际等部位来回擦抹。擦法为推拿常用手法之一。用指、掌、鱼际部擦之，分别称为指擦法、掌擦法（图 25）、鱼际擦法（图 26）。

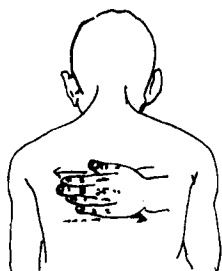


图 25 掌擦法



图 26 鱼际擦法

〔施治部位〕擦法常施用于头面部、颈部、胸背部，是治疗头颈部、胸腹部一些症状的特用手法，四肢很少使用。

〔治疗作用〕擦法总的治疗作用是：“疏松皮肉，解郁散闷，缓和强手法的刺激，生热散寒止痛”。擦法由于是轻而有节律的摩擦，因此，操作后往往产生轻松、微热、舒服的感觉，使整个头部都感到舒适、清楚，颈部转动灵活、轻快，在配合其他手法

治疗时，可消除因强手法刺激而引起的暂时性不适。

〔操作技巧〕操作时，要保持擦法的稳定力量，不可用力过大，以病人感到舒适为限，擦动时要保持节律性，不可时快时慢，其频率一般以每分钟 180 次左右为宜。

★按法

用拇指指端用力在穴位上压抑，亦可用大拇指背屈指间关节突起处（图 27），或掌心或掌根或肘尖作按法。故又分别称为指按法、掌按法、肘压法。常在做按法的时候配合揉动动作，以加强效应。小儿推拿常用指按和掌按。按法中指按又称点法或称为指针法，取以指代针之意。

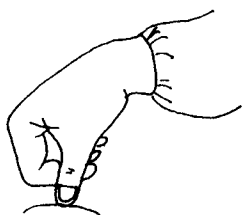


图 27 指按法

〔施治部位〕多指按法常用部位为腹部，其次是胸部、肩部和下肢；单指按法常用于局部和某穴位。由于多指按法的压面较大，很适用于腹部治疗，因此在腹部慢性疾病的治疗中，往往是配合摩法进行治疗的主要手法之一。单指是用拇指平压于穴位或部位，由轻到重。

〔治疗作用〕多指按法所产生的总治疗作用是：“顺气活血，疏经通络，开通郁闭，消胀软坚”。单指由于施用部位不同，按压力量不同，产生的作用也有所差异。如在力量上，重按为泻，轻按为补。在操作部位上，用于上部多是消气散结，疏散胸胁胀满；用于下肢多是通气消胀，排除燥便；用于胸部则是止咳消闷。

〔操作技巧〕按压时，食、中、无名指、小指的长短不同。因此，操作时，各手指的中节、末节必须下屈取齐，保持四个手指的平衡下压，方能舒适而得力。

用力时必须保持先轻、后重、再轻的三个步骤。根据病人具体情况和病人体质强弱的区别，先轻轻用力按压，然后逐渐加重，在结束时，不要使手突然离开按压部位，应逐渐放松移开。

★扯法

用拇、食指指端或食、中指中节夹住皮肤，用力做一拉一放动作，不同于拧法。常扯至局部红紫为度（图28）。

〔施治部位〕扯法常用于两耳，为耳部治疗的特用手法，是治疗头部症状的配合手法之一。

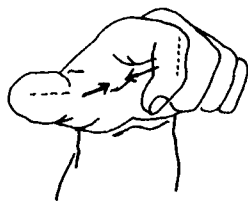


图28 扯法

〔治疗作用〕扯法总的治疗作用是：

“解热止痛，消除头部昏胀症状”。在耳部应用时，配合其他头部治疗手法，多有消除头部昏胀及太阳穴部位胀痛的作用。配合牙痛治疗手法，多有消除牙痛或两腮肿痛的作用。

〔操作技巧〕操作时，拇指和食指不宜夹得太紧，必须使拇、食指在扯动时边扯边摩擦，手法要灵活，不可死板，扯动和摩擦的次数以耳部皮肤充血为度，一般10~15次为宜。

★搓法

双手掌夹住或置于一定部位，双手交替或同时用力擦揉。在搓手指时似同捻法，若用于手背部或胁肋时又形似自前向后的摩法（图29）。

〔施治部位〕多用于四肢肌肉及关节部位或颈部、腰背部，多与揉法和擦法配合。



图29 搓法

〔治疗作用〕搓法的治疗作用有两个，一是通过搓动某部位的肌肉皮肤，可促进局部血液循环，起到疏筋活络的作用。二是局部搓法，可起到活血消肿，温中散寒，行瘀止痛的作用。

〔操作技巧〕搓时操作者要把自己的手搓热，然后选好部位或穴位，先由轻到重搓动，不可过快过重，以患儿耐受为度。搓后注意不要马上用凉水，且注意避免风寒侵袭。

★刮法

用拇指外侧缘或食、中指指面或用器皿的光滑边缘（如汤匙等），由此往彼推动，形似直推法，但较直推法用力较重。在用刮法时，可蘸汤水、油类，以润滑皮肤，避免破皮。常刮至皮下充血，见皮肤红紫色（图30、图31）。



图30 刮法1



图31 刮法2

〔施治部位〕刮法多用于背部、脊柱、四肢部位。根据所刮部位不同而作用亦不同，如刮脊背法主要治疗外感发热，畏寒恶风等，刮四肢则治疗肢体疼痛、僵硬、麻木等。

〔治疗作用〕刮法总的治疗作用是：发汗解表，散寒祛邪，疏通经络，活血化瘀，消肿止痛。根据施治部位不同所起作用有异，如刮后背脊柱则发汗解表，疏散表邪。刮胸部则宽胸理气，

宣肺止咳。刮四肢则疏利血脉，通经活络。

〔操作技巧〕用刮痧板刮后背、前胸、腿部等部位或用右手拇指指甲刮四缝穴。

★ 揉法

用手背小指侧部位附着于穴（部）位上，使腕关节做屈伸外旋的连续滚动，称为“揉法”（图 32 ~ 图 34）。



图 32 揉法 1



图 33 揉法 2



图 34 揉法 3

〔施治部位〕揉法是推拿手法中常用手法之一，治疗范围比较广泛，如四肢、腰背部的肌肉疼痛，风湿性关节炎，肩关节炎，颈部疾患等，均有较好疗效。

〔治疗作用〕揉法总的治疗作用是：“疏筋活络，解痉止痛，温阳通脉，促进血液循环，缓解痉挛，消除功能障碍”。根据施治部位的不同所起作用有异，如腰部揉法能健腰补肾，温肾壮阳，解痉止痛，舒利关节。用于颈部则活血通络止痛，治疗颈椎增生、颈动脉炎等。

〔操作技巧〕揉法操作时，要使小指尺侧面着实于穴位和部位，从左到右或从下到上，一步接一步做，力量均匀不可过重，亦不可过轻，速度掌握在每分钟 100 次左右，过快不易着实，过慢达不到连接作用，以病人感到耐受舒适为度。

★抖法

抖法是操作者用双手握住患儿的患侧肢体，微微用力向上推动，使被抖的肢体放松，然后进行波浪式抖动的一种方法。

〔施治部位〕其法主要用于上肢，用于下肢时较少。由于抖法是一种有节律性而又轻快的被动性活动手法，因此，在对四肢（尤其是上肢）关节功能性障碍性疾病治疗时，是主要的配合治疗手法之一。

〔治疗作用〕抖法总的治疗作用是：“滑利关节，舒松肌肉，解除挛缩，减轻病痛”。

〔操作技巧〕抖法操作时注意让病人将患侧肢体放松，肌肉尽量保持松弛，然后进行有节律的快速抖动，使被抖动的肢体不仅没有被拉扯疼痛的感觉，相反产生轻松舒适的轻快感。抖动的时速每分钟大约在 200 ~ 300 次，抖动每日次数根据病情而定。

★提法

提法是操作者双手平伸张开，用两手掌心相对，抱于患儿头部的两侧耳部，用力向中挤按并轻轻向上提伸的一种手法。

〔施治部位〕本法主要施治于头部，为头部和颈部一些疾病的特用治疗手法。

〔治疗作用〕提法总的治疗作用是：“疏利关节，消除疼痛，通经活络，活血化瘀，解除挛缩”。为落枕和颈椎病常用手法，对解除颈部的血管压迫和消除头晕耳鸣有很好的治疗作用。

〔操作技巧〕提法在提伸头部和颈部时，两手掌心要紧贴病人耳朵和两腮部，在向上提拔时，带动病人头部和颈部，使之轻轻旋转活动，不可用蛮力硬拔直提。提伸的限度要视病情而定，且有一定的极限，用力要和缓，先轻后重。

★折法

折法是操作者用双手捏住患儿某个关节的两端或一端部位，顺着关节本身的活动范围，进行反复折曲伸直操作的一种手法。

〔施治部位〕常用于四肢关节，以膝关节、踝关节、肘关节应用较多，是治疗关节疼痛的常用手法。

〔治疗作用〕折法总的治疗作用是：“疏利关节，分离粘连，消除关节障碍，增强肌肉弹力”。

〔操作技巧〕操作时要用巧力，轻轻地顺着关节的生理活动范围和方向慢慢折动，不可猛用蛮力。折伸的限度必须随关节生理限度和功能障碍的程度而定，逐渐加大范围和限度，而且要通过手掌感觉关节部位的反应，如颤动、关节响声，并根据响声等反应的现象增减折伸次数或范围。

★摇法

摇法是指操作者用双手或单手握住患儿的一侧肢体关节，向着顺时针方向或逆时针方向进行不同范围摇转的方法，即是摇法。

〔施治部位〕摇法施治部位比较广泛，可用于全身各个关节，如下肢髋关节、膝关节、踝关节、上肢肩关节、肘关节、腕关节、指关节。由于摇法是属于被动性运动的一种手法，故常治疗关节病。

〔治疗作用〕摇法总的治疗作用是：“顺气活血，舒经活络，活动关节，消除功能障碍”。但由于施用部位不同而起到的作用也有所区别，如用于肩关节可活动关节，减轻肩关节疼痛，并起宽胸理气作用。用于髋关节和腰骶关节时，可消除腰骶关节疼痛。

〔操作技巧〕使用此法时要根据患儿不同的部位和范围大小，进行不同的摇动，但不可超过正常生理功能和最大限度活动范围，以防损伤。并且根据关节障碍的程度，逐渐加大摇动范围，使操作者的主动性运动和患儿的被动性运动结合起来。摇动的速度不宜太快，要保持平稳，力量均匀，摇动时还要不断询问患儿的感受情况，以减少摇动操作时的阻力。小关节部位可适当加快速度。

★拉法

拉法又叫牵引法，是操作者双手握住患儿的某个肢体末端，顺肢体方向，向着远端进行巧力牵拉的一种方法。

〔施治部位〕拉法的施治部位常用于上肢关节和下肢关节，以下肢最常用。运用中配合摇法进行操作，是治疗四肢关节疾患的常用手法之一。

〔治疗作用〕拉法总的治疗作用是“疏利关节，分离粘连，消除挛缩，顺气活血，止痛消肿”。由于施用部位不同，作用也有区别，如用于下肢不仅活利关节，还可调节腹中燥屎和减轻腹部胀气，减轻腰部疼痛症状；用于上肢在活利关节的同时，还对解除胸胁胀满和分离一些胸部手术后粘连有较好的治疗作用。

〔操作技巧〕牵拉时动作要稳，双手动作协调有力。拉时要用巧力，由轻到重，不可急拉强拉，要根据病人情况随时调节，灵活掌握，以免由于操作不当，造成脱臼现象。牵拉时必须保持直线方向，不可偏斜，否则容易引起关节一侧软组织损伤。牵拉和回复要有节律，动作要协调，当牵拉至适当长度后轻轻放松双手，借关节自身韧带和肌肉的弹力使其自动复回，然后再复拉第二次、第三次。

复式法

★二龙戏珠

操作者以右手拿患儿中指、无名指端，左手按捏阴穴、阳穴，往上按捏及曲池，寒症重按阳穴，热症重按阴穴，最后左手拿捏阴、阳穴处，右手拿患儿食、无名指摇动（图 35）。

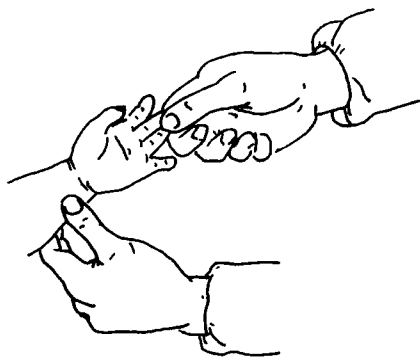


图 35 二龙戏珠

〔施治部位〕 前臂。

〔主要作用〕 调和气血，镇惊止抽。

〔操作技巧〕 双手配合，各司其职协调作用，手法要轻柔和缓。

〔适应证〕 用于治疗四肢抽搐，两目斜视等。

★凤凰展翅

操作者双手握患儿腕部，二大指分别按捏阴、阳穴之后，左手拿肘处，右手握患儿腕部，向下摆动几次后再向外向上摇动

(图 36)。

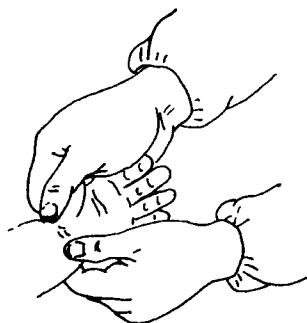


图 36 凤凰展翅

〔施治部位〕肘关节前部，腕部。

〔主要作用〕除痰醒神，调和气血。

〔操作技巧〕按揉结合，操作细致，手法平缓，快慢一致。

〔适应证〕用于治疗黄肿，痰鸣，昏厥等。

★乌龙摆尾

操作者左手拿住患儿肘部，右手拿患儿小指摇动，摇 20~30 次（图 37）。

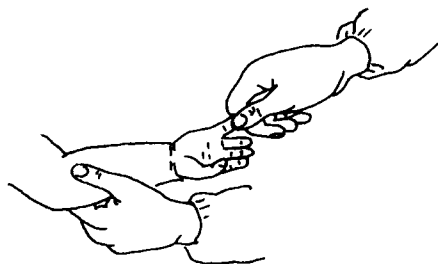


图 37 乌龙摆尾

〔施治部位〕 手及肘关节。

〔主要作用〕 通腑泄肠，利尿清心。

〔操作技巧〕 操作时力量适度，均匀摆动，柔缓操作，不可过急、过快、过轻、过重，以防损伤关节。

〔适应证〕 用于治疗大肠实热或邪热下行大肠引起的便秘及心火下移，小肠湿热引起口舌生疮、尿急、尿痛等。

★双龙摆尾

操作者左手托患儿肘部，右手拿患儿食、小指摆动，并左右摇动如摆尾状，摇 20~30 次（图 38）。

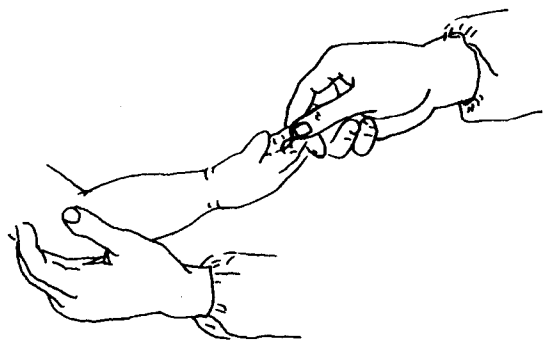


图 38 双龙摆尾

〔施治部位〕 手及肘关节。

〔主要作用〕 退热，宽胸理气，泻热通便。

〔操作技巧〕 操作时轻柔稳重，不可过快过重。重病、急病较壮者可做 30~50 次，速度可适当加快；身体虚弱者手法要轻要慢，次数也不可过多。

〔适应证〕 用于治疗小便不通或小便赤涩淋漓，口舌生疮，心悸胸闷，或便秘不通，腹满腹胀等。

★丹凤摇尾

操作者用左手拇、食指按捏患儿内、外劳宫穴，再用右手拇指指甲掐患儿中指指端，再摇动其中指各 10 ~ 20 次（图 39）。

〔施治部位〕 掌内外中心及中指端。

〔主要作用〕 调和气血，镇惊安神。

〔操作技巧〕 按捏掐摇结合，要轻柔，操作要细心，注意保护患儿皮肤。

〔适应证〕 用于治疗小儿高热惊风，夜寐不安，慢惊风头痛，头晕。



图 39 丹凤摇尾

★龙入虎口

操作者左手托患儿掌背，右手插入虎口，用大拇指或推或按揉患儿板门穴处（图 40）。

〔施治部位〕 手掌大鱼际处。

〔主要作用〕 除热，泌别清浊。

〔操作技巧〕 左手固定要稳，右手操作灵活，右手有节律往外推或往内推。

〔适应证〕 用于治疗发热，四肢抽搐，泄泻等。



图 40 龙入虎口

★苍龙摆尾

操作者右手拿患儿食、中、无名指三指，左手自总筋穴至肘

部来回搓揉几遍后，拿住肘部，右手持患儿三指频频摇动，如摆尾状，摆 20~30 次（图 41）。

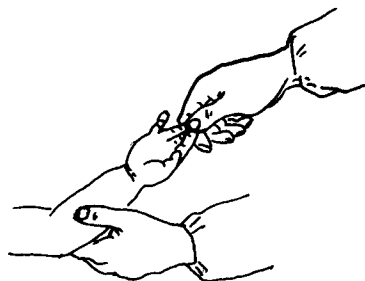


图 41 苍龙摆尾

〔施治部位〕手及肘部。

〔主要作用〕解表退热，理气开胸，滑肠通便。

〔操作技巧〕搓揉与摇法互相配合，动作轻柔，反复操作。

〔适应证〕用于治疗便秘，发热，胸闷憋气，腹胀，伤食，纳少等。

★老汉扳僧

操作者左手拇指掐住患儿拇指指根处，右手拿捏脾经穴，并摇动拇指 20~40 次（图 42）。

〔施治部位〕拇指。

〔主要作用〕健脾消食，理气消胀。

〔操作技巧〕掐捏摇动配合，施术轻柔缓和。

〔适应证〕用于治疗食滞中焦，痞

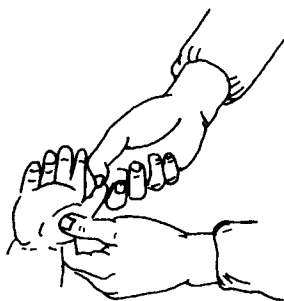


图 42 老汉扳僧

满腹胀，厌食腹痛，呕吐，便秘等。

★猿猴摘果

操作者两手捏起患儿手背腕部皮肤，一扯一放，反复多次（图43）。

〔施治部位〕手背腕部平阴穴、阳穴一线。

〔主要作用〕化痰行气，健脾和胃。

〔操作技巧〕只捏皮肤，速度均匀，动作轻柔。

〔适应证〕用于治疗脾胃虚寒，咳嗽，厌食，呕吐等。

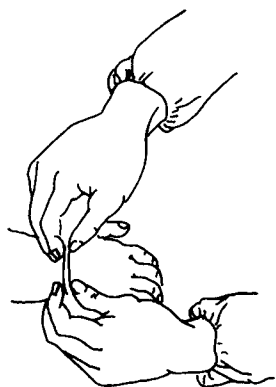


图43 猿猴摘果

★清天河水

操作者用大拇指桡侧或食中指指腹面，自总筋推向洪池（尺泽）处（图44）。

〔施治部位〕前臂正中，从肘腕到手腕。

〔主要作用〕发汗解表，清热泄火，甘寒养阴。

〔操作技巧〕将拇指桡侧或食中指指腹面平压住手腕正中，沿前臂正中往上推至肘腕部不可往返，反复推200~300次，重者500~1000次。力量要着实，均匀，平稳，不可过轻或过重。

〔适应证〕一切热证，如外感发热，阴虚盗汗，口干口渴，二便不爽等。

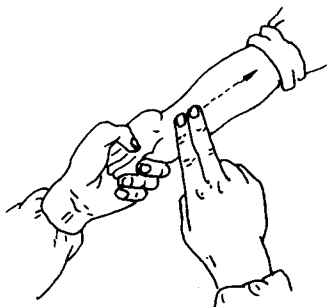


图44 清天河水

★水底捞月

操作者先用清水滴入患儿掌心，用拇指指腹贴实掌心并行施推法，边推边用口吹气，反复操作（图45）。

〔施治部位〕 手掌。

〔主要作用〕 清心泄火，退热解表。

〔操作技巧〕 拇指指腹着力，均匀施动，边推边吹气，反复操作3~5分钟，推时宜轻柔和缓。

〔适应证〕 用于治疗一切热证、心烦、便秘等。

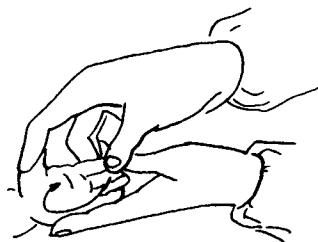


图45 水底捞月

★黄蜂出洞

操作者用右手拇指指甲先掐内劳宫、总筋，再分阴阳，然后用两手拇指在总筋穴处一撮一上至内关穴处，各15~30次（图46）。

〔施治部位〕 掌心、内关、坎宫、离宫穴处。

〔主要作用〕 发汗解表，宣肺化痰，止咳。

〔操作技巧〕 操作先从掌心开始顺序进行，力量和缓均匀，快慢适度。

〔适应证〕 用于治疗风寒感冒、咳嗽、鼻塞、流涕等。

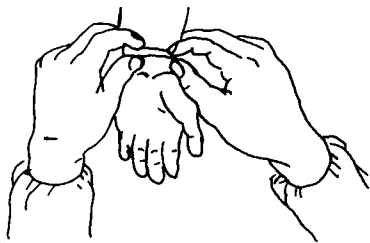


图46 黄蜂出洞

★黄蜂入洞

操作者用拇、中指或食、中指在患儿两鼻孔处，进行反复揉动（图 47）。

〔施治部位〕 两鼻孔处。

〔主要作用〕 发汗通气，祛风散寒。

〔操作技巧〕 操作时让患儿端坐或仰卧，操作者两中食指端压住两鼻孔处上下或左右轻轻揉动，至鼻通气或头部微汗出为止。

〔适应证〕 用于治疗风寒感冒及寒痰壅肺等。



图 47 黄蜂入洞

★运土入水法

操作者用左手拿住患儿除拇指以外的四指，使其掌心向上，右手拇指端或中指指端的指腹面着力，由患儿拇指指端推动，沿大鱼际赤白肉际处，经小鱼际赤白肉际到小指根处，反复操作 50 ~ 100 次，不可逆推（图 48）。

〔施治部位〕 掌部大小鱼际外侧沿。

〔主要作用〕 补土利水，利湿止泻。

〔操作技巧〕 去而不返，柔缓施术。

〔适应证〕 用于治疗小便赤涩，频数，腹泻等。



图 48 运土入水法

★运水入土法

操作者用左手拿住患儿四指，使其掌心向上，右手拇指端以指腹着力由患儿小指根运起，经小鱼际、大鱼际赤白肉际到拇指

根掌小横纹处，反复操作 50 ~ 100 遍（图 49）。

〔施治部位〕 掌部外侧缘。

〔主要作用〕 健脾助运，润燥通便。

〔操作技巧〕 去而不返，柔缓施术。

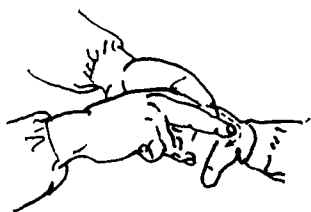


图 49 运水入土法

〔适应证〕 用于治疗大肠实热或肺热下移大肠引起的便秘，小便赤涩，舌红苔黄燥者。

★打马过河

操作者先用右手拇指指腹揉患儿内劳宫穴后，再将食指、中指并拢，以中指末节指腹着力，自内关穴经间使，循天河向上，一起一落，弹打至洪池穴为 1 遍，连打 10 ~ 20 遍。也可用拇、中二指由内关穴起，循天河弹至洪池穴的方法（图 50）。

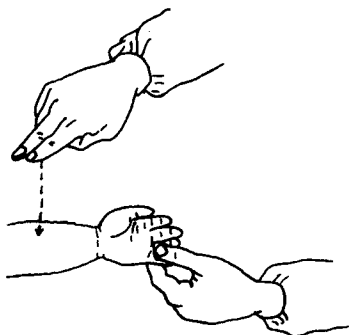


图 50 打马过河

〔施治部位〕 自掌心至洪池穴处。

〔主要作用〕 通经行气，利关节。

〔操作技巧〕 指腹着力，均匀揉动，弹打适度，操作细致。

〔适应证〕 用于治疗上肢痿痹，麻木不仁等。

★揉耳摇头法

操作者用双手食、拇指指腹分别相对着力捻揉患儿两耳垂

后，再捧其头左右摇之，揉 20~30 次（图 51）。

〔施治部位〕两耳垂及头部。

〔主要作用〕镇惊安神，和气理血。

〔操作技巧〕双手食、拇指相对用力，揉捻摇法结合，施术细腻，力量均匀。

〔适应证〕用于治疗高热惊厥，夜惊不安，头晕耳鸣，心悸失眠多梦，癫痫，多动等。

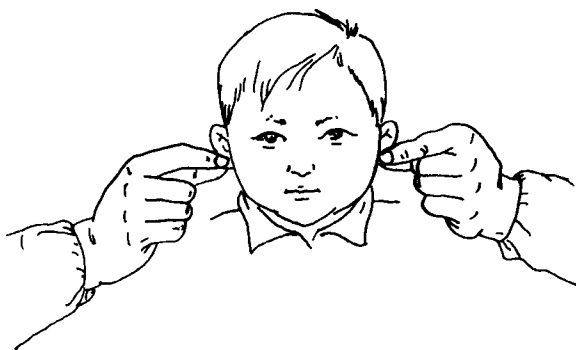


图 51 揉耳摇头法

★头痛推拿法

〔施治部位〕头部。

〔主要作用〕疏风散寒，宣肺解表，解痉止痛，升阳清目。

〔操作技巧〕

◎第一步：患儿端坐，操作者用左手大拇指按住患儿右耳上率谷穴，中指按住百会穴，再用右手大拇指、食指指端拨弄印堂及两攒竹穴 20 次。

◎第二步：操作者随即用两手中指按住两太阳穴，同时用两大拇指由印堂穴向上推送至发际天庭穴（又名开天门）20 遍。

◎第三步：操作者仍用两手中指按住两太阳穴，两拇指交替向上通过阳白到头维，连续 20 遍。

◎第四步：操作者两手中指不动，再用两大拇指由攒竹穴缓缓按过两眉际至太阳穴 20 遍，大拇指顺时针揉太阳穴 20 次。

◎第五步：操作者大拇指由太阳穴推至耳窍。

◎第六步：上提耳尖 3 次，接着拇指从耳前，食、中指在耳后，用中指擦耳后翳风穴（耳垂后下，当乳突与下颌角之间的凹陷处），顺势大拇指与食指捏住两耳垂下拉 3 次。

◎第七步：用两手掌大鱼际沿颈部两侧发际处经风府、风池推到大椎处，连续 20 遍，直至感到手掌发热为止。

◎第八步：操作者中指的指端或第一关节的棱角点打百会穴、四神聪穴（在头顶部，当百会前后左右各 1 寸，共 4 穴），或将右手食指、中指、无名指、小指并拢呈勺状，轻轻点打疼痛的部位。

以上前 7 步互相连贯，七步为 1 遍，一般 1 日 1 次，每次反复做 3 遍。

常用配伍穴位：一窝风、太冲、合谷、大椎、上星、百会、率谷、风府、三阴交。

[适应证] 用于治疗外感头痛，血管神经性头痛，高血压性头痛，头胀，头目不清等。

常用穴位

一些常用穴位如下（图 52 ~ 图 60）。

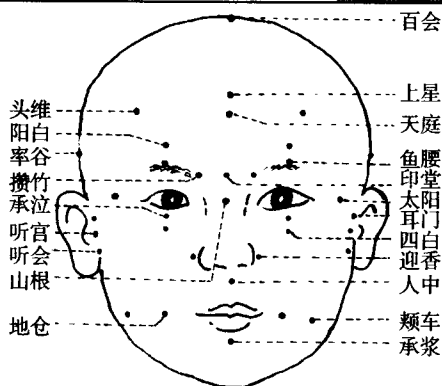


图 52 头面部穴位

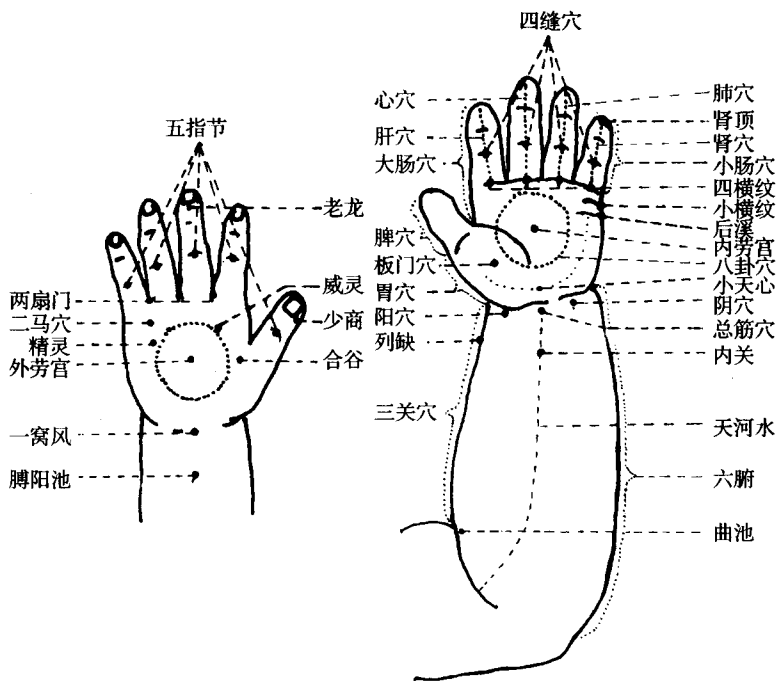


图 53 上臂穴位 1

图 54 上臂穴位 2

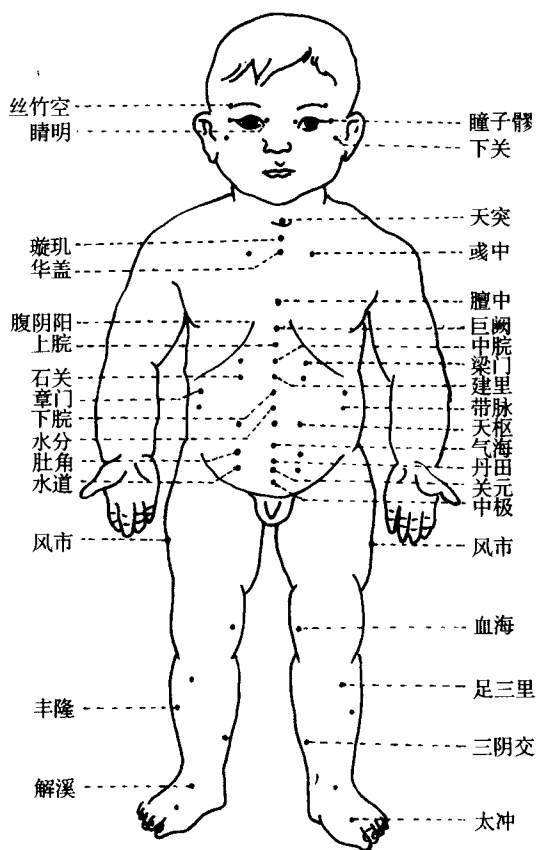


图 55 正面穴位图

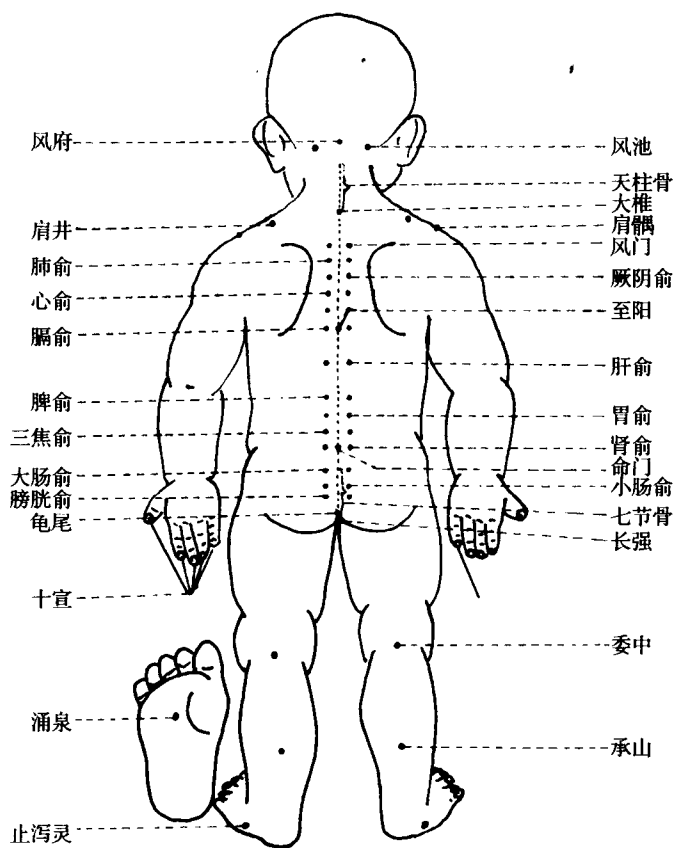


图 56 背部穴位图

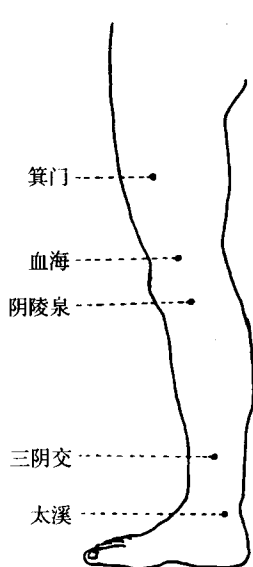


图 57 下肢内侧图

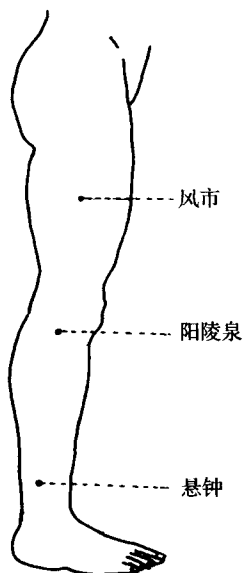


图 58 下肢外侧图

攒竹

〔位置〕在面部，眉头凹陷中，眶上切迹处（图 59）。

〔功能〕疏风清热，镇惊安神。

〔主治〕外感风邪引起的感冒头痛，纳呆等。

〔操作〕患儿端坐或怀抱，操作者用两拇指端指腹面，向两侧分推。



图 59 推攒竹

天庭

〔位置〕在头部正中
线，从印堂至前发际 0.5
寸呈一条直线（图 60），
属督脉。



图 60 推天庭穴

〔功能〕熄风止惊，明
目退翳。

〔主治〕眼病，口眼歪斜，惊风，夜啼，头痛等。

〔操作〕用推法，自两眉中间向额上直推至入发际 0.5 寸，
连推 30 次，又称开天门。

上星

〔位置〕在头部，当前发际正中线上 1 寸（图 52）。

〔功能〕清热泻火，凉血，熄风止惊。

〔主治〕头痛眩晕，目赤肿痛，迎风流泪，面赤肿，鼻渊，
鼻衄，癫狂症，小儿惊风，疟疾，热病。

〔操作〕点、揉、掐、捣法。

印堂

〔位置〕在头部，两眉内侧端连线之中点。按经络学说的观
点，印堂为经外奇穴（图 52）。

〔功能〕清热泻火，疏风解表，熄风止惊。

〔主治〕外感内伤所致惊风，夜啼，心悸等。

〔操作〕掐或推约 5 ~ 10 次。

山根

〔位置〕在头部，两目内眦中间，鼻梁上低洼处（图 52）。

〔功能〕安神定怯，熄风止惊。

〔主治〕急慢惊风等。如山根发青为惊，为痛；蓝色为喘；
蓝中有红纹是内热腹泻；如见赤红而为痢疾。

〔操作〕掐法约 5 ~ 10 次，或捏法 10 ~ 20 次，或推法 10 ~ 20 次。

太阳

〔位置〕在头部，眉梢与眼外角中间向外约 1 寸凹陷处，为经外奇穴（图 61）。

〔功能〕发汗解表，解痉止痛。

〔主治〕无汗或少汗，多汗，急慢惊风，感冒，发热，头痛，血管神经性头痛。



图 61 揉太阳

〔操作〕自眉梢向额角直推约 30 次，或揉 30 次，向耳方向或向眼方向运行约 30 次。

头维

〔位置〕从鬓发前缘直上距发际 0.5 寸（图 52）。

〔功能〕祛风止痛。

〔主治〕感冒头痛，头晕，头重。

〔操作〕患儿端坐或由母亲怀抱，操作者用拇指指尖从穴位处向上推，则为推头维。

阳白

〔位置〕在眼眉正中上 1 寸（图 52）。

〔功能〕祛风止痛。

〔主治〕感冒头痛，头晕，头重，面肌痉挛（面部抽搐）。

〔操作〕患儿端坐或由母亲怀抱，操作者用拇指指尖从穴位处向上推，则为推阳白。

四白

〔位置〕在承泣直下，当眶下孔凹陷处（图 52）。

〔功能〕清热明目，解痉止痛。

〔主治〕面瘫，面肌痉挛（面部抽搐），三叉神经痛，结膜炎，近视。

〔操作〕患儿端坐或由母亲怀抱，操作者用两手拇指顺时针或逆时针揉动四白。

人中

〔位置〕在鼻尖下人中沟上 $1/3$ 与下 $2/3$ 交会处（图 62）。

〔功能〕开窍醒神，解痉止抽。

〔主治〕突然昏倒，抽风，癫痫等，用于急救。

〔操作〕患儿端坐或由母亲怀抱，操作者用右手拇指指甲掐人中，直到会哭为止。



图 62 掐人中

承浆

〔位置〕在颏唇沟正中（图 52）。

〔功能〕解痉止痛。

〔主治〕三叉神经痛，面瘫。

〔操作〕患儿端坐或由母亲怀抱，操作者用右手拇指指甲掐，约 1 分钟。

迎香

〔位置〕在鼻翼下缘鼻唇沟凹陷处（图 52）。

〔功能〕疏风解表，通窍。

〔主治〕伤风感冒，鼻塞流涕，不闻香臭或鼻炎，鼻窦炎等。

〔操作〕患儿端坐或仰卧，操作者用右手食、中二指上下推揉穴位，约 1 分钟。

耳门

〔位置〕在耳屏上切迹前方凹陷处（图 52）。

〔功能〕滋阴清火。

〔主治〕耳聋，耳鸣等。

〔操作〕患儿端坐，操作者用右手食指或中指揉动穴位，约 1 分钟。

百会

〔位置〕在后发际上 7 寸，约当两耳尖连线的中点（图 63）。

〔功能〕升阳通窍止痛。

〔主治〕昏厥，头痛，眩晕，精神性疾病。

〔操作〕点百会或掐揉百会。



图 63 揉百会

风池

〔位置〕颈后枕骨下大筋外侧凹陷处（图 56）。

〔功能〕疏风解表，通窍明目。

〔主治〕感冒头痛，发热目眩，颈后强痛。

〔操作〕患儿俯卧或背坐，操作者用拇、食指端，将两侧风池穴提拿为拿风池；左右揉动为揉风池；上下推摩为推风池。

风府

〔位置〕在枕骨粗隆直下，两侧斜方肌之间的凹陷中（图 56）。

〔功能〕疏风解表，安神定志。

〔主治〕外感发热，头项强痛，精神失常，聋哑，中风后遗症。

〔操作〕患儿端坐，操作者用右手中指或拇指指腹面顺时针揉动。

天柱骨

〔位置〕颈后发际正中至大椎穴，与颈椎棘突呈一条直线（针灸书中记载，位置在哑门穴旁约 1.3 寸）（图 64）。

〔功能〕清热止惊，和胃消食止呕。

〔主治〕发热，惊风，伤食积滞，纳呆，恶心呕吐。

〔操作〕操作者用右手自上而下直推或擦约 100 次。

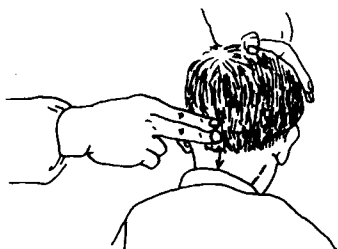


图 64 推天柱骨

大椎

〔位置〕在背后第 7 颈椎棘突下，也就是最高的一个颈椎棘突下凹陷处（图 65）。

〔功能〕退热止痛，发汗定喘。

〔主治〕发热，咳嗽，惊风，癫痫，肢体活动障碍等。

〔操作〕患儿俯卧或背坐，操作者用右手中指或食指指端揉动穴位，则称为揉大椎，或用食、中二指屈曲，挤拧大椎，则为捏大椎或拧大椎。

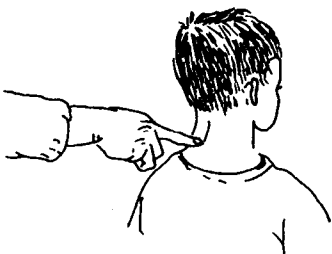


图 65 揉大椎

肩井

〔位置〕在颈后大筋与肩膀外侧连线的中点（图 66）。

〔功能〕通筋活络止痛。

〔主治〕感冒，怕冷怕风，上

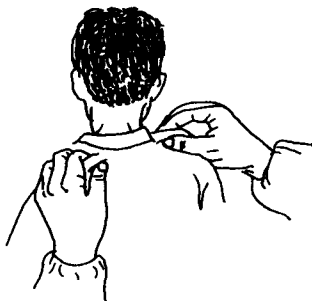


图 66 拿肩井

肢不能抬举，头痛和肩背不适等。

〔操作〕患儿俯卧或背坐，操作者用大拇指、食指对称用力提拿，则称为拿肩井；用指端按压穴位，则称为按肩井。

风门

〔位置〕在第2胸椎棘突下，旁开1.5寸（图56）。

〔功能〕疏风解表，宣肺化痰止咳。

〔主治〕感冒咳嗽，哮喘，慢性鼻炎及背部病症。

〔操作〕患儿端坐或俯卧，操作者用右手拇指和食指或用中、食指指端压住穴位做顺时针揉动。

肺俞

〔位置〕在第3、4胸椎棘突之间，旁开1.5寸（图67）。

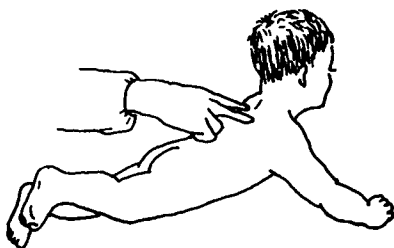


图67 揉肺俞

〔功能〕宣肺化痰止咳。

〔主治〕咳嗽，哮喘，肺结核，肺炎，胸膜炎，鼻塞，流涕及背部病症。

〔操作〕患儿端坐或俯卧，操作者用右手拇指、食指或用食、中指压此穴位顺时针或逆时针揉动，也可用两手拇指按压穴位。

脾俞

〔位置〕在第11、12胸椎棘突之间，旁开1.5寸（图56）。

〔功能〕健脾和胃，消食止泻。

〔主治〕胃痛，消化不良，慢性腹泻，肝炎，贫血，慢性出血性疾病，肾病，失眠，多梦，四肢困倦等。

〔操作〕同肺俞。

肾俞

〔位置〕在第2、3腰椎棘突之间，旁开1.5寸（图56）。

〔功能〕清热利尿，补肾止遗。

〔主治〕尿路感染，尿潴留，遗尿，肾虚气喘，慢性腹泻，耳鸣，耳聋。

〔操作〕同上。

命门

〔位置〕在第2腰椎棘突下（图56）。

〔功能〕温阳止泻。

〔主治〕遗尿，尿频，虚寒性腹痛，腰痛，慢性腹泻。

〔操作〕让患儿俯卧，操作者用右手拇指压住穴位顺时针揉动或压住不动。

七节骨

〔位置〕命门穴至龟尾呈一条直线（从第2腰椎到龟尾）（图68）。

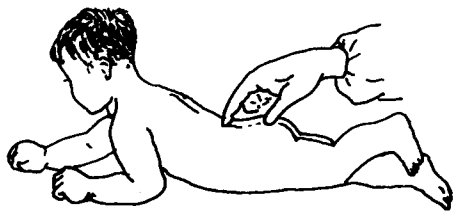


图68 推七节骨

〔功能〕上推，升提止泻，固肠涩便；下推，润肠通便，泄火开肺。

〔主治〕泄泻，便秘，肺热下移大肠或大肠实热上蒸于肺引起的肺热郁闭型咳喘症。

〔操作〕令患儿俯卧，操作者用右手拇指腹面或食、中指腹面从龟尾向上推至命门穴为上推七节骨，属补法；从命门向下推至龟尾为下推七节骨，属泻法。

龟尾

〔位置〕尾椎骨端(图 69)。

〔功能〕顺时针揉升阳止泻，逆时针揉则泄火通便。

〔主治〕脱肛，便秘，腹泻，疳积等。

〔操作〕患儿俯卧，操作者用右手拇指端或中指端揉，则称为揉龟尾。

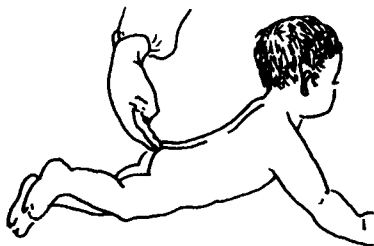


图 69 揉龟尾

长强

〔位置〕在尾骨尖端与肛门之间(图 56)。

〔功能〕顺时针揉升阳止泻；逆时针揉则泄火通便。

〔主治〕脱肛，便血，腰脊疼痛，腹泻，便干等。

〔操作〕患儿俯卧，操作者用右手中指或食指顺时针或逆时针揉动。

委中

〔位置〕在腘窝横纹中央(图 70)。

〔功能〕清热解暑，解痉止痛。

〔主治〕中暑，热厥，高热惊厥，四肢拘挛，急性腰背痛，

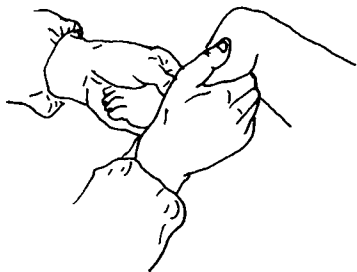


图 70 揉委中

四肢关节痛等。

〔操作〕患儿俯卧，操作者用右手拇指或中、食指揉动。

承山

〔位置〕在小腿下蹬用力时，出现人字形的凹陷处（图56）。

〔功能〕舒筋活络，补时升阳止泻，泻时润肠通便。

〔主治〕腰痛，肢体麻木，腹泻，便秘，脱肛等。

〔操作〕补法是让患儿俯卧，操作者用右手拇指掌面从下往上推，此时为推上承山；泻法是从上往下推，则为推下承山。

天突

〔位置〕在胸骨上窝正中（图71）。

〔功能〕止咳化痰，利咽解毒。

〔主治〕咳嗽，哮喘，失语，喉头异物感，吞咽困难，呃逆。



图71 揉天突

〔操作〕患儿端坐或仰卧，操作者用右手拇指或食指揉动或用拇、食二指捏住天突部位向上提，反复10~20次。

璇玑

〔位置〕在胸部正中线上，至第1肋骨上缘，天突下1寸（图55）。

〔功能〕止咳定喘，理气止痛。

〔主治〕咳嗽，哮喘，胸痛。

〔操作〕患儿端坐或仰卧，操作者用右手拇指或食、中指指端揉动。

华盖

〔位置〕在胸部，当前正中线上，平第1肋间（图55）。

〔功能〕利咽止咳。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸痛，肋肋胀痛，咽痛喉肿，急慢性咽炎。

〔操作〕用揉法或推法。

或中

〔位置〕位于胸部，当第1肋间隙，前正中线旁开2寸（图55）。

〔功能〕宣肺化痰，理气消胀。

〔主治〕咳嗽，气喘，痰壅，胸肋胀满，不嗜食。

〔操作〕多在经穴推拿时应用，右手拇、食指或中、食指压按穴位。

膻中

〔位置〕在胸部前正中线上，平第4肋间隙，正当两乳之间（图72）。

〔功能〕止咳化痰，顺气定喘。

〔主治〕心肌炎，胸闷疼痛，咳嗽喘憋，呃逆等。

〔操作〕患儿仰卧，操作者用右手拇指或食、中指并拢做逆时针或顺时针揉动。



图72 揉膻中

巨阙

〔位置〕在腹部前正中线上，脐上6寸（图55）

〔功能〕和胃消食，降逆止呕，理气止痛。

〔主治〕胃脘疼痛，恶心呕吐，腹胀，心悸，惊风抽搐。

〔操作〕用右手拇指或四指掌面旋揉，顺时针为补，逆时针为泻。

上脘

〔位置〕在腹部正中线上脐上 5 寸处（图 55）。

〔功能〕和胃消食，理气止痛。

〔主治〕纳呆，厌食，恶心呕吐，胃脘胀痛，泄泻等。

〔操作〕患儿仰卧，操作者用右手食、中指或掌根顺时针或逆时针揉中脘，顺时针为补，逆时针为泻（也有人认为顺时针为泻，逆时针为补）。

梁门

〔位置〕在上腹部，脐上 4 寸，前正中线旁开 2 寸（图 55）。

〔功能〕和胃止呕。

〔主治〕胃痛，呕吐，食欲不振，腹胀，大便溏薄。

〔操作〕用右手拇指或食、中指指端逆时针揉动 50 ~ 100 次。

石关

〔位置〕位于上腹部，当脐上 3 寸，前正中线旁开 2 寸（图 55）。

〔功能〕和胃止痛。

〔主治〕呕吐，腹痛，腹胀，便干，泄泻。

〔操作〕患儿仰卧，操作者用右手拇指或食、中指并拢揉动穴位。

中脘

〔位置〕胸骨下端至脐之中点（图 73）。

〔功能〕和胃消食，降逆止呕。

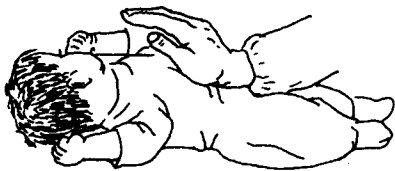


图 73 揉中脘

〔主治〕腹胀，呕吐，泄泻，食欲不振，嗳气，腹痛等。

〔操作〕操作者用右手拇指或食、中指端或掌根按揉患儿穴位，称揉中脘或按中脘。

下脘

〔位置〕在前正中线，脐上2寸（图74）。

〔功能〕理气消胀，和胃导滞。

〔主治〕胃脘痛，腹胀，纳呆，厌食，呃逆，恶心呕吐，肠炎和痢疾。

〔操作〕操作者用右手中指、食指按住穴位左右旋转，顺时针为补，逆时针为泻。

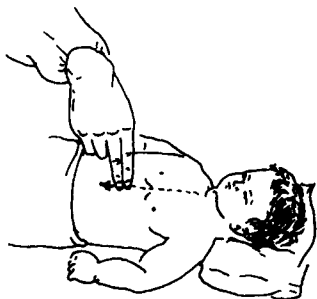


图74 揉下脘

水分

〔位置〕在上腹部，前正中线上，当脐上1寸（图55）。

〔功能〕理气消胀。

〔主治〕腹痛，腹胀，肠鸣，泄泻，反胃，水肿，小儿囟陷，腰背强急。

〔操作〕患儿仰卧，操作者用右手食或中指按住穴位，顺时针揉动称揉水分。

建里

〔位置〕在腹部前正中线上，脐上3寸（图55）。

〔功能〕理气止痛。

〔主治〕胃脘胀痛，腹满纳呆，乏力，困倦，烧心呕吐等。

〔操作〕患儿仰卧，操作者用右手拇指或食、中指揉动穴位。

神阙

〔位置〕肚脐（图75）。

〔功能〕理气止痛，消食止泻，通便。

〔主治〕腹痛，腹胀，食积，吐泻，肠鸣，便秘。

〔操作〕操作者用右手中指端或掌根置于脐部，向顺时针或逆时针方向揉动，称揉脐。拇、食、中、无名指端摩或以掌心摩，均称摩神阙。

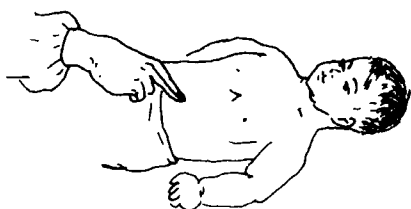


图 75 揉神阙

丹田

〔位置〕小腹部脐下 2 寸与 3 寸之间（图 76）。

〔功能〕理气止痛，止遗升提。

〔主治〕腹胀，腹痛，遗尿，脱肛，疝气，尿潴留。

〔操作〕或揉或摩，称揉丹田或摩丹田。

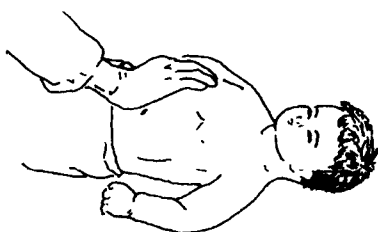


图 76 揉丹田

腹阴阳

〔位置〕上腹部，剑突下沿胸骨两侧呈八字形（图 77）。

〔功能〕理气消胀，降逆止呕。

〔主治〕腹痛，腹胀，消化不良，呕吐恶心，厌食。

〔操作〕沿肋弓角边缘两侧分推，称分腹阴阳。

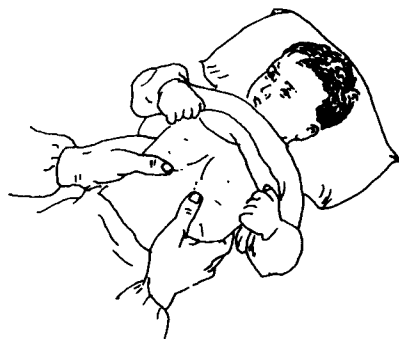


图 77 分推腹阴阳

气海

〔位置〕在腹部前正中线上，脐下1.5寸（图55）。

〔功能〕益气止泻，强身健体。

〔主治〕遗尿，痢疾，腹泻，腹胀，休克及防病保健强身。

〔操作〕同关元穴。

关元

〔位置〕在腹部前正中线上，脐下3寸（图55）。

〔功能〕益气助阳。

〔主治〕遗尿，腰痛腿疼，慢性腹泻，肾性哮喘，休克，防病保健强身用之。

〔操作〕患儿取仰卧位，操作者右手拇指或食、中指顺时针揉动。

血海

〔位置〕在髌骨内上缘2寸。简便定穴法，操作者面对患儿，用左手掌心按在患儿右膝髌骨上，当拇指尖所至处定穴（图55）。

〔功能〕祛风行血，舒筋活络止痛。

〔主治〕尿血，荨麻疹，高血压，膝关节炎。

〔操作〕患儿仰卧，操作者用右手拇指或食指顺时针揉动或逆时针揉动。

天枢

〔位置〕平脐，旁开2寸（图78）。

〔功能〕止泻通便。

〔主治〕腹泻，便秘，腹胀，痢疾等。

〔操作〕用右手食、中二指端揉，约揉50~100次。



图 78 揉天枢

肚角

〔位置〕 肚脐两旁大筋上（图 79）。

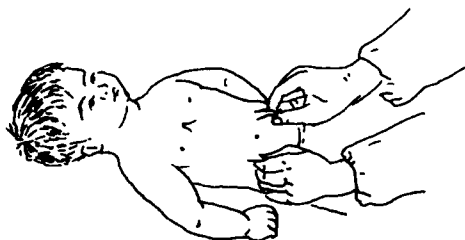


图 79 拿肚角

〔功能〕 理气止痛，固肠涩便。

〔主治〕 腹胀，腹痛，腹泻。

〔操作〕 用拿法。

足三里

〔位置〕 外膝眼下 3 寸，胫骨外侧约一横指处，属足阳明胃经（图 80）。

〔功能〕 理气消胀，健脾和胃止痛。

〔主治〕 腹痛，腹胀，脾虚食积，纳呆，便秘，泄泻不愈。

〔操作〕 患儿端坐或仰卧，操作者用双

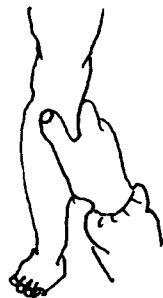


图 80 揉足三里

手顺揉穴位。

三阴交

〔位置〕内踝骨直上3寸处，属足太阴脾经（图81）。

〔功能〕滋阴补肾，熄风止惊。

〔主治〕遗尿，尿频，尿急，盗汗多梦，腰痛腿疼，阴虚火旺，抽搐惊惕等。

〔操作〕用右手拇指或食、中指顺时针揉动。

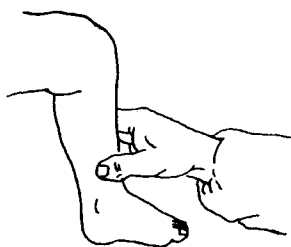


图81 揉三阴交

太冲

〔位置〕在足背第一、二跖骨结合部前的凹陷处（图55）。

〔功能〕清肝泄火，解痉止痛。

〔主治〕头痛，眩晕，面肌痉挛，精神病，癫痫，痉挛，小儿惊风，黄疸，胁痛，足背部病症。

〔操作〕用右手拇指或中、食指按压或揉动。

解溪

〔位置〕踝关节前横纹中点，两筋之间凹陷处，属足阳明胃经（图82）。

〔功能〕解痉止呕，舒利关节。

〔主治〕呕吐，腹泻，高热惊风，夜啼不安，踝关节屈伸不利。

〔操作〕用右手拇指或中、食指揉动此穴，或用拇指指甲掐。

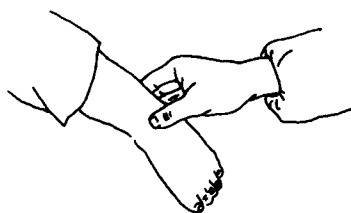


图82 掐解溪

涌泉

〔位置〕足掌心前 1/3 与后 2/3 交界处 (图 83)。

〔功能〕滋阴清热，降逆止呕，固肠涩便。

〔主治〕发热，呕吐，腹泻，两目红赤，头晕脑胀。

〔操作〕用右手拇指指甲掐约 5 ~ 10 次，或用拇指由后向前掌部推约 100 次。

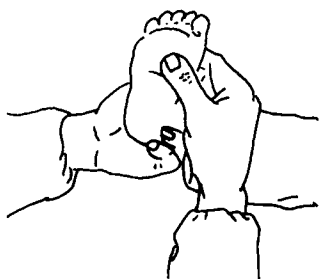


图 83 揉涌泉

止泻灵

〔位置〕在外踝骨直下，与赤白肉际交界处 (图 84)。

〔功能〕固肠止泻。

〔主治〕腹痛，腹胀，肠炎，痢疾。

〔操作〕操作者用右手拇指或食指顺时针旋揉或前后推动。

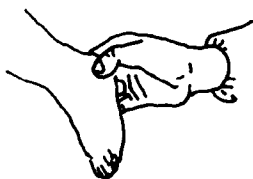


图 84 揉止泻灵

脾穴

〔位置〕在拇指桡侧缘，从拇指跟到拇指端 (图 85 ~ 图 87)。

〔功能〕健脾益气，消食化积。

〔主治〕消化不良，厌食，泄泻，积滞，便秘，腹胀，痢疾，抽风，咳喘，腹胀，贫血等。

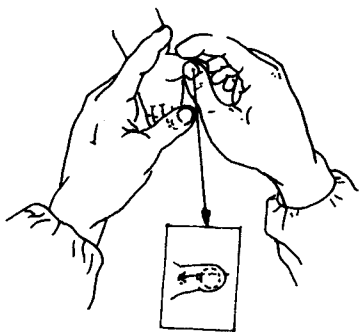


图 85 补脾

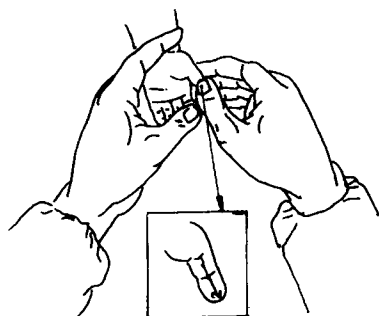


图 86 清脾经

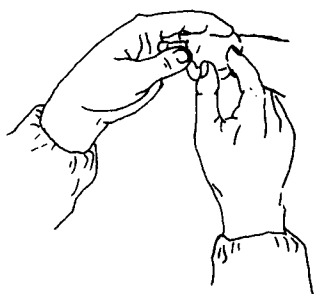


图 87 清补脾

〔操作〕补法是患儿拇指屈曲，操作者用右手拇指桡侧从患儿拇指端推向指跟；泻法是将患儿拇指伸直，操作者用拇指桡侧从指跟推向指端；平补平泻法是将患儿拇指稍微弯曲，操作者用拇指桡侧来回推。

胃穴

〔位置〕在大鱼际的外侧缘，从拇指跟到腕横纹的桡侧缘（图 88）。

〔功能〕和胃消食，降逆止呕，清热消胀。

〔主治〕伤食，纳呆，积滞，牙龈红肿疼痛，腹胀，呕吐等。

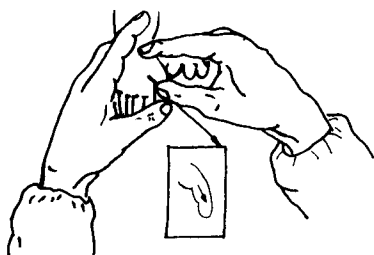


图 88 清胃经

〔操作〕操作者用左手握患儿左手，用右手食指和中指合并从腕横纹推到拇指跟为清胃，一般多用泻法，不用补法。如是胃阴不足或胃气虚的患者则需补脾，以达到补胃的目的。

肝穴

〔位置〕在食指面从指跟到指端（图 89）。

〔功能〕平肝泄火，镇惊熄风，除烦解郁。

〔主治〕头晕，头痛，两目红赤，烦躁，惊风，便秘，耳鸣。

〔操作〕操作者用右手拇指面从指跟推到指端为推肝经。

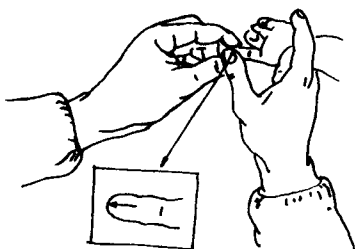


图 89 清肝经

大肠穴

〔位置〕在食指的桡侧从指跟到指端（图 90）。

〔功能〕固肠通便，清火泄热。

〔主治〕痢疾，腹泻，发热，便秘，脱肛等。

〔操作〕补法是操作者用左手握患儿左手，右手拇指桡侧推患儿左手食指，从指端到指跟；泻法是从指跟推到指端；平补平泻法是来回推。

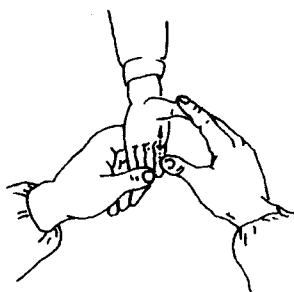


图 90 补大肠

心穴

〔位置〕在中指掌面从指跟到指端（图 91）。

〔功能〕清心泄火，养心补气。

〔主治〕口舌生疮，两目红赤，心慌气短等。

〔操作〕补法是操作者左手握患儿左手，用右手拇指端从指端推到指跟；泻法是从指跟推到指端。注意：此法多补，少泻。泻法易伤心气，如心火旺盛，出

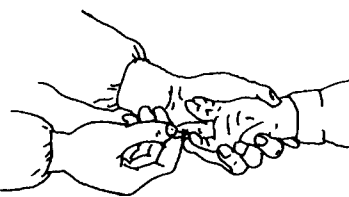


图 91 清心经

现口舌生疮，需用泻法时，当通过泻小肠的办法达到泻心火的目的，因为中医认为心与小肠相表里，泻小肠火便能起到泻心火的作用。

肺穴

〔位置〕 在无名指掌面，从指跟到指端（图 92）。

〔功能〕 补法的功能是益气平喘止咳；泻法是清肺泄热，利咽止咳；平补平泻法是顺气化痰，扶正达邪。

〔主治〕 感冒，咳嗽，气喘，痰鸣，发热，便秘，汗多，遗尿，脱肛等。

〔操作〕 补法是操作者用右手拇指端从患儿指端推到指跟，反推为泻法，来回推为平补平泻法。

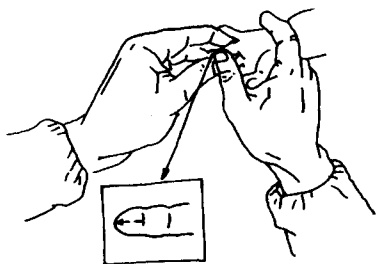


图 92 清肺经

小肠穴

〔位置〕 在小指的尺侧，从指跟到指端（图 93）。

〔功能〕 清热利尿，分清降浊。

〔主治〕 腹泻，尿少，尿闭，尿赤，口舌生疮，痈疽疔疮等。

〔操作〕 操作者用左手握患儿左手，用右手拇指从指跟推到指端，反复进行。此穴多用泻法，很少用补法。

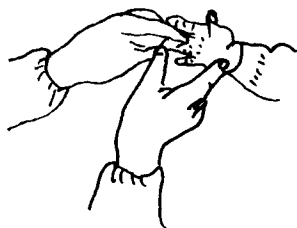


图 93 清小肠

肾穴

〔位置〕 在小指掌面，从指跟到指端（图 94、图 95）。

〔功能〕 滋肾水，壮肾阳，益脑填髓，纳气平喘。

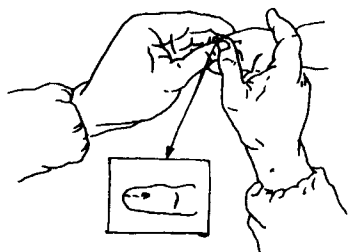


图 94 补肾经

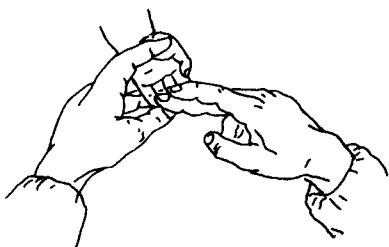


图 95 揉肾纹

〔主治〕先天不足，遗尿，尿频，五更泻和哮喘。

〔操作〕泻法是操作者用右手拇指掌面从指跟推向指端；反推为补，来回推为平补平泻法。亦可用揉法，称揉肾纹。

四横纹

〔位置〕在食指、中指、无名指、小指指跟处即掌横纹处（图 54）。

〔功能〕调中行气，止咳定喘。

〔主治〕咳嗽，腹胀，食积，内伤。

〔操作〕操作者左手将患儿四指并拢攥住，用右手拇指掌面从食指横纹处推到小指横纹处，称为推四横纹。

小横纹

〔位置〕在小指跟掌横纹与后泽穴中间（图 96）。

〔功能〕宣肺降气，化痰止咳。

〔主治〕肺炎，气管炎，百日咳，咳嗽痰鸣，口腔炎，鹅口疮，小便黄赤。

〔操作〕操作者用左手握患儿左手，用右手中指指端掌面顺时针揉动，则为揉小横纹。

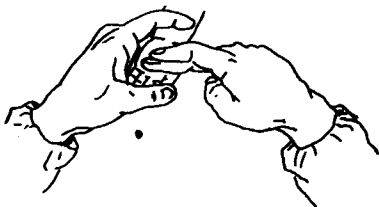


图 96 揉小横纹

板门穴

〔位置〕手掌大鱼际中心点的最高部位（图 97）。

〔功能〕清热除烦，降逆止呕，凉血止血。

〔主治〕发热，痰结，食积，腹胀，食欲不振，呕吐，腹泻等。

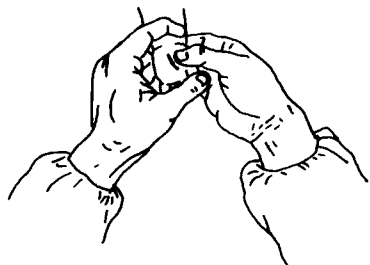


图 97 揉板门

〔操作〕用拇指指甲掐约 5 ~ 10 遍，或用拇指顺时针揉动 10 ~ 20 遍。

四缝穴

〔位置〕在第 2 至第 5 指掌侧，近端指关节横纹中点，一手共 4 穴，左右共 8 穴（图 54）。

〔功能〕消食和胃，止咳化痰。

〔主治〕小儿消化不良，营养不足，厌食，食积，便秘，咳嗽痰多。

〔操作〕掐法，用拇指指甲连续各掐 3 ~ 5 遍，或用指甲从指根部往指端刮，各 5 ~ 10 遍（图 98）。



图 98 刮四缝

天河水穴

〔位置〕前臂正中，从手腕到肘腕（图 54）。

〔功能〕清心泄热，除烦止渴。

〔主治〕鹅口疮，惊风，咳喘，感冒发烧，口渴，睡眠不安，大便干，盗汗等。

〔操作〕操作者用左手握患儿左手，使掌心向上，用右手食、中二指并拢的掌面或桡侧面从手腕推到肘腕，称为清天河水。

小天心

〔位置〕在大小鱼际的凹陷中，即大小鱼际交接处（图 99）。

〔功能〕安神定惊，清热利尿。

〔主治〕惊风抽搐，口眼歪斜，烦躁不安，夜啼，小便赤涩（小便不畅），大脑发育不良等。

〔操作〕操作者用左手握患儿左手，右手食、中二指屈曲，用第一关节的棱角扣打穴位；或用中指指端叩打穴位，均称为捣法。



图 99 捣小天心

八卦穴

〔位置〕在手掌面手心的周围，共分八个方位，有乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑八宫。南为离，北为坎，东为震，西为兑，西北为乾，东北为艮，东南为巽，西南为坤（图 100、图 101）。

〔功能〕顺气化痰，宽胸理膈。

〔主治〕宿食停滞，呕吐恶心，发热，咳喘，胸闷，腹胀等。

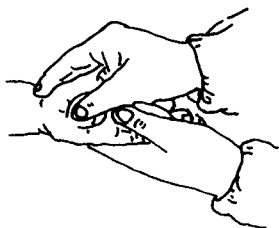


图 100 运八卦 1

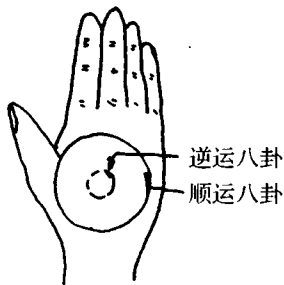


图 101 运八卦 2

〔操作〕患儿掌心向上，操作者用左手拿住患儿左手，用右手拇指或食中指沿患儿手心周围环形推运。顺时针为顺运，逆时针为逆运；顺时针从尺侧（小指侧）开始，逆时针从尺侧向相反方向运，不分东西南北。

阴阳穴

〔位置〕阴穴在手腕横纹尺侧端，相当于“神门”。阳穴在手腕横纹桡侧端，相当于“太渊”（图 102、图 103）。

〔功能〕调节阴阳。

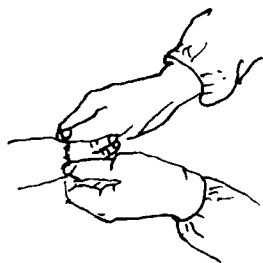


图 102 分推阴阳

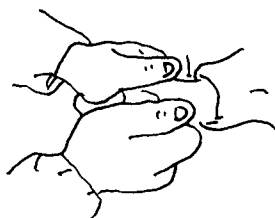


图 103 合推阴阳

〔主治〕阴穴治疗阴虚阳亢，寒热往来，气阴两虚，夜惊盗汗；阳穴治疗气血两虚，寒热往来，心肾不交，失眠多梦，肢冷项强，腹泻，腹胀。

〔操作〕合推或分推。

总筋穴

〔位置〕在手腕横纹正中（大陵穴后 0.5 寸处）（图 104）。

〔功能〕滋阴清热，解痉止泻。

〔主治〕小儿急惊风，夜啼症，潮热，盗汗，呕吐腹泻。

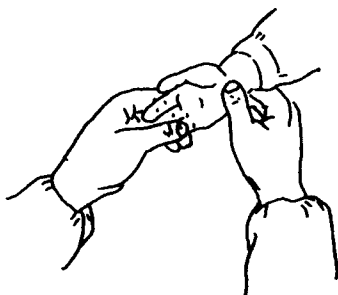


图 104 掐总筋

〔操作〕用掐法，约3~5次，或从总筋穴向两侧推10~20遍。

三关穴

〔位置〕在小臂桡侧从手腕到肘腕（图105）。

〔功能〕助气通阳，活血化瘀，培补元气。

〔主治〕气血不足，气虚多汗，肢冷腹泻，斑疹不出以及伤风感冒。

〔操作〕操作者左手握患儿左手，右手食、中二指并拢从手腕桡侧直推到肘腕，称推上三关。



图105 推上三关

六腑

〔位置〕前臂尺侧，从手腕到肘腕（图106）。

〔功能〕凉血退热，消疮散肿，通腑导滞。

〔主治〕一切实热证，如高热、烦渴、惊风、鹅口疮、扁桃体炎、疳腮、便秘等。

〔操作〕操作者用左手握患儿左手，右手食、中二指并拢，用掌面从患儿肘关节推向手腕，称退下六腑，一般只清不补。

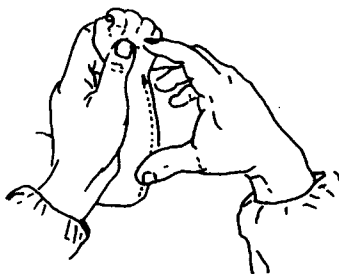


图106 退下六腑

五指节

〔位置〕在手五指背面第一指关节，即四缝穴对面（图53）。

〔功能〕 通关开窍，醒脑定惊，用于抢救。

〔主治〕 惊风昏迷时抢救，或夜寐不安，多梦易惊。

〔操作〕 患儿手背向上，操作者左手握患儿左手，用右手拇指指甲掐五指节。

二马穴

〔位置〕 在第四、五掌骨节之间的凹陷处（即小指和无名指交叉前的凹陷中），呈点形穴（图 107）。

〔功能〕 壮阳补肾，引火归元，行气散结，养脑清神，利尿通淋。

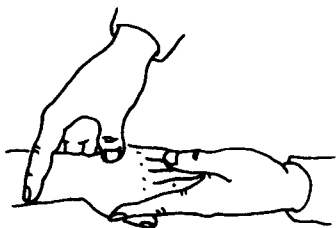


图 107 揉二马

〔主治〕 肾阳不足，肢冷腰酸，先天不足，痴呆，智力减退以及水肿遗尿等。

〔操作〕 操作者用左手握患儿左手，使手心朝下，用右手拇指端顺时针揉动。

精灵

〔位置〕 在小指和无名指的夹缝中，及掌指关节后的凹陷处（图 108）。

〔功能〕 行气破积，镇惊止抽，开窍醒神。



图 108 掐精灵

〔主治〕 惊风，昏迷，食积，气郁，多用于急症。

〔操作〕 操作者用左手握患儿左手，用右手拇指掐精灵穴。

威灵

〔位置〕 在中指和食指间的夹缝中，掌关节后凹陷处（图

109)。

〔功能〕 疏通经络，调畅气机。

〔主治〕 与精灵穴相同。

〔操作〕 同精灵穴。

外劳宫

〔位置〕 在手背中指和无名指掌骨交接的凹陷处（图 110）。

〔功能〕 温阳散寒止痛。

〔主治〕 外感风寒，腹痛，腹胀，肠鸣腹泻，脱肛，疝气，遗尿等。

〔操作〕 操作者用右手拇指或食、中指端顺时针揉动，则称为揉外劳宫。

合谷

〔位置〕 在手背第 1、2 掌骨之间，近第 2 掌骨桡侧的中点（图 111）。

〔功能〕 疏风解表，清热，宣肺止痛。

〔主治〕 感冒发热，头痛，咽痛，目赤鼻塞，口干舌燥，惊风抽搐以及手足痉挛等。

〔操作〕 掐法，操作者用右手拇指指甲用力掐住。

一窝风

〔位置〕 在手背面腕横纹正中凹陷处（图 112）。

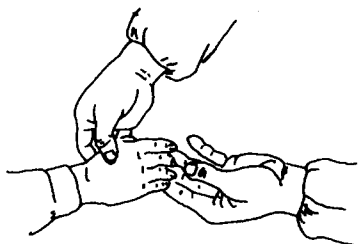


图 109 掐威灵

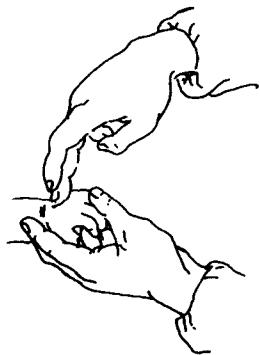


图 110 揉外劳宫

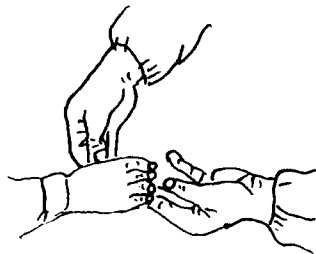


图 111 掐合谷

〔功能〕 发散风寒，温中行气，舒筋活络止痛。

〔主治〕 风寒感冒，受寒腹痛，风湿痹症。

〔操作〕 操作者用左手握患儿左手，用右手中指指端顺时针揉动，称为揉一窝风。

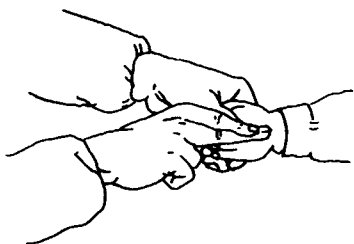


图 112 揉一窝风

老龙

〔位置〕 距中指甲跟正中，约 0.1 寸处（图 113）。

〔功能〕 镇惊安神。

〔主治〕 惊风，惊悸不安，恶梦多，睡眠不安等。

〔操作〕 掐法。

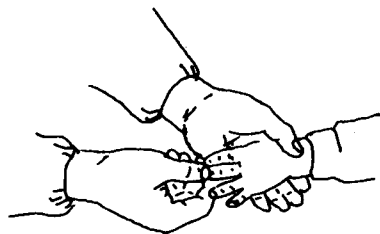


图 113 掐老龙

两扇门

〔位置〕 掌背小指与无名指、无名指与中指，中指与食指的指根夹缝间，当本节前（图 114）。

〔功能〕 疏风解表，镇惊熄风。

〔主治〕 小儿惊厥，抽搐，风寒感冒，发热无汗或高热不退等。

〔操作〕 揉两扇门。



图 114 揉两扇门

膊阳池

〔位置〕 在手背一窝风穴后 3 寸处，也就是腕横纹后 3 寸，

它与针灸阳池穴不同（图 115）。

〔功能〕 降气清脑，祛风止痛。

〔主治〕 头痛，头晕，惊风，癫痫和脑炎后遗症等。

〔操作〕 操作者用左手握患儿左手，并使手背向上，用右手拇指指甲掐为掐膊阳池；用中指端或拇指端揉为揉膊阳池。



图 115 揉膊阳池

列缺

〔位置〕 在桡骨茎突上方，腕横纹上 1.5 寸处。其简便定位法是用两手虎口交叉，在食指尖所指凹陷处（图 116）。

〔功能〕 疏风解表，宣肺止咳。

〔主治〕 头痛，咳嗽，鼻塞，咽痛，高热惊风，癫痫等。

〔操作〕 操作者用右手拇指端掌面压住穴位，其他四指放于穴位对面（尺侧），适当用力拿住。

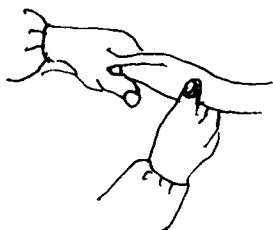


图 116 拿列缺

曲池

〔位置〕 屈肘，在肘窝桡侧横纹头至肱骨外上髁中点（图 54）。

〔功能〕 解表止喘，舒筋活络。

〔主治〕 感冒咳嗽，气喘，上肢痿软，抽掣。

〔操作〕 用拿法，或用揉法。

◇ 小儿病手到病除 ◇

疾病治疗篇

JIBING ZHILIAO PIAN



感冒

感冒又称上呼吸道感染，一年四季均可发生，又以冬春季节发病率最高，占整个儿科疾病的首位。此病是以鼻咽部炎症为主要病变，可由病毒或细菌引起，也可由双重感染引起。婴幼儿患上感后，炎症可向邻近器官蔓延，引起中耳炎、颈部淋巴结炎等。如炎症向下发展，又容易转为支气管炎或支气管肺炎。年岁稍大的小孩患感冒后可引起“肾炎”、“心肌炎”、“风湿热”等变态反应性疾病。

这种病大多数是由病毒引起，少数是由细菌引起的。中医认为感冒是外来时邪侵袭于肺脏，影响了肺气的正常宣降和通气功能而造成的。

诊断

◎轻症：无热或低热，有鼻塞流涕、喷嚏、咽痛、轻咳等，一般3~5日后自愈。

◎重症：全身症状较重，高热流涕，鼻塞，咽部及扁桃体充血，有黄色或白色渗出物，咽后壁可见疱疹、溃疡，如炎症扩散，可波及邻近器官，使所属淋巴结增大、增多，亦会因肠系膜淋巴结炎引起急性腹痛。

◎某些传染病，如麻疹、百日咳、流脑等，早期有上感症状，应注意鉴别。

◎病毒引起的，一般鼻部症状比咽部症状明显，可伴有眼结膜充血，血白细胞降低；细菌感染的，咽部充血及疼痛较病毒感染

染明显，会有白色渗出物，白细胞增高。但白细胞高低不能作为病毒或细菌感染的依据，只能作为参考。如果咽部疼痛充血，咽后壁滤泡增生为主可诊断为急性咽炎；扁桃体红肿，有渗出物的可诊断为急性化脓性扁桃体炎；高热，流口水，不能进食，伴咽后壁有小疱疹或有小溃疡的为疱疹性咽峡炎。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

顺运八卦3分钟，清补肺3分钟，顺揉风池2分钟，顺揉大椎2分钟，下擦脊背1分钟，顺揉太阳1分钟，上推印堂1分钟。

2. 随证配穴

(1) 风寒型

主要表现：发热，怕冷，不出汗，鼻塞不通或流清涕，咳嗽声哑，舌淡，苔薄白，脉浮紧。

治法：疏风散寒，解表止咳。

配穴：常用穴位加顺揉一窝风2分钟，推上三关2分钟，顺揉外劳宫2分钟，揉黄蜂入洞1分钟。头痛重的加用头痛推拿法和风池、风府穴；汗出怕风的则推补脾2分钟；咳嗽无痰的推四横纹2分钟。

(2) 风热型

主要表现：发热有汗，咽痛，口干咳嗽，伴有小便黄，大便干，舌质红，脉浮数。

治法：疏风清热，宣肺止咳。

配穴：常用穴位加清天河水2分钟，清大肠2分钟，掐合谷1分钟。发热重的加退下六腑5分钟。

(3) 感冒挟食型

主要表现：感冒症状伴有厌食，恶心呕吐，大便不调，腹痛

腹胀，舌淡，苔白厚腻。

治法：疏风解表，消食和胃。

配穴：常用穴位加清胃 3 分钟，清补大肠 3 分钟，清补脾 2 分钟，推板门 1 分钟。

(4) 感冒挟惊型

主要表现：感冒症状伴夜间睡眠不安，时有惊叫，烦躁易哭，小便黄，大便色绿。

治法：疏风解表，镇惊安神。

配穴：常用穴位加平肝 2 分钟，补肾 2 分钟，捣小天心 3 分钟，拿列缺 1 分钟，逆运八卦 1 分钟。

(5) 感冒挟痰型

主要表现：感冒症状伴有咳嗽频作，胸闷气短，喉中多痰鸣，或咳吐白痰。

治法：疏风解表，宣肺化痰。

配穴：常用穴位加揉小横纹 2 分钟，清肺 3 分钟，补脾 2 分钟。

预防护理

◎锻炼身体，加强体质，多晒太阳，多在户外活动，提高抗病能力。

◎讲究卫生，常洗澡，常更衣，并且根据气候变化增减衣服。

◎药物预防，生贯众 3~6 克，水煎服，每日 1 剂，分 3 次服，连服 3 日。

◎患病期间多饮水，多吃易消化的食物，及时清洗鼻腔和眼部分泌物，注意病情变化。

◎保持大便通畅，不可过饱、过累。

◎每日或隔日推拿风池、风府、合谷、一窝风 1 次，或从室

内外出时揉人中、风池数次，预防感冒。

◎在流行期间可注射流感疫苗，注射1~2次，隔3~4周1次，注射后3~4天即可产生免疫。

咳嗽

咳嗽是小儿呼吸道疾病中常见的症状之一，如上呼吸道感染、支气管炎、支气管肺炎等均可出现咳嗽。咳嗽多见于2岁以下婴幼儿，一年四季都可得这种病，尤以冬春两季为多，而且多发生在感冒、肺炎、咽炎、喉炎之后，但也有突然起病的，如过敏性哮喘、喉肌痉挛等。

这种病主要是由于细菌或病毒侵入气管和肺的黏膜，影响了气管和肺的通气功能引起的。另一方面，由于小儿解剖方面的特点，最易引起咳嗽，如小儿鼻腔短小，黏膜血管丰富，没有鼻毛，易受外感之邪侵袭，加之喉管狭窄，又有较多的淋巴组织和血管，一旦感染疾病就易产生喉头水肿，引起呼吸困难。乳幼儿肺泡弹性差，含气量少，有炎症后易被黏液堵塞引起窒息等。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

清补肺3分钟，平肝2分钟，揉一窝风2分钟，分推手阴阳1分钟，分推膻中2分钟，揉天突1分钟，逆运八卦2分钟。

2. 随证配穴

(1) 风寒咳嗽

主要表现：咳嗽较重，咳痰清稀，怕冷，发热，头痛，鼻塞

不通，咽痛而痒，鼻流清涕，或肢体疼痛，舌淡，脉浮紧。

治法：疏风散寒，宣肺止咳。

配穴：常用穴位加推上三关2分钟，顺揉外劳宫2分钟，顺揉膊阳池1分钟。

痰多揉小横纹1分钟，痰少推四横纹2分钟，头痛揉印堂1分钟，揉太阳穴1分钟。

(2) 风热咳嗽

主要表现：咳嗽吐白黏痰或黄黏痰，咳嗽不爽，伴口渴，发热，咽痛，出汗，舌淡红，苔薄而黄，脉浮数。

治法：疏风清热，宣肺止咳。

配穴：常用穴位加清肺3分钟，清大肠2分钟，清天河水2分钟，揉小横纹2分钟，揉风池2分钟，揉大椎2分钟，擦脊1分钟，掐合谷1分钟。

头痛重的拿列缺1分钟，揉膊阳池2分钟，或用头痛推拿法。如伴有痰多喉鸣和大便不调的加清补脾、揉足三里各1分钟。

(3) 痰热咳嗽

主要表现：阵发性咳嗽，呼吸气粗，喉中痰鸣，或痰少而黏，不容易咳出，鼻腔干燥，嗓子发干，小便黄赤，大便燥结，舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清肺化痰止咳。

配穴：常用穴位加退下六腑3分钟，揉小横纹2分钟，清补脾2分钟，清天河水2分钟，清小肠1分钟。

(4) 痰湿咳嗽

主要表现：咳嗽痰多，色白容易咯出，伴胸闷腹胀，饮食减少，大便稀，舌淡，苔白而腻，脉滑数。

治法：燥湿化痰。

配穴：常用穴位加逆运八卦2分钟，补脾3分钟，合推手阴阳1分钟，清胃1分钟，揉小横纹1分钟，清小肠2分钟。

(4) 气虚咳嗽

主要表现：咳嗽无力，痰色白而稀，面色苍白，气短，不愿意说话，说话声音低微，喜热饮，喜暖汗多，舌质淡红，舌体胖嫩，苔薄白，脉细无力。

· 治法：健脾益气，止咳。

配穴：常用穴位加补脾2分钟，补肺2分钟，揉二马2分钟，推上三关2分钟，顺运八卦2分钟，合推手阴阳1分钟，揉足三里1分钟。

预防护理

◎平时注意锻炼身体，多晒太阳，提高小儿对疾病的抵抗力，培养小儿良好的饮食习惯和睡眠习惯。

◎防止交叉感染，在呼吸道疾病流行时，尽量避免带小儿到公共场所，如商场、电影院等场所。

◎小儿的衣服要寒暖适宜，要随气候变化增减。

◎积极防治软骨病，注意多食含锌含钙较高的食物，如花生、核桃、虾类、排骨等，以提高小儿的抵抗力和免疫力。

◎注意环境卫生和室内的空气流通，要保持室内空气有一定的湿度，开窗时不要让风直接吹到孩子身上。

发 热

小儿体温超过 37.5℃ 称为发热，但有少数正常小儿，在某

些条件下，如喂奶、运动、哭叫、衣服过厚或室温过高时体温也能达到 37.5℃。

引起发热的原因很多，一般分感染性发热和非感染性发热。感染性发热多是由细菌、病毒、寄生虫、霉菌引起的；非感染性发热是由组织损伤、坏死或变态反应性疾病及神经系统疾病引起的。发热本身是防御和适应内外环境异常的一种代偿性反应，同一病因引起发热的体温高低不同（如新生儿肺炎可不发热或体温低下），因此，热度高低并不能完全代表疾病的轻重。中医把发热分为外感发热和内伤发热两种。外感发热多是感受了风热、风寒、暑热或湿温引起的；内伤发热多是由小儿体质虚弱，慢性病缠身引起的一种消耗性发热。其原因是护理不周或喂养不当。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

平肝 2 分钟，清补肺 2 分钟，清天河水 2 分钟，退下六腑 3 分钟，捏大椎 2 分钟，擦脊 1 分钟，揉风池 1 分钟。

2. 随证配穴

(1) 外感发热

① 风寒发热

主要表现：鼻塞不通，流清涕，打喷嚏，咳嗽声哑，发热怕冷，头痛无汗，四肢酸痛，舌淡，苔白，脉浮紧。

治法：疏风散寒，解表。

配穴：常用穴位加揉一窝风 2 分钟，推上三关 2 分钟，揉风府 1 分钟，揉外劳宫 2 分钟，推四横纹 1 分钟，揉迎香 1 分钟。

咳嗽重的推四横纹 2 分钟，清肺 2 分钟，发热不汗出者加顺运八卦 2 分钟，推印堂 1 分钟，擦脊 2 分钟。

② 风热发热

主要表现：发热不恶寒，咳嗽流涕，呼吸气粗，口气热，汗多怕风，大便干，咽部红肿，扁桃体肿大，舌偏红，苔白，脉浮散。

治法：疏风清热，辛凉解表。

配穴：常用穴位加清大肠 2 分钟，掐合谷 1 分钟，推下七节骨 1 分钟，推下承山 1 分钟。

③暑湿发热

主要表现：高热（体温 $39 \sim 40^{\circ}\text{C}$ ）不退，烦渴，汗出，头晕，两目不清，舌红，苔黄而干，脉滑数。

治法：清热解暑，养阴生津。

配穴：常用穴位加清胃 2 分钟，顺揉迎香 2 分钟，揉太阳 1 分钟，清大肠 2 分钟，掐合谷 1 分钟，点按百会 1 分钟。

④湿热发热

主要表现：发热，四肢困倦，懒动，头晕发胀，胸闷，恶心，口干不愿喝水，少食，小便黄，大便干燥，舌苔黄腻，脉濡数。

治法：清热利湿。

配穴：常用穴位加清补脾 2 分钟，清小肠 2 分钟，运水入土 1 分钟，清大肠 2 分钟，揉印堂 2 分钟，顺揉太阳 1 分钟，点掐百会穴 2 分钟，开天门 1 分钟。

如伴头痛则加用头痛推拿法。

(2) 内伤发热

①阴虚发热

主要表现：低热，盗汗，颧红，心烦，干咳少痰，咽干，口唇干燥，口渴，小便短黄，大便干，舌红少苔，脉细数。

治法：养阴清热，润燥生津。

配穴：常用穴位加补肾 3 分钟，揉二马 2 分钟，清胃 2 分

钟，揉三阴交2分钟，揉神阙1分钟。

②气血两虚发热

主要表现：低热，盗汗，食少便稀，气短，精神不振，困倦无力，面色苍白，唇舌色淡，语言低微，脉细无力。

治法：补气养血。

配穴：常用穴位加补脾2分钟，补肺2分钟，推上三关2分钟，补心1分钟，揉足三里1分钟，揉内劳宫2分钟，揉三阴交2分钟。

预防护理

◎加强体育锻炼，注意营养，保持室内空气流通。

◎按时注射各种预防针。

◎发热期间要吃容易消化的食物，适当补充水分。

◎捏脊，清补肺，清补脾，平肝，每日1次或隔日1次，并保持大便通畅。

小儿肺炎

小儿肺炎又称“支气管肺炎”或“小叶性肺炎”，是小儿最常见的疾病之一，也是许多急性传染病的主要并发症之一，尤以3岁以内小儿为最多。临床表现以发热、咳嗽、气急、鼻翼扇动为特征。此病多发于冬、春寒冷季节及气候突然变化的时候。其病因多是感染细菌或病毒引起的。中医认为是小儿肺气不足，外感风邪，内蕴痰热，肺失宣肃引起。

诊断

◎多继发于上呼吸道感染或支气管炎之后。常见发热、厌食、咳嗽、气喘等。

◎呼吸系统表现有咳嗽有痰或喉中痰鸣，呼吸浅促，气喘，病重者鼻翼扇动，指甲青紫，明显喘憋。肺部听诊有细湿罗音，以两肺底及脊柱两旁为最重，偶有喘鸣音。病灶融合呈大片肺实变时会有管状呼吸音，叩诊呈浊音或实音。

◎心脏方面的表现，重者会出现充血性心力衰竭，心率增快，安静时 140 ~ 160 次/分钟以上，肝脏进行性增大。严重者颜面、四肢浮肿，合并心肌炎时，面色苍白，四肢凉，冷汗，第一心音低钝，心律不齐或奔马律，部分小孩心电图异常，呼吸每分钟超过 60 次。

◎消化系统表现为食欲减退，呕吐腹泻，腹胀，重者可有中毒性肠麻痹；神经系统表现为精神不振、嗜睡、烦躁或惊厥等。重者可并发中毒性脑病、脑水肿或脑膜炎。

◎X 线检查，可见两肺有点片状阴影。经化验检查，白细胞总数可高达 $(15 \sim 40) \times 10^9/\text{升}$ ，中性占 70% ~ 90%，此表现大多数为细菌感染，如果白细胞降低或正常，大多数为病毒感染。

治疗

1. 常用穴位和推拿手法

逆运八卦 3 分钟，清补肺 3 分钟，推上三关 3 分钟，退下六腑 2 分钟，揉天突 1 分钟，分推膻中 1 分钟，清补大肠 1 分钟。

2. 随证配穴

(1) 风寒闭肺

主要表现：发热，恶寒，咳嗽，气急，口不渴，咽不红，痰

稀清白，舌淡红，苔薄白，脉浮紧。

治法：宣肺解表。

配穴：常用穴位加顺揉一窝风2分钟，顺揉外劳宫2分钟，顺揉风池1分钟。

(2) 风热闭肺

主要表现：发热不恶寒，咳嗽气急，口干而渴，咽红痰稠，苔薄而黄，脉浮数。

治法：清热宣肺，化痰止咳。

配穴：常用穴位加清心2分钟，清大肠2分钟，下擦脊背2分钟，分推手阴阳2分钟，清天河水1分钟，掐五指节5遍。

如果痰多加揉小横纹1分钟，清脾2分钟，清小肠1分钟；高热抽风者捣小天心1分钟，平肝2分钟，掐合谷1分钟，拿列缺1分钟，按肩井1分钟。

(3) 心阳虚衰

主要表现：咳嗽气喘加重，烦躁，面色青紫，四肢发凉，肝逐渐增大，脉数无力。

治法：开宣肺气，温振心阳。

配穴：常用穴位加揉神阙2分钟，补心2分钟，掐内关1分钟，揉外劳宫1分钟，揉膻阳池1分钟，补肾1分钟，揉三阴交1分钟，分推手阴阳1分钟。

(4) 正虚邪恋

主要表现：病情迁延时间长，虽急性期已过，但咳嗽痰多不减，两肺仍有明显小水泡音。偏于气虚的则神情呆滞，面色虚白，汗多。偏于阴虚的则出现低热，盗汗，干咳少痰，舌红少苔。

治法：气虚的应补气助阳，化痰止咳；阴虚的要养肺清热，扶正驱邪。

配穴：气虚的要补脾 3 分钟，推四横纹 2 分钟，揉小横纹 2 分钟，揉足三里 2 分钟，清小肠 1 分钟，顺运八卦 2 分钟；阴虚的要补肾 2 分钟，清天河水 2 分钟，平肝 2 分钟，揉二马 2 分钟，清胃 2 分钟，揉三阴交 2 分钟。

预防护理

◎注意饮食清淡，加强营养，多在室外活动，多晒太阳，预防佝偻病和营养不良。

◎避免接触呼吸道感染的病人。

◎保持安静，避免躁动及过多诊治措施。

◎室内空气要新鲜、凉爽，保持一定的湿度。

◎要勤翻身，多拍背，拍背时由两侧往中间拍。

◎重病患儿要先抢救，稳定后再行推拿。

◎病愈后要推补肺，揉大椎，推膻中，擦背脊，每日 1 次，或隔日 1 次，具有保健和预防作用。

百 日 咳

百日咳又叫“顿咳”，临床以阵发性和痉挛性咳嗽为其特征，因这种病缠绵难愈，所以称百日咳。该病多发生在冬末春初，1~6 岁小儿多见，10 岁以上很少发病，患过这种病以后可获得终身免疫。本病由于病程长，对身体影响较大，且容易引起并发症，故须早日预防治疗。

本病多是由于感染了百日咳杆菌引起的，通过咳嗽飞沫传播，潜伏期 2~21 天。病情发展分为三个阶段。

诊断

◎初期：发热（体温大多在 38°C 左右），咳嗽，流鼻涕，偶尔打喷嚏，与普通感冒相似，1~2 天后发热、一般症状逐渐减退，但咳嗽加重，昼轻夜重。

◎痉咳期：咳嗽呈阵发性和痉挛性，咳声短促，连续十几声而无吸气的间隙，继之咳嗽暂停。当深吸气时发出一种特殊的回声，像鸡叫一样，回声一停，紧接着又是一连串同样的咳嗽，如此反复数次或十数次，最后排出一口痰，暂时缓解，痉咳次数常是昼少夜多。

◎恢复期：阵发性痉挛咳嗽逐渐减轻，特殊的回声亦逐渐消失，呕吐减少，如果没有并发症，约 2~3 个星期恢复健康。如遇到感染又可出现百日咳样咳嗽，但不是真正的百日咳。

化验检查：白细胞总数显著增高，可达 $(30 \sim 50) \times 10^9/\text{升}$ ，淋巴细胞增高达 60%。

治疗

1. 常用穴位和推拿手法

逆运八卦 2 分钟，清补肺 2 分钟，推四横纹 2 分钟，推小横纹 1 分钟，清天河水 1 分钟，分推膻中 1 分钟，揉肺俞 2 分钟，拧大椎 20 次。

2. 随证配穴

（1）初期

治法：祛风散寒，顺气化痰。

配穴：常用穴位加揉一窝风 3 分钟，掐合谷 1 分钟，揉风池 1 分钟，揉曲池 1 分钟，擦脊 1 分钟。

（2）中期

治法：降气化痰，清肺泄热。

配穴：常用穴位加捏天突 50 次，补脾 2 分钟，揉二马 2 分钟，分推手阴阳 1 分钟，退下六腑 2 分钟，清大肠 1 分钟。

(3) 后期

治法：健脾和中，养肺止咳。

配穴：常用穴位加补脾 2 分钟，揉外劳宫 2 分钟，揉足三里 1 分钟，合推手阴阳 1 分钟，清胃 1 分钟，顺揉神阙 1 分钟，顺揉气海 1 分钟。

预防护理

◎控制感染源，对百日咳患儿要立即隔离，隔离期一般为 30 ~ 40 天，室内空气要流通，光线要充足。

◎保护易感儿，对易感儿要及时预防接种，也可吃大蒜预防，或用鱼腥草 30 克，水煎服，1 日 1 次，连服 5 日。

◎6 个月内的患儿，如咳嗽较重，应设专人守护，防止发生窒息。

支气管哮喘

支气管哮喘为呼吸道的变态反应性疾病。变应原可能是感染病原体及其毒素，或者是吸入粉尘，或者是食入某些过敏物质；气候变化及情绪激动常是本病的诱发因素，并以反复发作、呼吸困难、呼气延长以及喉间发出哮鸣声为特征。中医认为这是脾肾不足，痰湿内盛，感受非时之邪，引动宿痰，阻于气道，致使肺失宣肃，壅塞之气不通所致。

诊断

1. 临床表现

(1) 病史：常有家族史，年龄为5岁以上小儿，男多于女。过去有婴儿湿疹、变态反应性鼻炎、哮喘性支气管炎等。

(2) 症状：发作前有咳嗽、胸闷、鼻痒流涕、连续喷嚏等先兆症状，发作时烦躁不安，呼吸困难，不能平卧，张口抬肩，喘息汗出，面色苍白或青紫。

(3) 体征：呼气延长，两肺布满哮鸣音，继发感染后可闻及湿性罗音，伴肺气肿者可见桶状胸，叩诊为鼓音。

(4) 哮喘持续状态：哮喘持续发作12小时以上，用一般平喘药物未能控制者，称哮喘持续状态，可出现心衰以及呼吸性酸中毒。本病必须积极治疗，否则可引起呼吸衰竭而死亡。

2. 实验室检查

(1) 嗜酸性粒细胞常在6%以上，可高至30%，其他一般正常。

(2) X线检查。胸部X线检查常有肺气肿现象，肺组织透光增强，肺纹理增宽。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

清补肺3分钟，推四横纹3分钟，揉板门2分钟，揉天突1分钟，揉膻中1分钟，擦胸胁1分钟，揉肺俞2分钟，擦脊背1分钟，逆运八卦3分钟。

2. 随证配穴

(1) 寒喘

主要表现：面色晄白，或面色晦暗，四肢不温，吐痰清白，

舌质淡，苔白。

治法：温肺化痰，止咳平喘。

配穴：常用穴位加揉一窝风 2 分钟，揉外劳宫 2 分钟，推上三关 2 分钟。

兼有阳虚者面色青灰，肢冷，汗多，张口抬肩，端坐呼吸等，可加揉二马 2 分钟，补肾 2 分钟，补脾 2 分钟。

(2) 热喘

主要表现：大便干燥，痰稠而黄，舌质红，苔薄黄或黄腻。

治法：清肺化痰，止咳平喘。

配穴：常用穴位加清肺 5 分钟，清大肠 3 分钟，退下六腑 3 分钟，分推膻中 2 分钟，清补脾 2 分钟，清天河水 2 分钟，揉小横纹 1 分钟。

(3) 脾肾两虚

主要表现：面色晄白，神疲乏力，四肢不温，或动则心慌气短，汗出，舌质淡，苔薄白，脉细软。多为哮喘缓解期。

治法：益气补肾，止咳平喘。

配穴：常用穴位加清补脾 3 分钟，补肾 3 分钟，揉二马 2 分钟，推上三关 2 分钟，揉神阙 1 分钟，揉足三里 1 分钟。

预防护理

◎进行适当的体育锻炼和户外活动，多呼吸新鲜空气和进行阳光照射，以加强体质，减少发作。

◎避免受凉，防止感冒，随气候变化而增减衣服，尤其注意颈部、风池、风府、大椎、肺俞等部位勿着风受凉。

◎避免吸入烟尘和刺激性气体，家长吸烟应避开哮喘小儿。

◎饮食起居要有节制，不可过饮或过食肥甘和油腻食物以及生冷食物。

咽 炎

咽炎是指咽部黏膜、黏膜下组织和淋巴组织的感染性疾病。此病可由鼻炎向下蔓延所致，也可继发于上呼吸道感染之后，也有开始即发于咽部者，现代医学把它分为急性、慢性两种。急性咽炎反复发作、久治不愈或因环境某些因素的长期刺激，可能转换成慢性咽炎。

咽炎的致病因素多为病毒性感染为主，以腺病毒、副流感病毒和柯萨奇病毒引起者最多；细菌感染者以链球菌、葡萄球菌和肺炎双球菌为主；或为粉尘、烟雾和有害气体的刺激；长期张口呼吸及鼻涕后流，经常刺激咽部，损伤咽黏膜而患病。中医学认为本病多由风热邪毒侵袭咽喉，或胃腑郁热，上冲咽喉，或虚火上炎所导致。

诊断

急性咽炎起病急，初起时咽部干燥、灼热，继而出现咽痛，吞咽唾液时往往比进食时更为明显，唾液增多，全身症状一般较轻，可有发热、头痛、食欲不振和四肢酸痛等。转为慢性咽炎后，可出现咽部呈慢性充血，咽部可有各种不适感觉：如发痒、灼热、干燥、异物感等。分泌物黏稠，常附于咽后壁，声音嘶哑，常以晨起为重，声粗甚至失音。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

捏天突 30~50 次，揉 1 分钟，揉风府 1 分钟，揉大椎 1 分钟，揉合谷 1 分钟，清肺 2 分钟，掐少商 1 分钟，清肝 1 分钟，压肩井穴 1 分钟，揉曲池 1 分钟。

2. 随证配穴

(1) 风热型

主要表现：咽干，咽痛，咽部灼热，可伴有发热，微恶风或恶寒，时有咳嗽，痰黏难咳，舌边尖红，苔薄黄。

治法：疏风清热，解毒利咽。

配穴：常用穴位加清天河水 2 分钟，退下六腑 2 分钟，揉涌泉 1 分钟。

(2) 肺胃热盛型

主要表现：咽部红肿热痛，吞咽困难，伴高热，口渴饮水，咳嗽，咳痰黄稠，大便秘结，小便黄赤，舌质红，苔黄。

治法：清热泄火。

配穴：常用穴位加清肺延长至 3 分钟，清天河水 1 分钟，退下六腑 2 分钟，清胃 3 分钟，清大肠 2 分钟，推下七节骨 2 分钟，逆揉长强 1 分钟。

(3) 阴虚火旺型

主要表现：咽部不适，可有异物感，灼热，干燥，发痒，微痛等，可出现刺激性咳嗽，咳痰量少，气短乏力，或头目眩晕，腰膝酸软，耳鸣等，舌质光红，少苔。

治法：滋阴清热。

配穴：常用穴位加清天河水 3 分钟，揉三阴交 2 分钟，补肾 2 分钟，揉涌泉 1 分钟，揉肺俞、肾俞各 1 分钟。

预防护理

◎保持口腔卫生，培养良好的生活习惯，晨起、食后和临睡

前要刷牙漱口，睡前不要食糖果、糕点和甜饮料。

◎避免粉尘、烟雾及有害气体刺激。

◎忌食辛辣刺激性食物，多吃水果，如苹果、梨、萝卜等润喉利咽的食物。

◎锻炼身体，增强抗病能力，防感冒。

◎同时治疗原发病，如鼻炎、上感等。

头 痛

头痛在小儿时期并不少见，只不过有轻有重，有时为暂时性，有时为持续性或者反复发作。其部位及伴随症状均不相同，婴儿头痛不能诉说，往往表现为以手打自己的头或以头撞母怀，有时突然尖叫或烦躁不安，年长儿一般能说明头痛症状。诊断时必须结合病史、体征以及必要的化验及其他检查，然后综合分析才能查明头痛原因。中医认为头痛大多数是由感受风邪，痰湿蒙蔽清窍或气血虚弱，肝肾阴虚，肝阳上亢所致。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

头痛推拿法：推印堂2分钟，推头维1分钟，揉太阳1分钟，掐合谷1分钟，揉风池1分钟。

2. 随证配穴

(1) 风寒头痛

主要表现：头痛怕冷，发热，鼻塞，流清涕，舌淡，脉浮紧。

治法：疏风散寒，止痛。

配穴：常用穴位加揉一窝风 2 分钟，揉膊阳池 2 分钟，揉外劳宫 2 分钟。

（2）肝火头痛

主要表现：头痛连及两目，红肿热痛，时痛时止，痛无定时，鼻干，脾气急躁，易哭叫，有时大便干，小便黄。

治法：平肝泄火。

配穴：常用穴位加平肝 3 分钟，补肾 2 分钟，揉大椎 1 分钟，退下六腑 2 分钟，拿列缺 2 分钟。

（3）痰湿头痛

主要表现：头痛，眩晕，动则加重，时吐涎沫，胸闷，困倦乏力，嗜睡，舌淡，苔厚白腻。

治法：健脾利湿，通络。

配穴：常用穴位加清补脾 3 分钟，清小肠 1 分钟，推四横纹 1 分钟，揉足三里 2 分钟，顺运八卦 2 分钟。

预防护理

◎预防感冒和避开易感人群。

◎少吃辛辣食物，尽量减少小儿哭闹。

◎发烧小儿用手捶头或诉说头痛时，要及时到医院就诊，检查确诊后立即治疗。在采用推拿治疗时要注意，凡是器质性病引起的或急性传染病引起者不宜推拿治疗，外感性、血管性、神经性头痛为适应证。

呕 吐

呕吐是小儿常见病证之一。呕吐是由于食管、胃或肠道逆行性蠕动，并伴有腹肌强烈痉挛性收缩，迫使食管中或胃内容物从口鼻涌出。严重的呕吐可使患儿呼吸暂停，出现缺氧状态，如果护理不当，有呕吐物反流入呼吸道，可引起呼吸道感染或吸入性肺炎。有的反复呕吐，容易导致脱水，造成电解质紊乱、营养不良以及维生素缺乏。

本病的主要发病原因，是由于小儿脾胃虚弱，乳食不节，过食油腻或不易消化的食物，以导致胃不受纳，脾失运化，积滞中脘，升降失司，上逆而呕；脾胃素虚，过食生冷瓜果，凝滞胃府或因感受风邪，寒气上逆而吐；小儿喜食甜膩油煎之物，易导致热积胃中，气逆而吐；或因病后气阴不足，热伤津液，胃失濡养，不得润降而吐。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

顺运八卦3分钟，清胃2分钟，推板门1分钟，掐内关1分钟，逆揉巨阙2分钟，逆揉中脘2分钟，揉足三里2分钟，分腹阴阳1分钟，推天柱骨1分钟。

2. 随证配穴

(1) 伤食呕吐

主要表现：呕吐频繁，食后吐酸较重，吐出物酸臭，腹胀纳呆，口臭，午后低热，腹部发热较明显，或一侧颜面潮红，舌苔

厚腻。

治法：消食导滞，降逆止呕。

配穴：常用穴位加清大肠 2 分钟，退下六腑 2 分钟，推下承山 1 分钟，推下七节骨 1 分钟。

(2) 胃寒呕吐

主要表现：呕吐清水，并夹有不消化食物，喜热饮，怕冷，四肢发凉，朝食暮吐，或暮食朝吐（往往是早晨吃东西，下午或傍晚吐出来）。

治法：温中散寒，和胃止呕。

配穴：常用穴位加揉外劳宫 3 分钟，推上三关 2 分钟，补脾 3 分钟，推四横纹 2 分钟。

(3) 惊吓呕吐

主要表现：频繁呕吐，吐出物有黏液，烦躁，睡眠不安或睡中惊叫，大便色绿。

治法：镇惊安神，降逆止呕。

配穴：常用穴位加平肝 3 分钟，捣小天心 2 分钟，清天河水 2 分钟，拿内关 1 分钟，分推手阴阳 1 分钟。

(4) 热性呕吐

主要表现：呕吐酸臭，食入即吐，发热烦躁，口渴喜冷饮，大便干燥，小便黄。

治法：清热和胃，降逆止呕。

配穴：常用穴位加清大肠 2 分钟，退下六腑 3 分钟，推下七节骨 1 分钟，推下承山 1 分钟，清肺 2 分钟，清天河水 2 分钟，清小肠 1 分钟。

预防护理

◎节制饮食，不能过饱，要定时定量。

◎多食用含各种维生素和蛋白质的食物，少吃脂肪、甜食和油腻食物。

◎断乳后要逐渐增加辅助食品。

◎注意喂养方法，要少量频服，冷热适度，热症凉服，寒症热服。

◎经常推清胃，补脾，清补大肠，揉中脘，揉巨阙以和胃消食，降逆止呕。

婴幼儿腹泻

婴幼儿腹泻又称消化不良，是两岁以下小儿常见的一种消化道疾病。本病一年四季都可发生，而以夏秋季最多。

腹泻的主要原因是饮食不当，如突然改变饮食，饮食过饱，气候或环境突然变化，以及小孩受凉等，可引起肠胃蠕动增强，而导致腹泻；炎热季节可使胃酸及酶分泌减少，消化力减弱，从而导致腹泻；或是由于肠道内感染（如细菌、病毒感染），及肠道外感染（如上呼吸道感染、中耳炎、泌尿道感染等），均可使消化功能紊乱导致泄泻。

小儿得这种病为什么这么多呢？与小儿机体发育有一定关系。因为小儿生长发育迅速，新陈代谢旺盛，所需的营养物质相对较高，而肠胃功能相对薄弱，胃酸及各种消化酶分泌不足，加上中枢神经系统不能很好调节，失去了消化功能和营养需要的平衡而导致腹泻。中医认为婴幼儿腹泻的形成，主要是因为饮食、受寒、湿热、脾胃虚弱以及肠道功能失常所致。

诊断

◎轻型（单纯型腹泻）：腹泻每日5~6次，多的可达10余次，呈稀糊状，色黄或带绿，可有轻度的恶心呕吐，体温正常或稍高。

◎重型（中毒性）：腹泻次数增多，一般20次左右或更多，呈水样或蛋花汤样，以喷射状排出，体温较高（可达39℃左右），精神不振或烦躁不安，并伴有脱水和酸中毒症状。酸中毒一般表现精神萎靡，呼吸深而快，口唇樱桃红色，周围灰暗，呕吐较重。化验便常规，可查到不消化食物残渣和脂肪球，少数有白细胞。

治疗

1. 常用穴位及手法

顺运八卦3分钟，补脾3分钟，补大肠3分钟，运土入水1分钟，清小肠1分钟，推上承山1分钟，揉长强1分钟，推上七节骨1分钟，揉止泻灵1分钟。

2. 随证配穴

（1）伤食腹泻

主要表现：腹痛，腹胀，泻前哭闹，泻后疼痛减轻，大便酸臭，口臭，不愿饮食，食后呕吐，舌苔厚，脉沉滑。

治法：消食化积，和中止泻。

配穴：常用穴位加清胃3分钟，推四横纹2分钟，逆揉中脘2分钟。

（2）受寒腹泻

主要表现：大便稀并带泡沫，臭味较小，肠鸣腹痛，并伴有发热鼻塞，流清涕，轻咳，口不渴，舌淡红，苔白，脉迟，指纹

淡红。

治法：疏风散寒，止泻。

配穴：常用穴位加揉一窝风3分钟，推上三关2分钟，揉风池1分钟，揉外劳宫2分钟。

(3) 湿热泄泻

主要表现：大便如水，内夹不消化食物，色绿或黄，有少量黏液，大便次数显著增多，每日可达15~20次，尿少，肛门灼热、发红，舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿，止泻。

配穴：常用穴位加清补大肠2分钟，清补脾2分钟，退下六腑2分钟，逆揉神阙2分钟。

(4) 脾虚泄泻

主要表现：时泻时止或久泻不愈，大便有不消化食物残渣，多在饭后腹泻，先干后稀，面色萎黄或晄白，睡觉时两眼不能闭合，乏力，舌淡，脉弱无力。

治法：健脾止泻。

配穴：常用穴位加揉外劳宫5分钟，揉二马2分钟，揉神阙2分钟。

如果因受惊吓引起的腹泻，要平肝2分钟，掐小天心1分钟，掐五指节5遍。

伴有呕吐的要掐揉板门，推下天柱骨各2分钟；腹胀的推四横纹2分钟，揉足三里2分钟，揉天枢1分钟。

预防护理

◎加强身体锻炼，增强抗病能力，以适应外界环境的变化。

◎强调用母乳喂养，增添辅食不宜太快，品种不要太多，夏天或患病时最好不要断奶，喂奶要做到定时定量，并要注意饮食

卫生。

◎避免腹部受凉或感冒。

细菌性痢疾

细菌性痢疾，又称杆菌痢疾，中医称“下痢”、“寒痢”、“毒痢”等。本病是小儿常见的一种肠道传染病，由痢疾杆菌引起，临床以发热腹痛，里急后重及排泄物含有黏液和脓血样粪便为其主要症状。

细菌性痢疾的病因主要是食用被污染的食物引起的，其病理机制是由痢疾杆菌进入小肠，在碱性环境中很快繁殖产生的内、外毒素引起。内毒素从肠道内吸收后，对人体产生强烈刺激，能使血管发生痉挛，或发生其他过敏性状态，大肠黏膜的上皮受到损伤，发生卡他性炎症，形成浅表性溃疡，排出脓血便，形成痢疾。

此病多发生于夏秋季节，以1~3岁小孩最为多见。传播途径是病人或带菌者的粪便，还有粪便传染的衣物、用品、玩具等，通过手、食物、水或饮料传染。苍蝇带菌率也很高，易污染的用具及食物也是传播途径。中医认为主要是由误食不洁之物或感受湿热和寒湿之邪，蕴伏于肠胃，与气血相搏，肠道失于传导所致。

诊断

◎夏秋季节如小儿急性高热，体温达40℃左右，而一时找不出原因时，就应想到急性细菌性痢疾的可能。

◎如家庭中或邻居中有人最近正患痢疾要提高警惕。

◎除高热及一般全身症状外，体检与实验室检查均无阳性发现，应考虑痢疾。

◎发病初期有高热和神经症状，尚未排便，可用凉开水或冷盐水灌肠，取其粪便化验看是否有大量脓细胞或红细胞。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

清补大肠 5 分钟，退下六腑 3 分钟，推上三关 2 分钟，分腹阴阳 1 分钟，揉龟尾 2 分钟，推上七节骨 2 分钟。

2. 随证配穴

(1) 热痢

主要表现：大便为红色黏液状，腹痛，肛门灼热，舌红唇干，口干喜冷饮，小便短赤，伴有发热怕冷，舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿。

配穴：常用穴位加清天河水 2 分钟，清肺 2 分钟，捣小天心 2 分钟，清小肠 2 分钟，揉神阙 1 分钟。

(2) 寒痢

主要表现：下痢次数多，大便为白色黏冻，白多红少，腹痛肠鸣，面色苍白，口唇发青，口渴喜热饮，腹部喜热敷，小便清长，舌淡红，苔白。

治法：温中散寒。

配穴：常用穴位加揉外劳宫 3 分钟，揉神阙 2 分钟，推四横纹 2 分钟，补脾 2 分钟，逆运八卦 1 分钟。

腹痛较重者揉一窝风 2 分钟，揉中脘 1 分钟，揉天枢 1 分钟，拿肚角 20 次。

体弱多汗者揉内劳宫2分钟，补脾2分钟，揉二马2分钟。

小便清长者揉气海2分钟，补小肠2分钟，补肾2分钟。

预防护理

◎早到医院诊治，早隔离。

◎消灭苍蝇，做好粪便管理，保护水源，尤其要做好饮食卫生，吃饭前要洗手，并注意玩具的清洗和消毒。

◎病发期间要供给足够的水分和营养。

便秘

便秘是指不能按时排便，大便坚硬干燥，难以排出。便秘的原因：一是饮食不足，消化后余渣少，形成大便不足，奶液中糖量不足，使大便干燥，日久造成营养不良，腰部肌肉及肠部肌肉消瘦，推动无力；二是饮食中含蛋白质、钙化酪过高，如米粉、面粉等都可引起便秘；三是生活习惯不规律，不能按时排便；四是肛门局部畸形也可造成便秘。

诊断

排便次数减少，更主要的是粪便坚硬，以至排便困难。有时微带血液或黏液，排便时肛门有疼痛感觉，甚至有痔疮、脱肛，有的不能饮食，不敢排便而造成恶性循环，形成习惯性便秘。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

清大肠 2 分钟，揉中脘 3 分钟，摩腹 1 分钟，逆揉龟尾 2 分钟，推下七节骨 2 分钟，推下承山 2 分钟，揉迎香 1 分钟。

2. 随证配穴

(1) 肠热便秘

主要表现：大便干燥，小便黄，面色胀红，身热，口中气味酸臭，口干想喝水，舌红，苔黄燥，脉滑数。

治法：清热润燥，疏通气机。

配穴：常用穴位加退下六腑 2 分钟，清天河水 3 分钟，清胃 2 分钟，清肺 2 分钟。

(2) 虚寒便秘

主要表现：大便艰难，小便清长，腹中冷痛，喜热敷，四肢发凉，后腰部及两膝盖也发凉，舌质淡，苔白润，脉沉迟。

治法：温阳散寒，通便。

配穴：常用穴位加推上三关 3 分钟，揉外劳宫 2 分钟，清补脾 2 分钟，揉二马 2 分钟，清补肺 2 分钟，顺揉天枢 2 分钟，顺揉足三里 2 分钟。

(3) 气滞便秘

主要表现：暖气多，胸闷腹胀，两肋胀痛，甚则腹痛，大便干结，几日不解或欲便不能解出，苔薄白，脉弦。

治法：理气解郁，通便。

配穴：常用穴位加顺运八卦 2 分钟，推四横纹 2 分钟，分推手阴阳 1 分钟，分腹阴阳 2 分钟，逆揉天枢 2 分钟。

(4) 气虚便秘

主要表现：面色㿔白，语音低微，精神不振，头晕，心慌气短，大便不干燥，但不能解出，舌淡，苔白，脉细弱。

治法：养血益气，润肠通便。

配穴：常用穴位加补脾 3 分钟，补肺 2 分钟，揉足三里 2 分

钟，揉百会2分钟，补肾2分钟，揉二马2分钟。

如头晕气短则揉内关2分钟，推印堂1分钟，揉百会1分钟。

预防护理

◎养成按时排便习惯，大便干燥不能排出时，要让孩子精神放松，不可过度紧张。

◎多吃水果和含粗纤维的蔬菜，如芹菜、豆角等。

◎习惯性便秘，可常服蜂蜜、萝卜、梨、红薯等以润肠通便。

腹 痛

小儿腹痛是临床极为常见的一种疾病，涉及的范围很广，许多内外科疾病都可以引起腹痛，因为小儿的表达能力差，加之体征表现又不典型，故容易延误病情。同时，也给鉴别诊断带来一定的困难，所以对小儿腹痛，必须做到详细询问发病经过、腹痛性质和伴随症状，耐心检查疼痛部位及有关体征，并密切注意症状和体征的变化，协助医生尽早做出正确的诊断。

现代医学认为功能性腹痛常因单纯性的胃肠痉挛引起，如消化不良、蠕动紊乱、过敏性肠痉挛等；器质性病变腹痛持续时间较长，而且时间和部位固定不变，有压痛、肌紧张，如阑尾炎、肠梗阻、消化性溃疡等。有些器质性病变常以肠痉挛为诱因，如肠寄生虫、肠炎的黏膜病变、肠粘连以及腹部肿物等均可有肠蠕动或暂时痉挛引起腹痛，并阵发性增剧。

中医认为，本病为内、外病因所致，如六淫侵袭、乳食停滞和脉络瘀阻引起气机壅遏，经脉失调引起。

腹痛疾病较为多见，在急诊中也经常遇到，其病因较多，但难以诊断，所以要根据具体情况，尤其要排除外科疾病引起的腹痛方可推拿治疗。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

揉外劳宫 3 分钟，揉一窝风 2 分钟，摩腹 1 分钟，揉神阙 1 分钟，揉中脘 1 分钟，揉足三里 2 分钟。

2. 随证配穴

(1) 伤食腹痛

主要表现：饭后疼痛加重，腹胀而满，拒按，面色萎黄，纳呆食少，呕吐酸水，大便干燥，或便出不消化食物残渣，舌苔厚，脉滑数。

治法：消食导滞，理气止痛。

配穴：常用穴位加清胃 3 分钟，逆运八卦 2 分钟，推四横纹 2 分钟，清补大肠 3 分钟。

(2) 虚寒腹痛

主要表现：腹中疼痛较轻，得温则舒或疼痛缓解，得寒或受凉加重，喜热饮，喜俯卧，面色黄而发青，舌质淡，苔薄白，脉沉细。

治法：温中散寒止痛。

配穴：常用穴位加推上三关 3 分钟，顺揉天枢 2 分钟，拿列缺 2 分钟。

(3) 湿热腹痛

主要表现：腹胀拒按，胸闷，纳呆，口渴不欲饮，舌苔黄

腻，脉滑数。

治法：清利湿热。

配穴：常用穴位加清大肠 2 分钟，揉神阙 2 分钟，揉中脘 2 分钟，揉天枢 2 分钟，退下六腑 2 分钟。

(4) 气滞腹痛

主要表现：脘腹胀满，走窜不定或引起腹部两侧疼痛，胸闷暖气，舌苔薄，脉弦。

治疗方法：疏肝理气。

配穴：常用穴位加分腹阴阳 1 分钟，揉天枢 1 分钟，推四横纹 2 分钟。

(5) 瘀血腹痛

主要表现：痛如针刺，痛有定处，固定不移，或触之有块状物，推之不动，按之疼痛加重，有时昼轻夜重，口唇色暗，舌有瘀斑，脉细涩或弦滑。

治法：活血化瘀，行气止痛。

配穴：常用穴位加平肝 2 分钟，清补脾 2 分钟，揉三阴交 2 分钟，摩腹 2 分钟。

(6) 虫扰腹痛

主要表现：脐腹周围疼痛，时痛时止，往来上下，痛时高声啼叫，口喜吐涎及清水，且多在饭前疼痛。

治法：安蛔驱虫。

配穴：常用穴位加揉神阙 2 分钟，揉天枢 2 分钟，拿肚角 1 分钟，揉一窝风 1 分钟，捣小天心 1 分钟，顺运八卦、推四横纹各 1 分钟。

预防护理

◎注意饮食，不能饥饱无度，少吃冷食和不易消化食物及不

干净食物。

◎用热水袋敷脐，或把食盐炒热，用布袋装入，毛巾包裹敷脐上。

◎虫症引起腹痛要及时驱虫。

◎经常推揉中脘、神阙、外劳宫、一窝风预防腹痛。

◎保护腹部，切勿受寒受湿。

◎发现腹痛及早就医。

厌食

厌食是指小儿长期不思饮食和饮食不振之症，若患儿精神好，而病程较长者可见其面色少华，形体消瘦。但与疳积脾气急躁或精神萎靡等临床病象有所区别。本病城市儿童发病率较高，尤其是1~6岁小儿最为多见。由外感内伤等其他疾病引起的食欲不振，不属于本病范围。

中医认为本病主要是由于饮食没有规律、饥饱无度、或过食肥腻和冷食引起的。另外由于家长过分溺爱，贪食零食、偏食，以至损伤脾胃、不思饮食、食而无味。也有在乳幼期未及时添加辅食，断乳后突然改变饮食，令脾胃不能适应而引起厌食。现代医学认为小儿厌食与缺锌、铁、镁等微量元素有关。

诊断

不思饮食，见食即饱或食少腹胀，形体消瘦，时有恶心呕吐，身乏无力，但精神尚好。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

清补脾 3 分钟，清胃 3 分钟，清补大肠 2 分钟，揉巨阙 2 分钟，揉中脘 2 分钟，捏脊每日 1~2 次。

2. 随证配穴

(1) 脾失健运

主要表现：面色少华，不思饮食或食物无味，甚则拒食，形体偏瘦，而精神状态尚好。大小便正常，舌淡，苔白或薄腻，脉尚有力。

治法：健脾助运。

配穴：常用穴位加补脾 5 分钟，揉足三里 3 分钟，推上三关 2 分钟，清天河水 2 分钟。

(2) 胃阴不足

主要表现：口干多饮而不愿进食，皮肤及口唇干燥，大便干，小便多而黄，舌红少苔或光剥，脉细数。

治法：养胃育阴。

配穴：常用穴位加清天河水 5 分钟，补肾 2 分钟，揉三阴交 2 分钟，顺揉巨阙 1 分钟。

(3) 脾胃气虚

主要表现：精神不振，面色萎黄，厌食或拒食，若稍多进食，则大便中夹有不消化食物残渣或大便不成形，容易出汗，舌苔薄白，脉细无力。

治法：健脾益气。

配穴：常用穴位加补脾 2 分钟，清补肺 2 分钟，揉足三里 2 分钟，顺揉中脘 2 分钟，揉气海 2 分钟。

预防护理

- ◎要从小培养正常的饮食习惯，饮食要有规律，不可饥饱无度。
- ◎不要偏食、挑食，少食甜食和肥腻食物。
- ◎发现厌食及时治疗。

疳 积

疳积是指小儿脾胃虚弱，运化失常，消化吸收功能长期障碍导致的一种慢性消耗性疾患。与现代医学所称的营养不良症相类似，民间俗称“奶痨”。

本病多见于3岁以内的婴幼儿。本病形成的原因，主要是乳食无规律，积食伤脾；或喂养不当，造成营养失调；或慢性疾病造成。临床主要表现是形体消瘦，面色晄白无光泽，头发干枯无光，精神萎靡，腹部胀大，青筋显露，腹大如鼓，饮食异常，不仅影响小儿的生长发育，而且容易并发其他疾病，故应早期防治。

诊断

患儿面色萎黄或苍白，心烦易激动，饮食不振，形体消瘦，皮下脂肪减少，肌肉松软，头发干枯，体重不增或减轻，甚至智力迟缓，出现水肿和夜盲等现象。另外，还经常伴有其他慢性疾病，化验检查可见到程度不同的血色素和红细胞减少。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

顺运八卦2分钟，清胃2分钟，清补脾2分钟，清补大肠2分钟，揉中脘1分钟，捏脊1次，分腹阴阳半分钟，揉巨阙2分钟，揉足三里1分钟。

2. 随证配穴

(1) 伤食

主要表现：精神烦躁，夜间不能安睡，纳呆，腹胀，腹痛拒按，或呕吐食物残渣，或大便腥臭，小便混浊，或伴有发热，苔厚腻，脉滑数。

治法：消食导滞，和中健脾。

配穴：常用穴位加揉板门2分钟，清大肠3分钟，推下七节骨1分钟，推下承山1分钟。

呕吐者加配推下天柱骨2分钟。

(2) 积滞伤脾

主要表现：精神不振，烦躁不安，面色萎黄，乳食不进，或食后即饿，毛发干枯结穗，形体消瘦，头大颈细，腹部膨胀，脂肪消失，青筋暴露，舌质淡，苔腻，脉濡细。

治法：益气健脾，消食和胃。

配穴：常用穴位加退下六腑2分钟，摩腹1分钟，逆揉天枢1分钟，刮四缝1分钟，分腹阴阳1分钟。

(3) 气血两虚

主要表现：精神萎靡，睡眠露睛，食欲不振，便秘或便不消化食物，面色㿔白无光泽，形体干瘦如柴，四肢不温，哭声无力，舌质淡，少苔，脉虚无力。

治法：益气养血，健脾和胃。

配穴：常用穴位加补肾2分钟，补脾3分钟，推上三关1分钟，揉三阴交2分钟。捏脊1天1次，刮四缝1天1次，每次10~20遍。

预防护理

◎早期诊断，如发现小儿体重减轻，应及时检查和治疗。

◎合理喂养：尽量由母乳喂养，喂养方法应按小儿不同月龄，定时定量给予乳食，婴幼儿2~3个月消化能力较好的，可以逐渐加辅食，以先素后荤，先少后多为原则。一岁左右可断乳，可食易消化、营养丰富的食物。

◎锻炼身体，经常到户外活动，呼吸新鲜空气，多晒太阳，增强体质。

口 疮

口疮是指口腔内、口唇、牙龈、舌、颊、上颚等处黏膜出现淡黄色或白色的小溃疡，单个或多个不等，呈椭圆形，周围红晕，表面局部灼痛，反复发作，重者影响进食。根据发生部位不同命名亦不同，发生在口唇两侧者，称为“燕口疮”；满口糜烂，色红作痛者，称为“口糜”。

本病发病原因，主要是由于口腔不洁，感染单纯疱疹病毒或细菌所致。中医认为，主要是脾胃积热，心火上炎或虚火上炎所致。

诊断

溃疡点多发生于颊内、唇内或牙龈，也可波及舌和软腭。局部疼痛，拒食，颌下及颈前淋巴结肿大，甚则体温高达 $39 \sim 40^{\circ}\text{C}$ 左右。如果是疱疹性口腔炎，先是圆形滤泡，继而破裂成溃疡，全身症状较轻微；而急性溃疡性口腔炎，溃疡点分散或连接成片状，溃疡面上有灰白色或暗灰色的假膜，全身症状较重。

化验检查：血中白细胞常有增高，但疱疹性口腔炎血中白细胞往往偏低。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

清天河水 5 分钟，清心 2 分钟，揉小横纹 2 分钟，推四横纹 1 分钟，清板门 1 分钟，退下六腑 1 分钟，揉二马 1 分钟，补肾 2 分钟。

2. 随证配穴

(1) 脾胃积热

主要表现：唇舌或颊内、牙龈等处黏膜红肿疼痛，满口糜烂或形成散在的大小不一、数目不等的黄白色溃烂点，少则五六个，多则十余个，有的融合成片，边缘鲜红，伴有发热，烦躁，口臭，流口水，口渴，小便短黄，大便干燥，舌红，苔黄，脉滑数有力，指纹紫滞。

治法：清热解毒，通便泻火。

配穴：常用穴位加清大肠 3 分钟，清胃 3 分钟，清脾 2 分钟。

(2) 虚火上炎

主要表现：口腔溃疡较少，表面黄白色，周围颜色淡红，神

疲乏力，两颧发红，口干不渴，舌红少苔，脉细数。

治法：滋阴降火。

配穴：常用穴位加清小肠3分钟，推下七节骨2分钟，揉三阴交2分钟，清肺2分钟。

预防护理

◎多喂新鲜蔬菜末或菜汤，多饮水。

◎避免过烫、过咸饮食。

◎发病期间忌食辛辣食物。

鹅口疮

该病在口腔、舌上满布白屑，形似鹅口，故名“鹅口疮”。本病多见于新生儿或体弱多病、营养不良的婴幼儿，如长期应用广谱抗生素，也容易发生此病。此病主要是感染白色念珠菌引起的。中医认为由于患儿的心、脾、胃三经积热，或先天胎热内壅，或口腔不洁，感染秽毒之邪所致。

诊断

舌上或两侧颊黏膜上出现白屑并逐渐增大，互相融合，状如凝固的奶瓣，不易擦去，重擦时可见粗糙面。白屑周围红晕，口水增多，哭闹不安，并且拒食。

化验检查：取白色块状物，用10%氢氧化钾一滴镜检，可见霉菌丝状体及芽孢。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

清脾 2 分钟，揉小横纹 2 分钟，揉小天心 2 分钟，推四横纹 2 分钟，清天河水 2 分钟，退下六腑 2 分钟。

2. 随证配穴

(1) 心脾积热

主要表现：口腔黏膜白屑堆积较多，周围焮红较重，面日和口唇发红，烦躁不安，吃奶时哭叫，大便秘结，小便黄少，舌质红，苔白厚腻，指纹紫滞，脉滑数。

治法：清热解毒，泻火清脾。

配穴：常用穴位加清大肠 2 分钟，清肺 2 分钟，推下七节骨 2 分钟，推下承山 1 分钟，平肝 2 分钟。

(2) 虚火上浮

主要表现：口腔黏膜白屑散在，周围焮红不重，形神怯弱，两颧发红，手足心热，口干不渴，或低热盗汗，舌质红，少苔，脉细数无力。

治法：滋阴降火。

配穴：常用穴位加揉二马、补肾各 2 分钟，平肝 2 分钟，揉三阴交 2 分钟，揉足三里 2 分钟。

预防护理

◎积极防治常见病，增加小儿营养。

◎保持口腔卫生。

◎注意不要乱用抗生素。

流 口 水

流口水，又名“流涎”、“滞颐”，即小儿口中经常流涎，浸渍下颌及胸前，不仅衣服常被涎水浸湿，而且口腔周围易有粟红疹及糜烂。患儿大多饮食和精神良好，故引不起家长重视。患有口疮和口疳的小儿常有流涎现象，需与病理性流涎鉴别。

中医认为滞颐的病因有二：一是脾胃虚寒，不能收摄其津液，以至不断流涎；二是脾胃积热，廉泉不能制约而涎自流，所谓胃热即廉泉开，故而涎下。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

清补脾5分钟，清胃3分钟，清补大肠2分钟，揉二马2分钟，补肾2分钟，揉足三里2分钟，揉中脘2分钟。

2. 随证配穴

(1) 脾胃积热

主要表现：面赤唇红，舌赤边有口疮，口水有臭味，大便干，小便黄赤，舌红，苔黄，脉数。

治法：清热泻火。

配穴：常用穴位加清脾5分钟，退下六腑3分钟，清大肠2分钟。

(2) 脾胃虚寒

主要表现：面色萎黄或晄白，腹冷，肢凉，唇舌色淡，口气清冷，饮食纳呆，大便完谷不化。

治法：温中散寒。

配穴：常用穴位加揉外劳宫 5 分钟，揉一窝风 2 分钟，顺运八卦 2 分钟，揉膊阳池 2 分钟，顺揉神阙 2 分钟，推上三关 2 分钟。

预防护理

◎注意防寒冷和内热。

◎及时擦干下颌部涎水，以防感染其他疾病，尤其冬季更应如此。

遗 尿

遗尿是指 3 周岁以上的小儿，在睡眠时不能正常排尿的一种病态，可发生于夜间、白日或日夜兼有，其中以夜间遗尿为最多。

多数病儿是由大脑皮质及皮质下中枢功能失调引起功能性遗尿，少数是由蛲虫病、脊柱裂、泌尿生殖畸形及大脑发育不全等引起的。常见的诱因，一是白天过度疲劳，平时没有得到适当训练；或因受到指责和环境改变使小儿精神紧张诱发。中医认为该病是下元虚寒、肝经实热、脾肺气虚等影响了膀胱的气化功能，使膀胱约束失常所致。

诊断

◎夜间不自觉排尿，轻者数日 1 次，重者昼夜遗尿 1~3 次或者更多。

◎小孩体质虚弱，精神紧张，日间尿频或嬉戏、游玩过多，睡时不易叫醒。

◎尿常规检查，均在正常范围。

◎排除器质性疾病，视孩子是否包皮过长或尿道口炎，女孩外阴有无分泌物，并注意有无蛲虫等。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

揉丹田2分钟，揉关元2分钟，揉气海2分钟，揉龟尾1分钟，揉三阴交2分钟，补肾2分钟，揉二马2分钟，清小肠1分钟。

2. 随证配穴

(1) 下元虚寒

主要表现：每次睡眠都遗尿，一夜2~3次或更多，并多数伴有面色发白，智力迟钝，腰酸肢冷，小便清长，大便稀，怕冷，喜暖，舌淡，脉沉无力。

治法：温补肾阳，固摄下元。

配穴：常用穴位加顺揉神阙2分钟，推上三关3分钟，揉外劳宫2分钟，揉膊阳池2分钟，揉丹田2分钟。

(2) 肝经实热

主要表现：睡中遗尿，小便黄赤、味大，性情急躁或夜间咬牙，面目和口唇红赤，舌苔薄黄，脉弦滑。

治法：泻肝清热。

配穴：常用穴位加清肝5分钟，清小肠3分钟，清肺2分钟，分推手阴阳1分钟。

(3) 脾肺气虚

主要表现：多发生于病后，睡中遗尿，但尿频尿少，面色晄

白，神疲倦怠，四肢乏力，食欲不振，大便清稀，舌淡，脉细弱无力。

治法：培元益气，收敛固涩。

配穴：常用穴位加补脾2分钟，补肺2分钟，推上三关2分钟，揉百会2分钟，揉四神聪1分钟，揉中脘1分钟，揉足三里1分钟。

预防护理

◎自幼培养孩子按时排尿，白天切勿让孩子过度疲劳。

◎积极预防与治疗引起遗尿的原发疾病。

◎晚饭及睡前少饮流食，少喝水。

◎临睡前患儿排空小便，入睡后注意遗尿的时间，按时唤醒排尿。切勿使小儿精神紧张，更不能打骂和歧视小儿，要培养小儿战胜疾病的信心和决心。

脱肛

脱肛是指肛管、直肠向外翻出，脱垂于肛门之外，所以又称“直肠脱垂”。它是因长期咳嗽、久泻久痢、大便秘结和干燥引起的，若不及时治疗，长期不愈，可使真气耗损，肛门愈加松弛，以至形成脱而不收的难治之症。

诊断

每逢大便时肛门脱出，轻者便后能自动收回，重者精神萎靡，食欲不振，或有盗汗，体弱无力，直肠脱出不收，肿痛不堪等。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

揉气海3分钟，揉天枢2分钟，顺揉龟尾2分钟，推上七节骨2分钟，揉外劳宫3分钟，补脾2分钟，补肾2分钟。

2. 随证配穴

(1) 体弱气虚者配揉百会2分钟，补肺2分钟，补大肠2分钟，摩腹1分钟，推上三关和拿肩井各2分钟，以补中益气升提。

(2) 大便秘结者配清脾2分钟，清胃2分钟，清大肠3分钟，退下六腑3分钟，推下七节骨、推下承山各1分钟。

(3) 食欲不振和恶心呕吐者配清胃2分钟，揉板门2分钟，推天柱骨2分钟。

(4) 盗汗体弱无力易疲乏者配揉二马2分钟，捣小天心2分钟。

预防护理

◎改变不正常的大便习惯，保持大便通畅。

◎多吃带纤维的蔬菜，便干病人平时经常服用蜜水和润肠通便药。

◎经常揉腹，推下七节骨，揉迎香可免除便秘。

◎因直肠畸形引起的脱肛应请外科医生手术治疗。

肠套叠

肠套叠是指一段肠管套入与其连续的或相邻近的肠管腔内，

而造成的肠腔梗阻。是小儿常见的急腹症。多发生于2岁以内的男性幼儿，尤以5~10个月的肥胖婴儿多见。其原因，中医认为“肠为传化之府”，有传送、消化、转输水谷精微之功能。肠的生理特点，以通降下行为顺，滞塞上逆为病，不论气血、寒热、湿、食、虫等原因造成的通降功能失调，使肠道气血痞结而发病。现代医学认为：断奶后，常由食物性质改变或其他因素造成肠蠕动紊乱所致。可发生于结肠或小肠的任何部位，其中以回—盲型或回—结型最多见。因上部肠管及肠系膜嵌入下部肠管，静脉受压，引起嵌入肠管瘀血、水肿及黏液分泌，使毛细血管破裂而出血，导致坏死，重者可因休克或并发腹膜炎造成死亡。

诊断

阵发性腹痛，在脐周或右下腹突然剧烈作痛，突发大哭，面色苍白，出汗，下肢挛缩，呕吐以初时为甚，腹胀，在右腹部或升、横结肠有肿块，大便不通。病情进一步发展，可有脱水、电解质紊乱、休克等现象。

治疗

逆揉中脘2分钟，揉神阙3分钟，揉气海1分钟，摩腹3分钟，揉三阴交2分钟，清大肠2分钟，顺运八卦1分钟，推下承山2分钟，逆揉长强1分钟，逆揉龟尾1分钟，揉天枢1分钟，捏肚角20遍。

预防护理

◎未明确诊断之前，不要随便使用解痉止痛药，如颠茄类药物等，以免掩盖病情，耽误治疗。

◎本病来势急，小儿不能自诉，容易误诊，一旦发现小儿剧

烈哭闹，大便秘或带血，应立即到医院就诊检查，确诊后，根据情况再选择推拿与否。

◎严重的肠套叠必须手术治疗。

◎注意饮食卫生，进食要定时定量，勿暴饮暴食及过食生冷、寒凉之品。

◎注意保暖，保护腹部，勿受潮湿。

近 视 眼

近视眼是指患者不能远视或远视力不好的一种常见病症。多由于患者用眼不当所致，如躺着看书，或室内光线太弱，看书距离太近。本病也有一定的遗传性。现代医学一般把本病分为假性近视和真性近视两种。假性近视是因眼睛的调节功能失常所致，多见于学龄儿童。真性近视又叫轴性近视，是眼球的前后径较正常为长的现象。假性近视如果长时间得不到有效的纠正，也会形成真性近视。中医学称为“能近怯远”症。认为主要由于先天禀赋不足，肝肾亏虚所致。

诊断

远视时视物模糊，近视清楚，但近视过久也会出现眼睛发胀，头部疼痛，视力疲劳等症状，高度近视者眼球较为突出。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

(1) 从印堂沿眉向两侧分推至太阳穴处，反复操作1~3分

钟。

(2) 从内眼角经下眼眶轻揉至太阳穴，反复操作 10~20 次。

(3) 揉太阳穴、攒竹、睛明、四白、鱼腰穴各 1 分钟，揉风池 20 遍，揉肝俞、肾俞各 1 分钟。

2. 随证配穴

(1) 双目干涩，眼睛胀痛者，配揉百会穴 1 分钟，补肾、补肝各 2 分钟。

(2) 体质较差，脾胃虚弱者，配揉脾俞、胃俞穴各 1 分钟，揉中脘 1 分钟，揉气海 1 分钟，揉足三里 2 分钟，拿肩井 20 次。

预防护理

◎要注意用眼卫生，纠正不正确的用眼姿势，看书、写字时要注意光线。

◎锻炼身体，经常做眼保健操。

小 儿 疝 气

小儿疝气是指小腹疼痛牵引睾丸肿痛而言。中医认为大多是由于肝肾不足或中气下陷，坐卧湿地风冷入腹，阴寒内盛或湿热郁结，肝经不舒和小肠阻结所致。

诊断

腹股沟的一侧有光滑整齐和稍带弹性的可复性肿物（能用手扶回去的肿物）。当小儿哭闹站立或用力时，肿物出现并增大，且有膨胀性冲击感，平卧后逐渐缩小，直至完全消失。也可

用手指向上轻压肿物，协助肿物回入腹腔。复位时可听到有气通过的水声。如果复位时小孩咳嗽，并有冲击感，手离开后，肿物往往又重新出现。化验检查一般正常。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

捣小天心 5 分钟，平肝 2 分钟，补肾 2 分钟，补脾 2 分钟，揉外劳宫 2 分钟，清小肠 2 分钟，揉二马 2 分钟。

2. 随证配穴

(1) 寒疝

主要表现：阴囊肿硬而冷，并牵引小腹作痛，遇热时疼痛缓解，遇冷时疼痛加重，并伴哭叫不安，面色青白，唇舌淡白，脉迟或沉紧。

治法：温经散寒，行气止痛。

配穴：常用穴位加推上三关 2 分钟，揉神阙 2 分钟，揉气海 2 分钟，推上七节骨 2 分钟。

(2) 气疝

主要表现：阴囊偏坠，肿痛或不痛，每哭则发，发则下坠。

治法：疏肝理气。

配穴：常用穴位加顺运八卦 2 分钟，推四横纹 2 分钟，揉神阙 2 分钟，揉百会 2 分钟，揉四神聪 1 分钟。

(3) 湿热疝（又称水疝）

主要表现：阴囊红肿，或状如水晶，时时胀痛，烦躁啼哭。

治法：清热渗湿。

配穴：常用穴位加退下六腑 3 分钟，清大肠 2 分钟，揉气海 2 分钟，揉丹田 2 分钟，揉足三里 2 分钟，清天河水 2 分钟。

如外感风寒引起的鼻塞、流涕等，应加揉一窝风和推上三关

各1分钟。

预防护理

- ◎避免或减少小儿哭闹。
- ◎避免坐卧湿地，注意局部保暖。

惊 风

惊风又称惊厥，是小儿科常见的急症。其原因主要由于大脑功能暂时紊乱所致。由于小儿的神经系统尚未发育成熟，兴奋容易扩散，故容易发生惊厥。另外如产伤、脑发育畸形、先天代谢异常等疾病，也是引起惊厥的原因之一。高热及中枢神经感染，在小儿中多见，尤其是婴幼儿发病率更高，它的表现是周身或局部肌肉抽搐，并伴有意识丧失。如惊厥发作持续时间较长时，由于全身肌肉抽搐，血压升高，可导致高热、缺氧、颅内压增高，甚至发生窒息死亡。

中医把惊风分为急惊风和慢惊风。认为急惊风主要为感受邪毒，化热化火，热极生风，风火相煽，引起肝风内动而抽。慢惊风则是由于急惊风经治不愈，热性病或久吐久泻之后，脾胃受伤，津液亏损，肝血不足，筋失所养，虚风内动所致。

诊断

意识丧失，两眼珠固定或上翻、斜视，头转向一侧或后仰，口吐白沫，面部及四肢肌肉呈强直性或痉挛性抽动，并常伴有屏气。惊厥时间长者面色青紫，部分小儿会大小便失禁，一般经数

秒钟至十余分钟后自止，继而进入昏迷。少数抽搐短暂者意识清楚。发热的小儿若精神恍惚，频繁惊跳及肌肉紧张，常是惊厥的先兆，应及时服用退热镇静药，以防发生惊厥。婴儿入睡后有局部小肌肉抽动，有时熟睡欲醒未醒时手足乱动都属于正常现象，不要误以为是惊厥。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

掐人中2分钟，拿肩井1分钟，掐涌泉穴1分钟；掐五指节各5次，掐精灵、威灵各1分钟，拿列缺、掐小天心各2分钟，拿委中、掐合谷各1分钟，或到抽止为止。

以上穴位，一人操作时要一手掐人中不动，另一手轮流掐其余穴位，若有助手可同时连续操作，直至抽止，神志清醒。

2. 随证配穴

(1) 急惊风

主要表现：烦躁不安，牙关紧闭，手足抽搐，或有高热，呼吸急促，项背强直，两目上视等。

治法：疏风清热，豁痰开窍。

配穴：常用穴位加清心1分钟，清肺2分钟，清肝2分钟，推上三关2分钟，退下六腑2分钟，清天河水2分钟，按天突、推天柱骨、擦脊各1分钟。

外感风寒加揉一窝风、外劳宫各1分钟，喉鸣痰多者加揉小横纹1分钟，逆运八卦2分钟，分推膻中1分钟。

(2) 慢惊风

主要表现：形神疲惫，睡卧露睛，面色萎黄，肢冷便溏，手足心热，呼吸微弱，前囟门凹陷或凸起，摇头拭目，似抽非抽或手足蠕动。

治法：补肾健脾，益气固本。

配穴：常用穴位加补脾5分钟，补肾2分钟，揉二马2分钟，揉中脘2分钟，揉神阙2分钟，捏脊每日1次。

预防护理

◎首先将患儿平放，头侧卧，解松衣领，并用多层纱布包裹压舌板，此时将压舌板放在上下牙齿之间，以防咬破舌头。

◎保持呼吸道通畅，必要时给氧，吐出咽喉分泌物及痰涎，以防阻塞呼吸道引起窒息。

◎保持室内安静，密切观察，注意呼吸、脉搏、体温、血压、瞳孔和面色的变化。

◎及时预防各种感染与中毒。

◎高热患儿要及时予以退热。

夜啼

夜啼是小儿白天安静，入夜啼哭或每夜定时啼哭。本病应与其他疾病，如各种皮肤病、佝偻病、疝气、蛲虫病等身体不适或瘙痒等引起的哭叫加以区别。另外，也应与护理不当引起的夜啼相区别。夜啼是儿科常见病，故有人称为“夜啼郎”。

夜啼的发生主要有以下几种原因：

◎脾寒：小儿脾常不足，喜温恶寒，若护理不周，腹部中寒或乳母食生冷食物，或用冷乳喂儿，入于肠胃，均使寒邪内侵，脾寒内生，夜间属阴，重阴脾寒，寒邪凝滞，气机不畅，故入夜腹痛而啼。

◎心热：小儿心肝有余而脾肾不足，心属火，易生心热，若积热上攻，则邪热扰心。因心属火，恶热，故见灯火则啼。

◎阴血亏虚：血不养肝，阴虚内热，虚烦不眠而啼。或热病伤阴，阴虚内热，烦躁不眠而啼。

◎惊吓：小儿心气怯弱，若护理不当，突见异物，耳闻异声，不慎跌扑均可引起心神不宁而哭。

诊断

◎长期夜间啼哭，不得安睡，少则数日，多则数月，但日间嬉戏如常，睡眠较多。

◎有腹部受寒或过食油煎之物，或有暴受惊恐史。

◎小儿体质虚弱，多在疾病之后发生。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

补脾 3 分钟，清心 2 分钟，清肝 2 分钟，揉小天心 2 分钟，揉外劳宫 2 分钟，分推手阴阳 1 分钟，清天河水 1 分钟，揉足三里 1 分钟，摩腹 1 分钟。

2. 随证配穴

(1) 脾胃虚寒

主要表现：睡喜伏卧，曲腰而啼，四肢欠温，食少便溏，面色清白，唇舌淡白，脉沉细。

治法：温脾散寒。

配穴：常用穴位加推上三关 3 分钟，揉膊阳池 2 分钟，揉神阙 2 分钟，揉中脘 2 分钟。

(2) 心经有热

主要表现：睡喜仰卧，见灯火则啼哭极甚，烦躁不安，小便

短赤，大便秘结，面赤唇红，舌质红，脉数。

治法：清心泄热。

配穴：常用穴位加退下六腑3分钟，清大肠2分钟，清小肠2分钟，清肺3分钟，清天河水2分钟，推下七节骨2分钟。

(3) 惊吓

主要表现：睡中时而惊恐，唇面乍青乍白，紧偎母怀，夜间脉弦而数，指纹青紫。

治法：镇惊安神。

配穴：常用穴位加补肾2分钟，分推手阴阳2分钟，揉膊阳池2分钟，拿列缺1分钟，掐威灵1分钟，掐精灵1分钟。

预防护理

①首先应从生活护理上找原因，如饥饿、过饱、闷热、寒冷、虫咬、尿布浸湿、塑料布或毛线衣料刺激肿痛、肿痒等，均可致小儿啼哭。

②若小儿想让亲人扶抱或所欲不得，或见灯光啼哭即止，此为拗哭，并非病态。

营养性贫血

营养性贫血是指因缺乏生血所必需的营养物质，如铁、叶酸、维生素 B_{12} 等，使血红蛋白的形成或红细胞的生成不足，以至造血功能低下的一种疾病。多发生于6个月至2岁的婴幼儿。

现代医学把本病分为小细胞性贫血及大细胞性贫血两种。前者也叫缺铁性贫血，多发生于6个月至1岁的小婴儿。其主要原

因是由于婴儿生长发育快，需铁量很多，而人乳和牛乳含铁量都很低，不能满足婴儿的生长需要，此时若未及时添加辅食，就会发生缺铁性贫血。后者也叫巨幼红细胞性贫血，多发生于2岁以下的小儿，主要是由于小儿饮食中的维生素 B_{12} 与叶酸的含量不足，或肠道细菌合成量不足，使红细胞成熟的因素缺乏而发病。中医学把本病归属“虚劳”、“血虚”等范畴。认为血液的生成主要依赖于脾，其根本在于肾、心、肝。如果脾胃虚弱，不能运化水谷精微，气血生化之源不足，产生贫血。血虚五脏失养，便可能出现心血不足，肝肾两亏等症。

诊断

◎起病较缓慢，轻者表现为皮肤、黏膜苍白或苍黄，以口唇、牙床、眼睑、指甲等部位更为明显。

◎严重贫血时可见头晕，全身乏力，烦躁不安，食欲不振等，患儿往往伴有营养不良。

◎有的患儿嗜食异物，如吃土块、煤渣、墙泥等。贫血过久，可导致生长发育障碍。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

顺摩腹部1~2分钟或以热为度，揉中脘2分钟，揉足三里、三阴交穴各2分钟，捏脊1日2遍，补脾3分钟，揉脾俞、胃俞各1分钟。

2. 随证配穴

(1) 脾胃虚弱型

主要表现：面色苍白或蜡黄，食欲不振，疲倦无力，活动后气促，大便溏薄，舌质淡，苔薄。

治法：健脾和胃。

配穴：常用穴位加揉板门2分钟，推四横纹1分钟，揉外劳宫1分钟，推上七节骨1分钟。

（2）心脾两虚型

主要表现：面色萎黄，神疲乏力，食欲不振，心悸气短，睡眠不安，或有头昏、皮下出血及浮肿等。舌质淡，苔薄白。

治法：健脾养心。

配穴：常用穴位加补心2分钟，以掌横擦胸上部，以透热为度。揉膻中、内关、心俞各1分钟。

（3）肝肾阴虚型

主要表现：低热或五心烦热，两颧嫩红，盗汗，头晕，耳鸣，腰膝酸软，口舌干燥，指甲无光泽，舌质淡，苔少。

治法：滋水平肝。

配穴：常用穴位加平肝3分钟，补肾2分钟，揉肝俞、肾俞各1分钟，搓擦涌泉穴2分钟，揉阴陵泉、太溪各1分钟，揉太冲1分钟。

（4）脾肾阳虚型

主要表现：面色㿔白或苍白，口唇色淡，畏寒肢冷，精神困倦，食欲不振，大便溏薄，身体消瘦，心慌气短，活动后加重，舌淡，舌体胖嫩，苔薄。

治法：温肾健脾。

配穴：常用穴位加补肾2分钟，推上三关1分钟，揉外劳宫1分钟，揉肾俞、太溪各1分钟，横擦命门穴，以透热为度。

预防护理

◎患儿居住环境要安静，空气要新鲜，可适当安排室外活动和体育锻炼。

◎注意营养，对缺铁性贫血患儿多给含铁和蛋白质的食品，如鸡蛋、瘦肉、肝、绿叶蔬菜、豆浆等。

◎贫血患儿大都抵抗力下降，因此要特别注意避免接触有传染病和急性感染性疾病的人。

◎在推拿的同时可配合中西药物以提高疗效。

◎对严重贫血的患儿，要及时送医院治疗，以免延误病情出现危险。

鼻 衄

鼻衄又称鼻出血，是一种常见的症状。它的原因很复杂，许多疾病都可引起鼻衄。鼻衄是较危险的病症，因为它可能导致严重的后果，如出血过多就会出现贫血、虚脱，甚至死亡。

祖国医学认为产生鼻衄的原因有以下几种：

◎外感六淫化火，伤其脉络，热气浮越，迫血上行，循经脉而行于鼻，引起出血。

◎五脏功能失调，如心失主血，肝失藏血，脾失统血，肾失藏精和脾不主气，导致出血。

◎中毒出血，药物和其他物品中毒，可伤及脉络而出血。

鼻衄虽说是许多疾病的共同症状，病因很多，但其发病机理总属气火逆乱，血不循经，脉络损伤，血溢于外。实证为气火亢盛，血热妄行。虚证有二：一是阴伤，虚火妄动，灼伤血络；二是气虚不能摄血，离经外行。

现代医学认为，鼻黏膜干燥，鼻中隔弯曲，表浅小动脉破裂以及血液病等都可引起鼻出血。

诊断

◎鼻衄出血量多，来势猛，血鲜红多为实证。血量少，血流缓慢，血色较淡者多为虚证。

◎如出血量多和出现头晕、心慌、气短、汗出、肢冷、面色苍白、虚烦不寐等症时，有可能虚脱，需密切观察病情变化。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

揉按天庭（头部正中线，入前发际0.5寸）2分钟，揉膊阳池2分钟，补肾2分钟，分推手阴阳2分钟，清板门2分钟，退下六腑2分钟，揉三阴交2分钟，清肺5分钟，清天河水2分钟。

2. 随证配穴

（1）燥证

主要表现：鼻黏膜干燥，鼻中隔黏膜粗糙，甚至破裂、弯曲或者干痂皮层堆积，口唇干燥，便秘，舌红少苔或干燥。

治法：润肺生津，凉血止血。

配穴：常用穴位加补肾2分钟，揉二马2分钟，揉足三里2分钟。

（2）火证

主要表现：烦热，口干渴，大便秘结，小便黄赤，舌苔黄腻糙厚，脉弦数或洪大，属于实火。

治法：清热凉血，以止血为主。

配穴：常用穴位加平肝3分钟，清大肠2分钟，推下七节骨2分钟。

（3）气虚证

主要表现：鼻黏膜大多苍白，出血为渗出性，每次出血量不多，但频频反复不休，鼻中隔常无明显出血点，病程较长，面色苍白，神疲乏力，四肢稍重，头晕，食欲不振，大便偏稀，舌淡胖嫩，苔花剥。

治法：补脾摄血。

配穴：常用穴位加补脾2分钟，补肺2分钟，揉中脘2分钟，揉足三里2分钟。

本病以实证为多，常用清热泻火法。虚证较少，多以补气摄血为法则。

预防护理

◎因鼻黏膜干燥破裂引起的出血，应常戴口罩，保持一定程度的湿润。

◎纠正挖鼻孔的不良习惯。

◎禁用热水洗面，但可用热水洗脚，尤其在出血时。

◎增加营养，但禁忌辛辣食物，哺乳婴儿和乳母同样忌口，较大的儿童要多吃水果，尤其是藕，有凉血止血作用。

◎夏天不宜怀抱婴幼儿，最好半坐于阴凉地方。

◎经常用薄荷油滴鼻，以防鼻黏膜干燥。

婴幼儿手足搐搦症

婴儿手足搐搦症又称“低钙性惊厥”，多见于半岁以下的婴儿，以手足搐搦或全身抽搐为特征。现代医学认为，其发病与维生素D缺乏有密切关系，血钙过低是形成本病的主因。年龄越

小发病率越高，以春季多发，且常与母乳喂养不足有关。祖国医学认为，本病主要由于先天不足，加上后天失养，以至脾肾两亏，精气血生化之源不足，肝不藏血，筋脉失去濡养，肝风内动而发病，或因感冒发热时而诱发病。

诊断

手足搐搦及惊厥，发作频繁，但发作缓解后如正常儿，每因外感与惊恐而引起发作，常出现面色苍白，神疲乏力等症。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

平肝2分钟，清天河水、退下六腑各2分钟，拿肩井、掐人中、合谷、涌泉各1分钟，拿委中、阳陵泉、承山各1分钟。

2. 随证配穴

(1) 肝风内动

主要表现：起病较急，两目上视，神志不清，全身或四肢抽搐，持续数秒或数分钟，每日发作次数不等，少则数次，多则几十次，缓解后如正常儿。面色青红相兼，口唇干，舌质淡，苔白。

治法：柔肝熄风。

配穴：常用穴位加掐十宣、五指节、威灵、精灵，以清醒抽止为度，然后补肾、补脾各2分钟。

(2) 血虚生风

主要表现：四肢抽搐不安，时发时止，伴有面色苍白，精神疲倦，食欲不振，唇甲色淡，全身乏力，汗多，舌质淡，苔薄白。

治法：益气养血，祛风解痉。

配穴：常用穴位加补脾3分钟，揉足三里2分钟，揉三阴交1分钟，揉一窝风1分钟，揉板门1分钟，推上三关1分钟，捏脊3~5遍。

预防护理

◎周围环境要安静，减少不必要的刺激，尤其是突然的刺激会引起抽搐。

◎居室内要冷暖适宜，随着气候的变化，要及时地增减衣被，防止外感风邪。

◎除推拿外还应同时补充钙剂，以防再度抽搐。

◎患儿在家中突然抽搐后，立即用上方止抽，然后到医院检查治疗。

◎平时多食用海味、肝类等含钙质高的食物，以补充体内的钙质。

维生素A缺乏症

维生素A缺乏症是由于体内缺乏维生素A所引起的一种疾病，其主要特征表现是两目干涩，雀盲或皮肤干燥。本病发病率较高，以婴幼儿多见，现代医学认为，发生本病的原因可有以下几种：长期以奶粉豆浆喂养婴儿，未及时添加富有维生素A或胡萝卜素的食物，易发生本病；高热、肺炎、肺结核等，维生素A的需要量迅速增加，也易发生本病；消化系统疾病，如慢性腹泻、痢疾等使维生素A和胡萝卜素吸收不良。中医认为本病多因小儿脾胃亏损，精血不足，目失濡养，或脾胃蕴热传之于肝，

肝阴受损所致。

诊断

◎病初起，皮肤逐渐变得干燥，鳞屑增多，以四肢伸侧及肩部比较明显，病儿的头发比较干燥，失去了光泽和滋润，有的还可出现脱发，指甲失去光泽和滋润。

◎有的病儿出现夜盲症，眼泪减少，出现干眼症，白眼球上有皂沫样的银白色小粒，叫结膜干燥斑，严重时角膜软化、穿孔，最后可导致失明。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

顺揉神阙、中脘各2分钟，点按睛明、攒竹、阳白、四白、瞳子髎各1分钟，拿血海1分钟，揉足三里、三阴交各1分钟，揉肝俞、脾俞、胃俞、肾俞各半分钟。

2. 随证配穴

(1) 脾胃亏虚型

主要表现：夜间视物不清，自觉眼部干涩不舒，频频眨眼，羞明喜暗，全身皮肤干燥，面色少华，形体消瘦，食欲不振，腹部胀满，大便稀薄，舌质淡，苔白。

治法：健脾和胃。

配穴：常用穴位加补脾2分钟，揉板门1分钟，推上三关1分钟，按揉中脘、天枢、神阙各1分钟。

(2) 肝阴不足型

主要表现：双目干涩，羞明流泪，夜间视物不清，全身皮肤干燥，伴有咽干口燥，两颧发红，盗汗，手足心热，大便干燥，舌质红，苔薄或少苔。

治法：滋阴平肝。

配穴：常用穴位加平肝1分钟，补肾2分钟，分腹阴阳2分钟。

3. 保健推拿法

操作者用拇指从患儿印堂穴推向上星穴半分钟，点揉百会1分钟，从印堂推至太阳1分钟，按压睛明、四白各1分钟，按揉肝俞、脾俞、胃俞、肾俞穴各1分钟。

预防护理

◎经常给患儿吃含维生素A丰富的食物，如猪肝、羊肝、蛋黄、胡萝卜、菠菜等。多吃水果和杏干，以补充胡萝卜素。

◎合理使用药物，应遵照医生的嘱咐，按时、按量给患儿服用鱼肝油或肌肉注射维生素AD。

◎患慢性消耗性疾病时，应积极治疗，并及早补充维生素A。

佝 偻 病

佝偻病多见于3岁以内的小儿，尤以6~12个月的乳幼儿发病率最高。这种病是一种慢性营养缺乏症，主要是缺乏维生素D和钙磷，引起骨骼神经肌肉等系统异常，其中以骨骼生长障碍最为明显。该病的患病率北方多于南方，可能与接触阳光少有关。

诊断

◎初期症状：烦躁不安，夜啼，神情淡漠，胃纳呆滞，头部多汗。病情进一步发展后会有头发稀少，枕秃，肌肉松弛，腹部

膨大等症状，甚至肝脾肿大。

◎中期症状：按压头部、顶骨或枕骨的中央有囊性感，或有方颅、囟门增大晚闭。胸部有串珠肋，鸡胸，下肢呈“X”腿或“O”形腿，手腕部、踝关节部有增厚的圆形隆起（又称手镯），有的呈龟背，牙齿出得晚等。

化验检查：血中的碱性磷酸酶大于正常值，钙减少。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

补脾3分钟，清胃3分钟，补肾3分钟，捣小天心1分钟，揉中脘2分钟，揉丹田2分钟，捏脊每日1次，揉足三里2分钟，揉三阴交2分钟。

2. 随证配穴

(1) 脾虚气弱

主要表现：皮肤苍白，头部多汗，头发稀少易脱落，肌肉松软，四肢无力，形体消瘦或虚胖，腹部膨大，大便清稀，纳食减少，精神烦躁，夜寐不安，脉软无力，舌淡，苔白。

治法：健脾补肾。

配穴：常用穴位加顺运八卦2分钟，揉二马2分钟，揉膊阳池1分钟。

如果汗多加补肺2分钟，分推手阴阳半分钟；夜寐不安，易惊者加捣小天心2分钟，平肝1分钟；便秘者补大肠1分钟，推上七节骨1分钟。

(2) 肾气亏损

主要表现：形体瘦弱，面色不华，出牙、坐立、行走等发育迟缓，骨骼畸形明显，且有头囟门不闭、方颅、鸡胸、龟背、腹大如鼓及下肢弯曲等，舌淡，苔少，脉迟无力，指纹淡。

治法：补肾益气壮骨。

配穴：常用穴位加揉二马2分钟，清天河水2分钟，揉百会2分钟。

预防护理

◎注意孕妇保健是预防小儿佝偻病的重要措施。孕妇应适当进行户外活动，注意营养。如妊娠中期手足麻木或小腿肚抽筋，应早日服用维生素D及钙剂。

◎加强调护，多在阳光下及户外活动，一般在生后两个月开始，孕妇尽量多暴露皮肤，多晒太阳，时间是冬季上午9点以后，下午4点以前；夏季上午10点以前，下午4点以后比较适宜，但切勿使强光直射或着凉。

◎提倡母乳喂养，随着小儿生长发育的需要应及早增加辅助食物。

◎对未成熟的小儿及生长迅速的小儿晒太阳有困难时，应尽早服用维生素D制剂或鱼肝油。一般生后2周开始服浓缩鱼肝油滴剂，婴儿每日服维生素D 400~800单位，并配合钙剂。

病毒性心肌炎

病毒性心肌炎是病毒侵犯心脏，以心肌炎性病变为主要表现的疾病。现代医学认为：本病可能为病毒直接侵犯心肌，或由于自身免疫反应所致。其主要病原为柯萨奇病毒、埃可病毒、脊髓灰质炎病毒、腺病毒、流感和副流感病毒、麻疹病毒等，临床出现各种轻重不等的心脏功能改变，患儿一般于半年至一年可恢

复，少数转成慢性。中医学把本病归属于“胸痹”、“心悸”、“怔忡”等范畴。由于气血阴阳失调，以至出现心气不足，心血不足，心阴不足，气滞血瘀等变化，从而产生各种症状。

诊断

◎患儿多有轻重不等的前驱症状，如发热，全身不适，咽部疼痛，腹泻等。

◎当心肌受累时，患儿常常自觉心前区不适，胸闷或胸痛，心慌，气短，乏力等。

◎心律失常以过早搏动为最多见。

◎严重者可出现心力衰竭、昏厥或抽搐等。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

按揉心俞，并直推到膈俞，反复操作1~3分钟，点揉至阳穴1分钟，擦脊及脊柱两旁膀胱经俞穴、点按双侧内关穴各1分钟，以膻中为中心向两侧分推，反复操作15~30次。

2. 随证配穴

(1) 心气不足型

主要表现：胸闷，心慌气短，乏力，面色㿔白，动则出汗，甚则大汗淋漓，四肢发冷，舌质淡，苔薄白。

治法：温阳益气。

配穴：常用穴位加揉二马2分钟，揉足三里1分钟，推上三关2分钟，揉外劳宫穴1分钟，补心1分钟，补脾2分钟。

(2) 心血不足型

主要表现：头晕，目眩，面色苍白，身体瘦弱，心慌气短，睡眠不安，舌质淡，苔薄或少苔。

治法：益气养血。

配穴：常用穴位加补脾 1 分钟，补肾 1 分钟，补三阴交 1 分钟，清天河水 1 分钟，推涌泉 1 分钟，推肝 1 分钟。

(3) 痰湿上扰型

主要表现：胸闷气短，体胖乏力，心中烦乱，多梦，睡中易惊，舌质淡，苔白腻。

治法：利湿化痰。

配穴：常用穴位加清补脾 2 分钟，清肺 2 分钟，揉足三里 2 分钟，退下六腑 1 分钟，揉肺俞 2 分钟，揉丰隆 1 分钟。

(4) 气滞血瘀型

主要表现：心慌，胸闷或胸痛，口唇青紫，皮肤干燥，舌质紫暗或有瘀点，苔薄白。

治法：活血化瘀。

配穴：常用穴位加揉膻中 2 分钟，揉中府 2 分钟，分推肩胛骨内侧 10~20 次，揉三阴交穴 1 分钟。

预防护理

◎加强体育锻炼，增强抵抗力，防止感染其他疾病，减轻心脏负担。

◎饮食宜采取少食多餐的方式，不宜吃得过饱，防止暴饮暴食，以免增加心脏负担。

◎适当增加室外活动，多晒太阳，保证足够的睡眠时间。

◎平时要注意患儿的面色、呼吸、脉搏，如果出现烦躁不安、出汗、面色苍白、气促、脉搏增快，很可能是发生了心力衰竭，应及时到医院请医生诊治。

尿 频

尿频又称“小便频数”，是指小便次数增多，有急迫感而无疼痛的一种病证。小儿在2岁以前出现这种症状者，不一定属于病态。现代医学认为本病的形成，是由于小儿高级神经系统功能发育不全、精神紧张等因素所致。中医学认为本病主要是由于小儿体质虚弱、肾气不足而无力制约水道所致。

诊断

小儿不时想小便，一般每日超过10次，每次尿量不多，常伴有面色㿔白，四肢不温，口干口渴，神疲乏力等。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

补脾2分钟，补肾2分钟，清小肠1分钟，揉丹田2分钟，揉气海1分钟，揉中极1分钟，揉肾俞、膀胱俞各1分钟，揉三阴交2分钟。

2. 随证配穴

(1) 阳虚型

主要表现：小便频数，或滴沥不尽，色白而清，面色㿔白，四肢不温，腹部发凉，少气懒言，纳呆，舌质淡，苔薄白。

治法：温阳补气。

配穴：常用穴位加补肺2分钟，捏脊每日1次，按揉双侧脾俞各1分钟，横擦腰背部1分钟。

(2) 阴虚型

主要表现：小便频数，或不能自禁，尿色深，夜热口干，手足心热，两颧发红，舌质红，苔少。

治法：滋阴补肾。

配穴：常用穴位加补肾3分钟，揉足三里1分钟，揉百会2分钟，揉二马1分钟，掐阴陵泉10~20次，揉涌泉1分钟。

预防护理

◎发现小儿尿频时，首先排除外阴炎、尿道炎、膀胱炎或泌尿系感染、蛲虫等引起的小便频数。

◎患儿患此病后减轻活动量，防止过度劳累和兴奋，并注意预防感冒和保持皮肤清洁。

◎小儿在小便时，不要突然惊吓或开玩笑，以免引起大脑皮质功能紊乱，而出现尿频甚至尿失禁。

◎对肾气虚弱的尿频，可配合补肾益气的中成药，如金匱肾气丸、六味地黄丸等。

尿 潴 留

尿潴留是由于尿路有病理障碍或神经性功能障碍，从而导致大量尿液积蓄在膀胱中而不能排出或排出不畅的病证。现代医学中的尿道狭窄、血块堵塞膀胱、麻醉、手术后或由于中枢神经或周围神经的损伤、炎症等疾病均可导致尿潴留。推拿治疗尿潴留多适用于排尿功能障碍引起者。中医称此病为“癃闭”，是由于膀胱湿热、肾阳不足、命门火衰等原因引起，且多与脾、肺、肾

三脏有关。

诊断

小腹部胀满疼痛，小便不通或点滴难出，耻骨上区膨隆，按时有波动感，心烦口渴，精神不振等。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

揉丹田 5 分钟，推箕门、中极各 2 分钟，揉水道、三阴交各 1 分钟，按压关元到耻骨。

2. 随证配穴

(1) 湿热蕴积

主要表现：小便点滴不通，或点滴不畅，小腹胀满，口苦口黏，或口渴而不欲饮，尿色黄赤，舌质红，苔黄腻。

治法：清热利湿。

配穴：常用穴位加清小肠 1 分钟，清天河水 1 分钟，清肝 1 分钟，清肾 1 分钟。

(2) 肾阳虚损

主要表现：小便不通或点滴不畅，排出无力，面色㿔白，畏寒肢冷，水肿，舌质淡，苔白。

治法：温阳利水。

配穴：常用穴位加补肾 1 分钟，清小肠 1 分钟，揉肾俞、三焦俞、命门穴各 1 分钟，揉二马、外劳宫各 1 分钟。

预防护理

◎推拿时以患儿能忍受为度，由轻而重，不可用力过猛。

◎对因器质性病变引起者，应积极治疗原发病，对慢性尿潴

留患儿则应及时发现、及时治疗。

◎对手法无效者，应尽快到医院就诊，及早解除患儿痛苦。

◎增强体质，预防各种感染，忌食辛辣、肥甘之品，克服忍尿的不良习惯。

肾 盂 肾 炎

肾盂肾炎是细菌侵犯肾盂和肾实质而引起的一种疾病。在小儿泌尿系感染性疾病中比较常见。现代医学将肾盂肾炎分为急性和慢性两种。多由大肠杆菌、副大肠杆菌和变形杆菌引起者为主。细菌多由尿道上经膀胱、输尿管达肾盂及肾实质，也可由其他部位的感染，通过血液和淋巴系统而达肾脏。中医学将本病归属“淋证”范畴，急性期大多由于湿热蕴积下焦，膀胱气化功能失常所致。慢性期常出现肾阳不足，脾肾两虚等正虚邪恋之证。

诊断

◎急性肾盂肾炎发病急，患儿可有发热、寒战，少数并有面色灰白等中毒症状。

◎低热或无热者很少，常伴有恶心、呕吐，尿液出现明显混浊。

◎较大儿童除发热外，常感肾区痛，用手按时可出现压痛。如果合并了膀胱炎，可出现尿频、尿急、尿痛及排尿困难，少数可出现血尿。

◎急性肾盂肾炎治疗不彻底就会转为慢性肾盂肾炎，患儿可

出现面色苍白、身体消瘦、精神不振以及生长迟缓等。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

揉气海、关元各 2 分钟，揉中极 2 分钟，揉三焦俞、膀胱俞各 1 分钟，清小肠 1 分钟，清肺 1 分钟。

2. 随证配穴

(1) 膀胱湿热

主要表现：恶寒发热，尿频，尿急，尿痛，尿色黄而短少，小便有烧灼感，少腹胀痛，腰部酸软，舌质红，苔黄或白腻。

治法：清热利湿。

配穴：常用穴位加揉三阴交、阴陵泉各 1 分钟；擦脊，用手掌尺侧擦脊柱及脊柱两旁俞穴，以热为度；横擦大椎及两肩部。

(2) 肝胆郁热

主要表现：小便不畅，尿道有灼热感，伴食欲减退，口苦咽干，烦躁不安，胁肋胀痛，舌质红，苔黄。

治法：疏肝利胆。

配穴：常用穴位加揉章门、太冲穴各 1 分钟。擦两胁半分钟或以热为度，清肝 2 分钟，推下承山 1 分钟，退下六腑 1 分钟，清天河水 1 分钟。

(3) 肾阴不足

主要表现：尿频，尿急，头晕，腰酸腿软，低热，咽干唇燥，舌质红，少苔或无苔。

治法：养阴清热。

配穴：常用穴位加补肾 2 分钟，横擦肾俞穴以透热为度。擦小腹两侧，以透热为度。揉三阴交、阴陵泉各 1 分钟，清天河水 1 分钟，清肝 1 分钟。

(4) 脾肾两虚

主要表现为：尿频，尿急，颜面浮肿，腰部酸软，神疲乏力，食欲不振，或有少腹坠胀，舌质淡，苔薄白。

治法：健脾补肾。

配穴：常用穴位加补脾、补肾各2分钟，揉足三里、二马各1分钟，揉外劳宫1分钟，揉命门1分钟。

预防护理

◎患儿应卧床休息，多喝水促进排尿。

◎在急性期应给予流食，如米粥、藕粉等，少吃多餐，适当控制盐的摄入量，恢复期要多注意给患儿吃含蛋白质丰富的食物，如瘦肉，鸡蛋等。

◎对婴幼儿应经常保持其会阴部的清洁干燥，尿布要用清水洗净，然后用开水煮沸10分钟后晒干。

◎肾盂肾炎来势急，发病快，且又容易反复，因此一旦发现应及早诊治。

急性肾炎

急性肾炎又称急性肾小球肾炎，是一种急性起病，不同病因所致的感染后免疫反应引起的弥漫性肾小球炎性病变。多发生于5~10岁的儿童，男性多于女性，为小儿常见病之一。现代医学认为急性肾小球肾炎可由多种病因引起，但绝大多数为链球菌感染后所致。另外，肺炎双球菌、金黄色葡萄球菌、乙型肝炎病毒、腮腺炎病毒、流感病毒等也都可以引起急性肾炎，但较少

见。祖国医学认为本病多属“水肿”的“阳水”或“风水”等范畴。其发病原因，外因为感受风邪、水湿或疮毒入侵；内因主要是肺、脾、肾三脏功能失调。

诊断

◎常在上呼吸道、扁桃体炎、脓疱疮等感染后1~4周起病，可有低热、头晕、恶心、呕吐、食欲减退等一般症状。

◎起病的第1周开始出现浮肿，最初是上眼皮浮肿，1~2日后渐及全身，还会出现尿少和血尿，尿的颜色呈洗肉水样，或呈茶红色，血尿在1~2周内消失。

◎患儿在起病后的头几天内，可出现高血压，少数的血压不高，血压高者常在开始利尿后恢复正常。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

从肚脐推向耻骨反复20次。推大腿内侧，自上而下，以热为度。指揉气海、中极、阴陵泉、三阴交各1分钟。推下七节骨1分钟，揉肺俞、大肠俞、小肠俞各1分钟，清小肠1分钟，清天河水1分钟。

2. 随证配穴

(1) 风水型

主要表现：发病较急，初期可有恶寒发热，咳嗽气粗，眼睑浮肿，继而出现全身浮肿，尿少黄赤，舌质淡，苔薄白。

治法：疏风解表，利水消肿。

配穴：常用穴位加揉水分穴1分钟，擦脊、擦肩背部以热为度，掐合谷、曲池、一窝风各20遍，揉大椎1分钟，拿肩井10~20遍。

(2) 热毒型

主要表现：肢体浮肿，小便短赤，色如浓茶，口干口渴，心烦不安，腹部胀闷，大便干结，舌质红，苔黄。

治法：清热解毒。

配穴：常用穴位加揉大椎1分钟，退下六腑、清天河水各2分钟，清小肠2分钟，清肺、平肝各1分钟，揉膻中1分钟，搓擦胸胁1分钟。

(3) 寒湿型

主要表现：肢体浮肿或下半身肿甚，面色萎黄，肢体沉重，困倦乏力，食欲不振，四肢不温，大便稀薄，小便短少，舌质淡，苔白腻。

治法：温阳化湿。

配穴：常用穴位加揉中脘2~5分钟，揉气海延长至2分钟，揉丹田2分钟，揉命门、肾俞各2分钟，揉足三里1分钟，掌擦两胁部2分钟。

预防护理

◎积极预防和治疗上呼吸道感染和皮肤感染，对反复发作的扁桃体炎，可考虑手术切除。

◎患儿患肾炎后，要卧床休息，待血压恢复正常，其他症状改善后，可逐渐增加活动。

◎患儿应吃含糖和脂肪的食物，如米粥、各种糕点、藕粉等。要控制患儿的饮水量。

◎患儿患肾炎后可并发心力衰竭、高血压、尿毒症等危重病，故注意观察和护理。

慢性肾炎

小儿慢性肾炎也是一种与感染有关的免疫反应性疾病，发病率较成人低，由急性肾炎转变为慢性肾炎者也比较少见。本病可继发过敏性紫癜，或为肾病综合征的晚期表现。临床有血尿、蛋白尿、高血压、水肿和不同程度的肾功能障碍。祖国医学把此病包括在“水肿”范畴。

本病的发生主要是脾肾功能失调，气阳虚损。临床治疗时多分为脾阳不足，脾肾阳虚，肝肾阴虚，正虚邪实等症。

诊断

临床表现大多不明显，仅在体检时发现浮肿、高血压、蛋白尿、血尿等，或出现恶心、呕吐、腹泻、贫血等尿毒症现象。患儿一般表现面色苍白，眼睑轻度浮肿，胃不好，肢体乏力，另外往往在感冒之后症状加重。

慢性肾炎进入肾病期时，全身显著水肿。后期出现夜间尿多，尿蛋白减少，水肿相应减轻，血压升高。当肾功能减退或出现尿毒症时，出现头痛、呕吐、昏迷、抽搐、出血、心力衰竭等。

化验检查，尿蛋白微量或大量，红细胞常在高倍视野3个以上，急性发作时有血尿，12小时尿明显异常。血白细胞及中性粒细胞增高，非蛋白氮、尿素氮和肌肝增高，血浆总蛋白降低。血钙、钠、氯、二氧化碳结合力降低。尿少时血钾和磷升高，并出现酸中毒。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

清补脾 3 分钟，清大肠 2 分钟，清小肠 2 分钟，推四横纹 2 分钟，揉足三里 2 分钟，揉气海 1 分钟，摩腹 1 分钟。

2. 随证配穴

(1) 脾肾阳虚

主要表现：面色㿔白，神疲倦怠，四肢厥冷，全身浮肿，并伴有胸水，腹水，尿少，腹胀，食少，恶心呕吐或有喘促，舌质淡，苔薄润，舌边有齿痕，脉细。

治法：温阳利水。

配穴：常用穴位加补肾 3 分钟，揉二马 2 分钟，揉丹田 2 分钟，揉神阙 2 分钟，推上三关 2 分钟。

(2) 脾阳虚弱

主要表现：面浮肢肿，四肢不温，精神疲乏，纳呆泛恶，大便溏薄，舌质淡，苔腻，脉濡细。

治法：益气健脾利水。

配穴：常用穴位加推上三关 2 分钟，揉膊阳池 2 分钟，推下天柱骨 1 分钟，揉中脘 2 分钟。

(3) 肝肾阴虚

主要表现：面色无华，午后颧红，五心烦热，口干欲饮，不思饮食，大便秘结，睡寐汗出，舌红少苔，脉细数。

治法：平肝滋肾，育阴潜阳。

配穴：常用穴位加平肝 2 分钟，补肾 2 分钟，揉二马 2 分钟，揉三阴交 2 分钟，清天河水 2 分钟，揉丹田 1 分钟。

(4) 阴阳两虚

主要表现：面部浮肿，色泽晦暗，精神萎靡，形体羸瘦，胸

闷腹胀，食欲不振，恶心呕吐，尿少赤涩，便溏或便秘，呼吸气促，甚至烦躁，昏迷抽搐，舌质淡胖，苔白腻或黄腻，脉沉细。

治法：扶正降浊。

配穴：常用穴位加推上三关2分钟，揉外劳宫2分钟，揉膊阳池2分钟，揉中脘2分钟，平肝2分钟，补肾2分钟，揉板门1分钟，清心1分钟。

预防护理

- ◎注意保护患儿，防止上呼吸道感染和其他传染病。
- ◎积极彻底治疗感染病灶。
- ◎患儿浮肿时应停止体力活动，限制食盐摄入量，如不水肿则不必限制食盐用量。
- ◎如尿中有大量蛋白，应补充含高蛋白的食物。
- ◎适当参加身体锻炼，提高抗病能力。

肾病综合征

肾病综合征是以肾小球基底膜通透性增高为主的症候群。临床以全身高度浮肿，高胆固醇血症，大量蛋白尿，低蛋白血症为特征。本病多发生于3~8岁的小儿。现代医学将肾病综合征分为单纯性肾病、肾炎性肾病、先天性肾病三类，其中以单纯性肾病多见。认为本病的发病原因可能与机体细胞免疫力功能紊乱有关。祖国医学将本病归属于“水肿”、“阴水”、“虚损”的范畴。其发病与肺、脾、肾三脏功能失调有关，病变部位则以脾、肾两脏为主，即脾虚不能制水，肾虚不能行水，水液内停，外溢

肌肤而出现水肿等症状。

诊断

◎全身呈凹陷性水肿，以颜面、腹部、下肢最为明显，也可出现阴囊水肿，有时并有胸水、腹水甚至双眼不能睁开。

◎浮肿反复发作，一般情况在初起时尚好，以后面色逐渐苍白，精神萎靡，食欲减退等。

◎可伴有呼吸道感染、腹膜炎等并发症。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

顺揉水分穴1分钟，点按气海穴半分钟，揉中脘、神阙、中极各1分钟，揉阴陵泉、足三里、三阴交，补肾、揉二马各1分钟，清小肠1分钟。

2. 随证配穴

(1) 脾虚湿泛型

主要表现：面色㿠白，精神萎靡，疲倦乏力，全身浮肿，腹部胀满，小便短少，大便溏薄，食欲不振，恶心呕吐，舌质淡胖，苔薄白或白腻。

治法：健脾利湿。

配穴：常用穴位加补脾3分钟，揉板门1分钟，揉脾俞、胃俞、三焦俞、膀胱俞各1分钟，顺时针摩腹2~5分钟。

(2) 脾肾阳虚型

主要表现：面色㿠白或发灰，精神疲倦，四肢不温，全身高度浮肿，可伴有胸水、腹水、尿少、腹胀、恶心、呕吐，舌质淡，苔薄白或薄腻。

治法：温肾健脾。

配穴：常用穴位加揉脾俞、肾俞、三焦俞各1分钟，横擦腰骶部以热为度，补脾1分钟，揉膈阳池1分钟，推上三关1分钟。

(3) 肝肾阴虚型

主要表现：头晕目眩，头部隐痛，双目干涩，耳鸣，两颧潮红，烦躁不安，手足心热，舌质红，苔薄或少苔。

治法：补肝益肾。

配穴：常用穴位加平肝2分钟，补肾延长至2分钟，横擦腰骶部、斜擦少腹部，均以透热为度。

预防护理

◎注意休息，对严重水肿的患儿应限制活动。

◎采用适合患儿胃口的一般饮食，蛋白质应适当增加，对于水肿或高血压明显的患儿应忌盐。

◎防止感染，积极处理感染病灶，患儿应避免到人多的公共场所去。

小 儿 斜 颈

斜颈是指头向患侧倾斜，颈前倾并旋向健侧，患侧面部软组织萎缩变形，一般是指因一侧的胸锁乳突肌挛缩而造成的肌性斜颈。脊柱畸形引起的骨性斜颈，视力障碍引起的代偿性姿势性斜颈和颈部肌麻痹导致的神经性斜颈为数极少。局部淋巴结肿大疼痛引起的暂时性斜颈不属于本病范畴。

斜颈产生的原因很多，一是分娩时一侧胸锁乳突肌因受产道

或产钳挤压和牵拉受伤出血，血肿硬化造成挛缩；二是分娩时胎位不正，阻碍一侧胸锁乳突肌的供血引起缺血性改变；三是因胎儿在子宫内头部向一侧偏斜所致。

诊断

患儿多数在产后或几个月后发现颈部有一个肿块，卵圆状，大小各异，其方向与胸锁乳突肌一致，按压肿块或头部运动牵拉时有疼痛。数月后有头面部畸形，如斜颈明显，颜面大小不对称，肿块多由条索状纤维代替，而且较硬，变粗以后压痛逐渐消失，晚期伴有颈椎或上胸椎有固定性脊柱侧弯。

治疗

第一步，患儿取坐位或仰卧位，用滑石粉做介质，操作者一手托颈使后伸，一手推揉患侧的胸锁乳突肌和附近组织，上下数遍，揉法要深，手指与皮肤不要滑动，以免皮肤受伤。

第二步，拿捏患侧胸锁乳突肌的肿块，用拇、中、食三指仔细拿捏。如肿块偏近乳突就一直拿捏到乳突部；如肿块偏近胸锁骨处，应一直拿到胸锁骨的肌肉附着点。用力要深，犹如肿块要捏散一样，但要注意重捏与轻揉相结合，以免患儿剧烈哭闹。

第三步，做完以上动作后，头颈部扳向健侧做被动牵引。

第四步，用双手在挛缩处做分向牵扯筋腱数次，每日1次，治愈为止。

预防护理

- ◎经常揉捻患儿颈部，每日2~3次。
- ◎注意喂奶和睡眠姿势。
- ◎经常用活血化痰中药或热水敷颈部。

面部神经麻痹

面部神经麻痹是面神经受损伤引起的面部肌肉运动障碍的一种病证，又称“面瘫”、“口眼歪斜”。本病分为中枢性面神经麻痹和周围性面神经麻痹两类，本篇只介绍后者。

本病可发生于任何年龄，以青壮年多见，在小儿中也可出现。患本病后不仅病人觉得痛苦，而且影响人的美容。现代医学认为本病多由急性非化脓性茎乳突孔内的面神经炎引起，一般认为可能是局部营养神经的血管因受风寒而痉挛，导致该神经缺血性水肿而致病，或与局部的病毒感染有关。祖国医学认为：本病多由风寒邪气侵袭面部经络，导致经脉气血运行不畅，经筋失于濡养，纵缓不收而发病。

诊断

患儿多在清晨醒来时发现一侧眼睛不能闭合，嘴角歪向一侧，漱口困难，面部肿胀或有牵掣感。耳下或乳突部常有疼痛感觉，病侧面部表情消失，鼻唇沟变浅或歪斜，说话漏风，口角流涎，进食时食物常停留在病侧齿颊之间，有的还可出现味觉减退或听觉过敏的症状。

治疗

1. 常见穴位及推拿手法

开天门1分钟，揉双侧太阳穴1分钟，摩擦患儿患侧面部以热为度；揉阳白、四白、迎香、地仓、颊车、下关等穴位，每穴

1 分钟。掐揉双侧合谷穴各 1 分钟，擦揉双侧风池穴各 1 分钟，清肝 2 分钟，清天河水 1 分钟。

2. 随证配穴

(1) 风寒型

主要表现：除面部症状外，兼见鼻塞流涕，舌淡，苔白，脉浮紧。

治法：疏风散寒。

配穴：常用穴位加揉一窝风、大椎、风府、翳风、承浆穴各 1 分钟。

(2) 风寒化热型

主要表现：除面部症状外，兼见咽干多饮，便干溲赤，面部发热，舌偏红，苔薄白，脉浮数或滑数。

治法：疏风清热，解表通络。

配穴：常用穴位加揉太冲、推下承山、七节骨各 1 分钟，退下六腑 1 分钟，拧大椎 15 次。

预防护理

◎推拿期间不可过度劳累，避免吹风受凉，不用冷水洗脸。

◎平时适当进行体育锻炼，增强身体抵抗力。

◎推拿时患侧和健侧可交替进行，但健侧手法要轻，患侧要重。

◎较大儿童可自我推拿，每日 2 次，每次 5~10 分钟。

进行性肌营养不良

进行性肌营养不良是一组遗传性骨骼肌退行性变性疾病。本

病可分为多种类型，小儿以假性肥大型最为常见。可有家族史，多为隐性遗传。起病最小年龄为1岁，一般多在3岁左右或稍大发现症状。

现代医学认为本病的病因尚不明了，而遗传因素在本组疾病中起重要作用。近年来对细胞膜学较重视，即基因的缺陷或某种酶的先天缺陷，使肌细胞膜的结构发生变化，最后导致肌纤维的变性坏死等病理变化。祖国医学认为本病属“痿证”之范畴，其病因有外感和内伤之不同。若患儿先天不足或素体脾胃虚弱，或久病致虚，或有外感风热暑湿之邪侵袭，使肌肉筋脉失养，气血不通而发为本病。

诊断

患儿走路不稳，上半身向左右摆动，呈“鸭子步”，容易跌倒，爬楼梯困难，患儿由仰卧位爬起到站立位时，先转为俯卧位，用双手支起上半身呈爬跪姿势，继而两膝伸直，以双手双腿共同支持躯体，然后两手依次扶其膝盖，逐步上移到大腿而站起，呈现特殊的起立姿势，小腿肚和肩部的三角肌出现假性肥大。患儿最终因肌肉萎缩，不能行走，最后并发营养不良、呼吸道感染或心力衰竭而死亡。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

- (1) 经穴推拿（详见附录二）。
- (2) 四肢分筋法（详见附录二）。
- (3) 揉按肩髃、曲池、合谷、委中、承山各1分钟。

2. 随证配穴

- (1) 肺热伤津型

主要表现：肢体痿软无力，发热，口渴咽干，皮肤干燥，咳嗽无痰，大便干结，小便短赤，舌质红，苔薄黄。

治法：清热润肺。

配穴：常用穴位加清肺 2 分钟，清肝、退下六腑、清大肠各 2 分钟，清小肠 1 分钟，揉大椎、擦脊柱各 1 分钟。

（2）湿热浸淫型

主要表现：两下肢痿软无力，沉重麻木，胸部胀满，渴不喜饮，面色发黄，喜冷恶热，小便不畅，灼热疼痛，舌质红，苔黄腻。

治法：清热利湿。

配穴：常用穴位加推擦大腿内侧，自上向下，以热为度。揉三阴交、太冲、阴陵泉各 1 分钟，揉足三里 1 分钟。

（3）脾胃虚弱型

主要表现：四肢痿软无力，或见双侧小腿肚肥大，面色萎黄，食欲不振，疲倦乏力，大便溏薄，四肢欠温，舌质淡，苔薄白。

治法：健脾和胃。

配穴：常用穴位加补脾 3 分钟，揉板门 2 分钟，推上三关 1 分钟，补大肠 1 分钟。揉脾俞、胃俞各 1 分钟，揉腹 1 分钟。

（4）肝肾亏损型

主要表现：起病缓慢，病程较长，肢体痿软无力，腰膝酸软，头晕耳鸣，或遗尿，舌质红，少苔。

治法：滋水平肝。

配穴：常用穴位加补肾、清肝各 2 分钟，揉关元、肾俞各 2 分钟，横擦腰骶部，斜擦少腹部，以热为度，掐太溪、解溪穴各 10 次。

预防护理

◎本病目前无特效药物，应综合治疗，在推拿的同时，可配合针灸、理疗等，以延缓肌肉的萎缩及防止肌肉的挛缩。

◎平时应加强饮食营养，多食高蛋白、水果、新鲜蔬菜，但体重不宜增加太多，否则不利于活动。

◎积极预防和及时治疗呼吸道感染等多种疾病。

◎小儿患病后长期卧床者，应特别注意避免发生褥疮，定时翻身，白天每2小时翻身1次，夜间3~4小时翻身1次，使患儿经常保持皮肤的清洁，促进血液循环。床铺要清洁整齐，保持干燥、平坦、无渣屑。

小 儿 痿 证

痿证简称“痿”，又名“痿痹”。临床特点是肢体筋脉松弛，软弱无力，严重者手不能握，足不能任身；肘、腕、膝、踝等关节脱臼，渐至肌肉萎缩而不能随意运动，日久肢体瘫痪。

小儿痿证的发生，主要是由阳明湿热内蕴，肺受热乘而气液枯槁，脾受湿淫，流溢经脉所致。因肺朝百脉，肺热叶焦，则百脉弛缓而为痿；脾主肌肉，阳明主一身的宗筋，如脾胃湿热不攘，则见“大筋软短，小筋弛长，软短为拘，弛长为痿”。此病可发生于任何年龄，但以5~10岁最为多见。发病季节四季均有，但以5~10月份最多。患病后大多数患儿都能逐渐恢复健康，严重者则遗留后遗症，如肢体痿废、肌肉萎缩或畸形，极重患儿则出现呼吸麻痹，若不及时救治，往往导致生命危险。

诊断

小儿痿证是小儿痿软无力，临床凡患儿自觉肢体软弱无力，活动无力，甚至不能任地，不能步履，形成弛缓性瘫痪或肌肉萎缩者都可诊为痿证。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

(1) 补肾 3 分钟，揉二马 2 分钟，清补脾 2 分钟，清补肺 2 分钟，揉百会 2 分钟，平肝 2 分钟。

(2) 经穴推拿，每日 1~2 次（详见附录二）。

(3) 四肢分筋法。

上肢：用左右手交替从病人腋窝部循经拨动，先由里往外，再由外往里，反复 5~10 遍，然后左手拇指扣住腋下大筋，中指或食指扣住肩井，右手拉病儿手腕，最后揉手背掌骨，再用两手抓住小儿五指上下抖动 5~6 次。

下肢分筋同上基本一致，最后两手握脚腕，使病人屈腿，左右摆动，然后揉动脚腕，拉直大腿，来回做 3 遍即可，每日 1 次或 2 次。此法与上法紧密配合，1 日 1 次（详见附录二）。

2. 随证配穴

(1) 气热伤津

主要表现：突然两足痿软无力或四肢全瘫，或恶寒发热及低热，皮肤干燥，心烦口渴，咳嗽无痰，咽干，溲赤热痛，大便秘干，舌红苔黄，脉浮数。

治法：清热润燥，养阴清胃。

配穴：常用穴位加清胃 2 分钟，清天河水 2 分钟，清大肠 2 分钟，清小肠 2 分钟，揉足三里、三阴交各 1 分钟。

(2) 湿热浸淫

主要表现：两下肢痿软，足跗微肿麻木，喜冷恶热，身重身热，面色发黄，胸脘痞满，小便赤涩，舌苔黄腻，脉濡数。

治法：清热利湿。

配穴：常用穴位加清胃 3 分钟，清大肠 2 分钟，退下六腑 2 分钟，清小肠 2 分钟，清天河水 2 分钟，擦脊 2 分钟。

(3) 脾胃虚弱

主要表现：下肢渐渐痿软无力，肌肉消瘦，甚至萎缩，饮食少，大便溏甚至脱肛，面浮少华，舌苔薄白，脉细。

治法：益气健脾。

配穴：常用穴位加揉足三里 3 分钟，揉中脘 2 分钟，揉神阙 2 分钟，揉三阴交 2 分钟。

(4) 肝肾亏损

主要表现：起病慢，肢体痿软无力，腰膝酸痛，并伴有头晕少力，多见于年长儿。

治法：补益肝肾，滋阴清热。

配穴：常用穴位加揉三阴交 3 分钟，揉足三里 3 分钟，揉丹田 3 分钟，揉百会 2 分钟。

预防护理

◎除四害，讲卫生，加强身体锻炼，及时接受预防接种。

◎做好孕妇保健，防止妊娠期间感染和外伤，注意孕期营养，减少产伤。

◎患儿病后及时治疗，加强患肢的被动活动及按摩推拿，改善患肢功能，预防肌肉萎缩。

◎患病后注意褥疮发生，定时翻身，日间每 2 小时翻 1 次，夜间 3~4 小时翻 1 次。

◎经常保持皮肤清洁，促进血液循环。

◎床铺要清洁整齐，注意经常保持干燥、无渣屑。

类风湿性关节炎

类风湿性关节炎是一种常见的伴有全身症状的慢性关节疾病。多见于7~14岁儿童，女孩多于男孩，其发病后全身关节都可以受累，尤其是小关节较重，甚至关节变形，影响正常活动。现代医学认为，本病的病因目前还不十分清楚，多数人认为患者血清中存在类风湿因子引起的自体免疫反应。另外还有内分泌和遗传因素。受寒和潮湿往往是本病发生的诱因。祖国医学认为，本病是由外感风寒湿邪，气血运行不畅，经脉不通所致。如果风邪较重则疼痛游走不定；寒气较重，则痛有定处；如果湿邪较重，则肿胀麻木；久病不愈，则可出现气滞血瘀的病理变化。

诊断

大多起病缓慢，早期可有低热，全身肌肉酸软无力，食欲不振，体重减轻，消瘦等。开始仅1~2个小关节受累，呈游走性，活动时疼痛，继而肿胀变硬，局部发热但不一定发红，其典型早期表现为晨僵。以后，随着病变的发展，可由小关节到大关节，由少数到多数，可累及多个关节，晚期出现肌肉萎缩，病变关节变形而发生畸形和僵直。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

- (1) 顺揉神阙、气海各2分钟，揉四肢，以患侧为主。
- (2) 四肢分筋法，1日1次。
- (3) 揉按足三里、三阴交、承山、风市、承扶各1分钟。
- (4) 点按肩、背、腰骶部，以热为度。

2. 随证配穴

(1) 痛痹

主要表现：关节疼痛比较明显，痛有定处，屈伸不利，局部发冷，得热痛减，遇寒加剧，舌质淡，苔白。

治法：温经散寒，通经活络。

配穴：常用穴位加拿肩井3~5次，两手掌相对用力，横揉四肢，以局部发热为度；直擦肩部脊柱，斜擦两肩，以热为度。

(2) 行痹

主要表现：肢体关节疼痛，游走不定，多见于膝、踝、肘、腕关节，屈伸不利，遇风则加重，舌质淡红，苔薄白。

治法：祛风行血，活络止痛。

配穴：常用穴位加揉曲池、合谷各1分钟，拿风池半分钟，揉肺俞1分钟。

(3) 着痹

主要表现：四肢沉重，肌肉酸痛，关节疼痛，屈伸不利，腰部发凉，双足浮肿，大便稀薄，小便清长，舌质淡，苔白腻。

治法：温经散寒，利湿止痛。

配穴：常用穴位加揉肩井、合谷各1分钟；以手掌尺侧面拍打脊柱两侧，自上而下，反复操作，以皮肤微红为度；揉按脾俞、胃俞各1分钟。

(4) 热痹

主要表现：关节红肿热痛，遇热则甚，发热，口干咽燥，面红目赤，烦躁不安，大便干，小便黄，舌质红，苔黄腻。

治法：清热利湿，活络止痛。

配穴：常用穴位加揉大椎、风池、风府各1分钟，下擦脊背1分钟，拿肩井1分钟，退下六腑1分钟，清天河水1分钟，推下承山1分钟。

预防护理

◎患儿平时要注意保暖，尤其是汗出后不宜用冷水冲洗和脱衣服，要随气候变化更换衣服。

◎饮食宜富有营养，不宜食寒性食物。

◎争取早期治疗和适当的身体锻炼，但不要过度疲劳。

◎手法宜轻柔和平，切忌使用蛮力，以免发生不良后果。

轻微脑功能障碍综合征

轻微脑功能障碍综合征是指智力正常或接近正常的小儿，有不同程度的学习困难、活动过多、注意力不集中和情绪不稳定等症候群。因无严重的智力减退和肢体瘫痪，而与大脑发育不全或脑性瘫痪不同。本病男孩多于女孩。现代医学认为，本病的发生，可能与出生前后的轻微脑损害、多基因遗传及代谢异常有关。祖国医学认为，本病多因先天肝肾不足，或后天脾胃失调而使气血不足，脑髓失养所致。

诊断

小儿活动过多，婴儿期表现为不安入睡，睡眠不安。幼儿期不能静坐，任意破坏东西。学龄期在课堂上不能认真听讲，做

小动作，注意力涣散，不能参加正常儿童有兴趣的活动，平时难以约束自己，冲动任性不顾后果，甚至逃学、说谎、偷窃与打架等。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

揉百会穴、太阳穴、内关穴、足三里各2分钟，揉膊阳池1分钟，点打百会、四神聪各1分钟，揉心俞、肾俞、命门穴各1分钟，捏脊，1日1次。

2. 随证配穴

(1) 心脾两虚型

主要表现：患儿不安静，注意力不集中，多梦易醒，健忘，神疲乏力，面色㿔白，四肢不温，大便稀薄，舌质淡，苔薄白。

治法：健脾养心。

配穴：常用穴位加补脾3分钟，补心2分钟，揉中脘2分钟，开天门1分钟。

(2) 肝肾亏损型

主要表现：患儿好动，不安静，学习困难，头晕健忘，腰酸无力，大便干，小便清长，舌质淡，苔少而干。

治法：补肝益肾。

配穴：常用穴位加补肾3分钟，揉肾顶1分钟，揉涌泉2分钟，揉太溪1分钟，揉三阴交1分钟。

预防护理

◎培养患儿正常的生活习惯，逐渐增强患儿的注意力。

◎保持患儿心情舒畅，不要责骂歧视患儿，要关心患儿，耐心地配合医生治疗。

◎推拿期间应同时服用中枢神经兴奋剂或中药，以增强疗效。

癲 癇

癫痫是小儿时期最常见的一种神经系统疾病，民间称“羊痫风”。本病病因复杂，反复发作，故为难治性疾病。

现代医学一般将癫痫分为原发性和继发性两大类，原发性癫痫是指原因不明或有遗传性因素的疾病，常在4岁后起病。继发性癫痫常见于大脑器质性病变，如脑损伤、脑缺氧、脑肿瘤等所引起。中医学认为本病的发生，或因胎中受惊，或因外感六淫，或因内伤饮食等引起。其病位主要是在脑和心，以及肝脾两经，其机理主要是风邪内侵而诱发。

诊断

大发作：多见于年长儿，早期可出现肢麻、指动、心慌气短等先兆症状，随后意识丧失，跌倒，面色苍白，身体强直，眼球上翻，口吐白沫，几秒钟后出现全身性抽动，甚至大小便失禁，经过几分钟至十几分钟后抽搐停止，继而昏睡，醒后自觉头昏，疲乏无力。

小发作：多见于幼童，女性多于男性。患儿可突然出现短暂的意识丧失，不跌倒，无惊厥，发作时患儿两眼发直，面部肌肉或四肢肌肉偶尔有小的抽搐。

局限性发作：多因为大脑有病所致，患儿表现为肢体某一部分的抽搐或感觉异常，多见于一侧嘴角、上肢或半身，如转成大

发作时，可伴有意识丧失。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

揉百会、中脘、气海各 2 分钟，揉膻中 1 分钟，拧大椎、掐人中、承浆、合谷、涌泉各 1 分钟。清肝、补肾、清心各 2 分钟，擦脊（从大椎沿脊椎往下擦），揉心俞、厥阴俞、肝俞、肾俞、脾俞各 1 分钟。

2. 随证配穴

(1) 风痫型

主要表现：发作前多有头痛头晕先兆，随即神志不清，突然摔倒，手足抽搐，双目上视，牙关紧闭，口吐白沫，并发出异常的叫声，不久渐渐清醒，常有疲乏无力等症状，舌质淡，苔白腻。

治法：疏风解痉。

配穴：常用穴位加揉风府、风池、曲池、一窝风各 1 分钟，揉内关、神门各 1 分钟，擦脊 10 遍。

(2) 惊痫型

主要表现：突然惊恐意乱，不能自制，时而愤怒，时而惊叫不安，舌吐在外，口流涎水，面色时红时白。

治法：镇惊安神。

配穴：常用穴位加掐太冲 1 分钟，清天河水、退下六腑各 2 分钟。

(3) 食痫型

主要表现：发作前多有伤食病史，发作时神志模糊，精神痴呆，喘气较粗，喉间有痰，口角流涎，舌质淡，苔厚腻。

治法：消食和胃，祛痰解痉。

配穴：常用穴位加捏脊，清胃、板门、脾穴各2分钟，顺运八卦2分钟，推下七节骨1分钟，揉丰隆1分钟，摩腹2分钟，清天河水1分钟。

(4) 胎痫型

主要表现：生后百天即发病，精神萎靡不振，面色苍白，易惊易恐，甚至睡中亦惊，手足抽动，舌质淡，苔薄白。

治法：清肝泄火，止惊。

配穴：常用穴位加清脾1分钟，揉足三里1分钟，擦脊背20遍，揉长强1分钟。

预防护理

◎合理安排患儿的生活和学习，保证充分休息，保持心情愉快。

◎控制饮食，防止暴饮暴食，并注意让患儿多喝水，不喝浓茶等兴奋剂。

◎防止外伤，对于发作次数频繁或大发作的患儿限其在高处活动，防止突然发作坠地受伤。年长儿不要让其单独到公路、河边等危险地方去玩耍，以免发生意外。

◎发作时要及时清除口腔中的东西，及时给患儿解开衣领和裤带，保持呼吸道通畅，为避免将舌头咬伤，可用手绢包在小勺把上，从侧面放在两齿之间，头部也应垫软东西，以防挫伤头部。

◎在按摩的同时，可服用抗癫痫中药或西药，以相互促进疗效。

◎如抽搐持续发作应立即到医院就诊，给予镇惊及脱水疗法，以防呼吸衰竭或脑缺氧，避免留下后遗症。

脑 性 瘫 痪

脑性瘫痪是指小儿在出生前、出生时或出生后由多种原因引起的脑部疾病。本病常伴有智力低下、听觉与视力障碍及学习困难等，以早产儿较多见。现代医学认为发生本病的原因有脑部缺氧、难产、产伤、脑血管疾病导致的颅内出血、以及各种颅内畸形、先天性脑积水、母亲在怀孕早期严重营养缺乏或放射线照射皆可致脑性瘫痪。祖国医学认为，脑性瘫痪属“五迟”范畴，可由父母气血虚弱、先天不足、禀赋亏虚，或后天护理不当，或疾病缠绵，使小儿身体虚弱、肝肾亏损、气血不足发为本病。

诊断

四肢瘫痪，或一侧上下肢瘫痪，上肢一般较下肢重，发生于右侧者较多，或双下肢同时瘫痪，一个肢体瘫痪等。轻症患儿表现下肢轻度瘫痪，走路步态不稳，两手动作笨拙。少数病例可出现各种异常动作，或手足搐动症及舞蹈样动作等。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

顺运八卦2分钟，补脾2分钟，补肾穴、二马穴各2分钟，揉足三里2分钟，揉三阴交2分钟，点揉百会、四神聪各1分钟，揉膊阳池1分钟，四肢分筋法，每日1次。

2. 随证配穴

(1) 肝肾亏虚型

主要表现：面色㿔白，双目无神，智力迟钝，站立行走、牙齿生长迟缓，甚至肢体瘫软无力，凶门宽大难合，舌质淡红，苔薄。

治法：补肝益肾。

配穴：常用穴位加补肝1分钟，揉肝俞、肾俞各1分钟，擦胁肋部2分钟。

(2) 心气不足型

主要表现：面色㿔白，智力较差，精神呆钝，语言发育迟缓，或肢体瘫软无力，或手足颤动，舌质淡，苔薄白。

治法：补气养心。

配穴：常用穴位加补心2分钟，补肺1分钟，揉膻中、内关各1分钟，揉心俞、厥阴俞各1分钟。

(3) 气血虚弱型

主要表现：肢体瘫痪，或走路步态不稳，面色苍白，精神萎靡，疲倦乏力，头发稀疏萎黄，舌质淡，苔薄白。

治法：补气养血。

配穴：常用穴位加补脾延长至5分钟，推上三关3分钟，捏脊每日1次，揉血海1分钟，分腹阴阳1分钟，推四横纹1分钟。

预防护理

◎给患儿易消化富于营养的食物，如鸡蛋、瘦肉、鱼、小米粥、牛奶等，并要多给患儿吃水果和蔬菜。

◎让患儿进行合理的功能锻炼，如日常生活动作训练、语言训练和预防肌肉挛缩的措施等。

◎脑性瘫痪的患儿身体抵抗力大都低下，要避免接触患有传染病和急性感染性疾病的人。

◎可利用早晨起床前和晚上睡前各进行一次按摩，有利于患

儿的健康和疾病恢复。

神经性耳聋

神经性耳聋是指内耳听觉神经、大脑的听觉中枢发生病变而引起听力减退，甚至听力消失的一种病证。现代医学认为引起神经性耳聋的主要原因有以下几种：①小儿在患病后连续使用抗生素如链霉素、卡那霉素、庆大霉素等所引起的中毒性耳聋。②由病毒感染或内耳血管栓塞引起的突发性耳聋。③患传染病如脑膜炎、麻疹、伤寒等所致的传染性耳聋。④由外伤或爆破震动、噪声引起的爆震性耳聋等。祖国医学认为，耳为肾之外窍，为十二经脉所灌注，内通于脑。其病因病机可有风热外袭、肝火上升、痰火郁结、肾精亏损、脾胃虚弱等几种。

诊断

自觉耳中有蝉鸣或其他各种声响，在安静环境中患儿感觉更明显。可伴有发热、头痛、烦躁不安、腹胀、腰酸乏力等多种全身症状。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

两大拇指压住患儿耳门穴，其他四指放在后枕部，用中指交替叩击后枕部1分钟，然后双手拇指一松一按做20次。揉听宫、听会各2分钟，点按翳风1分钟，推肾俞1分钟，擦脊1分钟。

2. 随证配穴

(1) 风热侵袭型

主要表现：自觉耳中憋胀，有阻塞感，耳鸣，听力下降，多伴头痛，发热，恶风，口干口渴，舌质淡红，苔薄白或薄黄。

治法：疏风解表。

配穴：常用穴位加揉风府、风池、合谷、曲池各1分钟，揉大椎、肺俞各1分钟，清肝、清肾各1分钟，清天河水1分钟，拿肩井1分钟，擦脊背20遍。

(2) 肝火上扰型

主要表现：耳聋时轻时重，耳鸣较重时如闻潮声，每遇恼怒之后加重，常伴耳部肿胀，眩晕，面红目赤，口苦咽干，烦躁不宁，大便秘结，小便黄赤，舌质红，苔黄。

治法：清肝泄火。

配穴：常用穴位加开天门1分钟，揉太阳1分钟，点百会50次，清肝2分钟，掐太冲20次，揉三阴交1分钟，揉涌泉1分钟。

(3) 痰火郁结型

主要表现：听力下降，两耳如蝉鸣，自觉头部沉重，胸部胀满，咳嗽痰多，口苦或口淡无味，大便秘结，小便黄，舌质红，苔黄腻。

治法：清热化痰，理气消胀。

配穴：常用穴位加顺揉足三里、丰隆各2分钟，揉承山1分钟，清补脾、清胃各1分钟，逆运八卦1分钟，揉膻中1分钟。

(4) 肝肾亏损型

主要表现：听力逐渐下降，耳鸣昼夜不息，夜间较甚，伴虚烦不眠，头晕目眩，神疲乏力，腰腿酸软，舌质淡而少苔，脉弦数而细。

治法：滋水补肝。

配穴：常用穴位加补肾、补肝各2分钟，揉内劳宫1分钟，揉二马1分钟，清天河水1分钟，揉涌泉1分钟。

(5) 脾胃虚弱型

主要表现：耳聋耳鸣，过劳则加重，伴倦怠乏力，食欲不振，腹部胀满，面色萎黄，大便稀薄，舌质淡，苔薄白。

治法：健脾和胃。

配穴：常用穴位加顺运八卦2分钟，补脾、清胃各1分钟，运土入水1分钟，揉足三里2分钟，揉中脘1分钟，顺时针摩腹2分钟，揉脾俞、胃俞各1分钟。

预防护理

- ◎保证患儿有足够的睡眠时间。
- ◎在推拿期间要避免噪声的干扰。
- ◎饮食宜清淡而富有营养，忌食辛辣温燥食物。
- ◎伴有其他病时要合理治疗，合理用药。

慢 性 鼻 炎

慢性鼻炎是指鼻黏膜、黏膜下层、甚至骨质，由于各种因素所致的慢性炎症。是一种常见、多发、临床上以鼻塞为主要症状的鼻病。其原因多由急性鼻炎演变而来，环境因素，如气温突然变化、空气过于干燥、通风不良、空气污染、粉尘烟雾以及有害气体长期刺激，也可导致本病。小儿体内缺乏维生素类或微量元素锌类物质也可使抵抗能力下降而导致本病的发生。祖国医学认为，本病是由于外感六淫之邪，侵及肺窍，肺窍闭塞所致。

诊断

间歇或交替性鼻塞，于运动出汗时鼻塞好转或通畅，静坐、睡眠或遇冷时鼻塞加重，鼻涕较多，一般为黏液性，如有继发感染则成黏脓性，常伴有头痛、头昏、暂时性嗅觉减退等不适症状。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

推印堂、捏攒竹各 1 分钟，开天门 1 分钟，揉太阳 1 分钟，推迎香 2 分钟，揉黄蜂入洞 1 分钟，按揉合谷穴 1 分钟，揉人中、风府各 1 分钟。

2. 随证配穴

(1) 风寒型

主要表现：鼻塞严重，流涕色白清稀，恶寒发热，无汗，头身疼痛，舌质淡红，苔薄白。

治法：疏风散寒，通窍。

配穴：常用穴位加推上三关 2 分钟，揉外劳宫、一窝风各 1 分钟，补肺 1 分钟，揉曲池、揉大椎各 1 分钟。

(2) 风热型

主要表现：鼻塞不通，嗅觉失灵，口鼻气热，流涕黄黏而稠，可伴有发热、恶风、汗出、口渴，时有咳嗽，舌质红，苔薄黄。

治法：疏风清热，宣肺。

配穴：常用穴位加清肺、清天河水各 2 分钟，揉曲池 1 分钟，退下六腑、清大肠各 1 分钟，拿肩井 1 分钟，揉大椎 1 分钟。

(3) 胆热型

主要表现：鼻塞流黄浊涕，有臭味，嗅觉差，头痛，伴烦躁不安，头晕耳鸣，口苦胁痛，舌质红，苔黄。

治法：清胆泄火。

配穴：常用穴位加清肝3分钟，清肺2分钟，清天河水、退下六腑、清大肠各1分钟，揉总筋1分钟，推下七节骨1分钟，揉太冲1分钟。

(4) 肺气虚寒型

主要表现：鼻塞时轻时重，鼻涕色白量多，无臭味，嗅觉减退，伴气短乏力，形寒肢冷，咳嗽有痰，舌质淡，苔白。

治法：补肺益气。

配穴：常用穴位加补肺2分钟，揉外劳宫、推上三关各2分钟，顺揉神阙2分钟，揉肺俞、脾俞各1分钟，揉足三里1分钟。

预防护理

◎注意身体素质锻炼，增强抗病力，注意饮食，起居调节，预防感冒。

◎避免吸入刺激性的气体，如粉尘、烟雾等，忌食辛辣刺激性食物。

◎平素保持心情舒畅，精神愉快。

◎鼻腔畸形的应到医院进行矫治。

过敏性鼻炎

过敏性鼻炎又称“变态反应性鼻炎”，是人体对某种物质的

变态反应在鼻部的表现。此类病人大多为过敏体质，一旦遇到某些过敏物质便可引起变态反应。如牛奶、鱼虾、牛、羊肉等，其他如尘埃、毛类、花粉、寒冷等，可有家族史、季节性。祖国医学认为，肺为娇脏，外合皮毛，开窍于鼻，如果脾肺气虚，腠理疏松，则易使风寒之邪外袭而发病。

诊断

阵发性鼻痒，继之连续喷嚏，少则一次几个，多则几十个，急性发作时，常有多量水样鼻涕流出，间歇性或持续性鼻塞，还可出现暂时性嗅觉减退、头痛、耳鸣、流泪等症状。

治疗

1. 常用穴位及推拿手法

上推印堂2分钟，揉迎香、黄蜂入洞各1分钟，揉人中2分钟，揉风府1分钟，揉一窝风、合谷、大椎各1分钟。

2. 随证配穴

(1) 风寒犯肺型

主要表现：鼻痒，喷嚏频作，鼻塞，流大量清水样涕，常伴发热，恶风寒，头痛等，舌质淡，苔薄白。

治法：疏风散寒。

配穴：常用穴位加揉外劳宫1分钟，推上三关1分钟，揉肺俞1分钟，拿肩井20次，揉神阙1分钟。

(2) 肺脾气虚型

主要表现：鼻塞，鼻胀较重，嗅觉迟钝，平素头重头昏，四肢无力，食欲不振，大便溏薄，舌质淡或胖，边有齿痕，苔白。

治法：补肺益气。

配穴：常用穴位加补脾3分钟，补肺3分钟，揉气海、神阙

各1分钟，揉足三里、中脘、肺俞、脾俞各1分钟。

(3) 肾气亏损型

主要表现：长年鼻痒，鼻塞不通，喷嚏连作，清涕难敛，早晚较甚，常伴有神疲乏力，畏寒肢冷，头晕耳鸣，腰膝酸软等，舌质淡，苔白。

治法：补肾纳气。

配穴：常用穴位加补肾2分钟，补命门2分钟，补脾2分钟，揉二马2分钟，揉外劳宫、揉膊阳池各1分钟，揉脾俞、肾俞各1分钟。

预防护理

◎寻找过敏原，避免接触，经过长时间脱离过敏原后，患儿会对过敏原的敏感性降低或消失。

◎改善周围环境，坚持身体锻炼，提高人体的抵抗力。

◎避免食用鱼虾、海味、牛乳、蛋黄等食物。

附录一 小儿保健推拿

增强体质的保健推拿

由于小儿脏腑娇嫩，各器官功能尚未发育成熟，因此，对疾病的抗御能力相对较弱，易罹患疾病。为了增强小儿体质，提高自身抗病能力，使其更好、更健康地发育成长，采用推拿疗法是一种行之有效而又无副作用的自然疗法。

推拿方法

第一种：顺运八卦 2 分钟，清补脾 3 分钟，清补大肠 2 分钟，揉神阙、中脘各 1 分钟，揉足三里 2 分钟，清补肺 1 分钟。

第二种：捏脊 1 日 1 次。

第三种：逆揉巨阙 2 分钟，逆揉中脘 2 分钟，清补脾 2 分钟，揉大椎 1 分钟，揉膻中 1 分钟，揉涌泉 1 分钟。

小儿厌食保健推拿

厌食是目前儿童中常见疾病，轻者造成形体消瘦，重者造成营养不良、贫血或并发其他疾病，故保证小儿的饮食正常，平时可以采用保健推拿，以预防厌食的发生。

推拿方法

第一种：顺运八卦 2 分钟，清胃穴 2 分钟，清补脾 1 分钟，清补大肠 1 分钟，推四横纹 1 分钟，刮四缝 1 分钟。

第二种：揉巨阙 2 分钟，揉中脘 2 分钟，揉天枢 1 分钟，揉足三里 1 分钟，推下承山、七节骨各 1 分钟。

第三种：捏脊1日1次。

近视眼保健推拿

近视眼又叫“屈光不正”，是指眼的屈光系统不能正常地把远处的光线聚焦在视网膜上，而是把焦点落在视网膜之前，形成近视。表现为看远处模糊，而看近处则不受影响，同时常伴有眼睛酸痛、发胀、头晕等症状。主要原因是自小看电视、看书距离太近或在光线较弱的环境下看字迹较小的书引起的。

推拿方法

幼儿仰卧，用双拇指沿眼轮匝肌作环形揉动2分钟，再用拇指尖沿眼眶周围做压法2分钟，用拇指拿眉弓，再点揉印堂、睛明、攒竹、瞳子髎、鱼腰、四白穴各1分钟。

点揉合谷、清肝各1分钟，揉风池、肝俞各1分钟，揉三阴交、肾俞各1分钟。

小儿健脑保健推拿

小儿健脑保健，除了注意饮食调整、营养物质、知识的学习、环境的影响外，推拿健脑亦能促进孩子大脑的发育，使孩子更聪明，更健康。

推拿方法

第一种：推擦脊柱，以局部发热为宜，揉肝俞、脾俞、肾俞各1分钟。

第二种：捏拿两侧颈部大筋，揉风府，用拇指从印堂经攒竹、鱼腰到太阳数遍，点百会、头维、风池、天柱穴。

第三种：用手掌在枕后部施搓揉法，温热为宜，揉风府、肩井、合谷、后溪穴各1分钟。

小儿感冒保健推拿

感冒，是由多种病毒引起的常见呼吸道疾病，尤其是素体虚弱的小儿，最易感受外邪而发病，所以采用推拿预防感冒是一种行之有效的办法。

推拿方法

第一种：顺揉一窝风2分钟，清补肺2分钟，掐虎口穴（合谷穴）1分钟，揉风池1分钟。1日1~2次。

第二种：揉人中，每次20~30遍，1日1次，力量均匀，不可过重，揉风府穴1分钟，揉风池穴1分钟，揉大椎1分钟，揉曲池1分钟，1日1~2次。

第三种：揉迎香1分钟，揉人中1分钟，肺俞、风门、膻中各1分钟，1日1~2次。

鼻炎、鼻窦炎保健推拿

准备姿势：让患儿端坐，操作者将手洗净擦干，注意力集中，然后进行操作。

第一式：用右手食指、中指和无名指按顺时针方向揉按百会穴，揉一圈为1次，共60次。

第二式：用两手的食指和中指，同时按摩靠近眼内角的鼻梁，由上到下为1次，共80次，或以局部红润为止。

第三式：旋转揉按迎香穴，转揉一圈为1次，共70次。此法有通鼻气的效果。

第四式：两手食指、中指和无名指，同时揉按印堂，然后由前额移到阳白、丝竹空，直达太阳穴为1次，共60次。具有清醒头目的作用。

上述四式为一套，每次做3遍，每日1~3次，坚持2周便

可见效。

牙痛保健推拿

牙痛是牙齿病中最常见的一种症状，牙齿本身的疾病与牙周的疾病都可以引起牙痛。多因遇冷、遇酸、遇甜等刺激所致。为了避免牙痛的发生可采用推拿方法，保健牙齿。

推拿方法

按压下关、颊车穴各1~2分钟，揉迎香、四白穴各1分钟，捏拿肩井穴1分钟，点揉承浆穴1分钟，按压内劳宫穴和压痛点各1分钟。

配穴：牙龈红肿，牙齿疼痛，遇冷痛减，遇热痛增，间有发热，恶寒，加揉风门、大椎、曲池、内关；牙齿隐隐作痛，微红，微肿，咬物无力，兼有腰酸膝软、耳鸣者加揉肾俞、涌泉穴等。1日1~2次。

口眼歪斜推拿

第一式：操作者两手食指按患儿两太阳穴，两中指按两颊车穴，两无名指按两大迎穴，用左手大拇指端顶住承浆穴，右手大拇指端顶住人中穴，两手大拇指端同时拨人中、承浆两穴的筋。

第二式：两手的食指、中指和无名指，仍按第一式按住穴位不动。口眼歪斜向左者，右手大指端按住左眼下承泣穴的筋不动，左手大拇指端按住右眼承泣穴，然后分拨其筋；再用右大拇指端按住左四白穴不动，用左手大拇指端按住右眼承泣穴，然后分拨其筋。如口眼歪斜向右边者，左手大拇指端按住右眼承泣穴不动，右手大拇指端按住左眼下四白穴，分拨其筋；再将左大拇指端按住右眼下四白穴不动，右手大拇指端按住左眼下承泣穴，分拨其筋。

第三式：操作者用两指拨鼻眉际两攒竹穴的筋 10 多次；

第四式：操作者用两中指按住两太阳穴，同时用两大拇指由印堂穴向上推送至发际的天庭穴 3 次；

第五式：操作者用两大拇指由病人攒竹穴缓缓按过两眉际至太阳穴，大拇指微按太阳穴；

第六式：接着由两太阳穴推至两耳旁；

第七式：操作者用两手大拇指和食指上提两耳轮，以食、中指按耳后，大拇指和食指由耳窍下拉至两耳垂；

第八式：操作者用两手中指拨开两耳门，随即用两手大拇指封闭两耳门；

第九式：向相反方向捣两手小天心穴，每分钟约 150 次，共捣 10 分钟；

第十式：操作者用右手掌将病人后项擦热，并告诉家长注意护理，以免受风。

附录二 其他疗法

简易经穴推拿法

适应证：用于胸腹胀满，恶心呕吐，腹痛，大便不畅，失眠，神经衰弱，心慌气短等。

患儿姿势：仰卧，暴露腹部，冬季可穿衬衣，使患儿安静，消除紧张，自然呼吸，操作者站在患儿右侧，将两手搓热，避免刺激皮肤引起患儿不安或哭闹。

操作方法

第一步：操作者用左手中、食指或拇指，按在心窝部的巨阙穴（肚脐上6寸），右手按在脐上1.5寸的阑门穴，顺揉2分钟。

第二步：左手不动，右手按压脐上3寸的建里穴，推揉1分钟。

第三步：左手拇指压在脐上3寸、旁开2寸的石关穴，中指或食指压在脐上4寸，旁开2寸的梁门穴，右手中指推揉脐下1.5寸的气海穴1分钟。

第四步：右手拇指压在脐上1寸的水分穴，中指扣压右侧肋下2寸的带脉穴，同时左手拇指压在右手拇指上，中指扣压右侧带脉。注意中指扣压右侧带脉时要往里抖动1分钟。

第五步：左手中指不动，仍按巨阙穴，右手拇指不动，中指压在左侧章门穴（脐上2寸旁开6寸），推揉2分钟。

第六步：左手不动，右手拇指按压在右石关，中指按压左梁门，推揉1分钟。

第七步：左手无名指按压天突穴（喉结下凹陷的地方），中指压在第一肋骨的胸骨中点，食指按压第一肋下缘中点，右手食、中、无名指推揉剑突下的巨阙穴。

第八步：左手按压心窝部的巨阙穴，右手食指按压脐上5寸的上脘穴，中指按压脐上4寸的中脘穴，无名指按压脐上2寸的下脘穴1分钟。

第九步：左手不动，右手中指仍推揉脐上1寸的地方1分钟。

第十步：左手拇指按压右石关穴，中指按压左梁门，右手中指揉气海1分钟。

第十一步：右手五指自然屈曲，用手背从脐右侧或脐上开始围肚脐按压3遍。

第十二步：引气归原。左手拇指和食指分别捏住水分穴（脐上1寸）与阑门穴之间的肌肉，右手用同样手法捏住气海两侧的肌肉，两手同时用力上提1分钟。

第十三步：左手拇指和中指分别压住两侧或中穴（在第一胸骨旁开2寸），右手放在下肢两侧的阴陵泉（此穴相当于针灸学上的血海部位）1分钟。

第十四步：让患儿仰卧，操作者两手拇指同时压住大椎穴（第七颈椎下）两手食、中二指同时扣压肩井穴（在大椎穴与肩髃穴之中点）1分钟。

第十五步：食、中指不动，两拇指压按两风门穴（第二胸椎下旁开2寸）1分钟。

第十六步：食、中指不动，两拇指压住第四胸椎下旁开3.5寸的膏肓穴（两侧肩胛骨内侧下1/3的地方），按压1分钟。

第十七步：左手食指和拇指压住两膏肓穴不动，右手拇、食二指由脊椎两侧旁开1.5寸的地方，由上向下按压1遍。

四肢分筋法

(一) 上肢分筋法

1. 左上肢分筋法

姿势：病人取坐位或仰卧位。操作者站在患儿的左外侧，左手握住患儿右手腕。

第一式：操作者用右手四指握住患儿左手腕正面，大拇指压住患儿手腕背面凹陷处，食、中和无名指扣住患儿手腕正面，然后用左手握住患儿的左手食指、中指、无名指和小指向里往返拉合数次，同时用右手捏住患儿手腕的右手大拇指，分拨患儿左腕骨背面的筋。

第二式：患儿左臂举起，手向上扬，操作者用右手将患儿的左臂肘扣住，以大拇指扣曲池（在肘窝横纹端与肱骨外上髁之间，半屈肘定穴）部位的筋，食、中指扣住肘后的筋，用左手大拇指扣住患儿左手腕背面，食指和中指拿住患儿左手腕，向里向下合拨，用大拇指向下压，食指和中指同时趁势向上挑，使患儿手掌向上仰。

第三式：操作者右手不变，随即往外仰拨，左手仍捏住患儿腕骨，大拇指顶住患儿手背的中指骨往里压，食、中指扣住脉门（指诊脉的部位，在手腕正面），使患儿的手勾起往外仰拨，按照第二、三式，仰合、里外、上下分拨3~5次。

第四式：病人左臂弯曲平伸，操作者左手握住患儿左手腕，手心对着患儿手腕背面，大拇指扣住患儿的虎口（即合谷穴），食指和中指扣住患儿的脉门，右手食指和中指按住患儿的肩头，用右手大拇指扣住腋下前面的筋分拨3~5次。

第五式：操作者一手握住患儿手腕，一手拨患儿腋前部位的筋数下。

第六式：操作者左手仍依照第五式握住患儿手腕，右手大拇指扣住患儿左肩头，食指和中指将腋下后面的筋扣住，分拨肱骨外侧的筋，一下一下地往下拨至肘为止，连续拨3~5次。

第七式：操作者左手仍握住患儿左手腕，用右手大拇指扣住患儿左肘下外侧的筋，同时用食指和中指扣住肘下面与大指相对处，大拇指向下扣拨，食指和中指向上仰拨，顺其筋脉，一次次地向前仰合分拨到大拇指与列缺穴为止。分拨时患儿五指因有感觉而摇动。因为所拨的筋都与五指相通，上通手臂下达手指，所以各指都动。

第八式：患儿左臂反仰平伸，操作者用右手大拇指顶住患儿左手掌背面中指的骨节，食指和中指扣住患儿手掌及腕骨右侧，用右手大拇指往里推，食指和中指向外合，使患儿的手掌成为向上往里勾并与肩头相对。同时用左手的大拇指扣住患儿左肩井上的大筋，食指和中指扣住背后肩胛骨，同时用右手将患儿的左手往外伸出，左手扣住患儿左肩的筋往后推，使患儿左臂反转，将其手臂的筋伸开。

第九式：操作者右手仍扣住患儿左手腕骨（位置不变），用左手大拇指扣住患儿左腋下前面的筋，食指和中指扣住肩井部位，右手仍扣患儿手腕，将其臂向后反背1~2次，病人的左臂能反背到右面软肋下为止，但不可勉强。如遇到臂部有病不能屈伸或半身不遂者，能反背到何处，即到何处止，渐渐筋脉舒开即能反背到软肋下。

第十式：患儿的左臂平行伸直，操作者再照第四、五、六式重做一遍，即用右手捏住患儿左腕，用左手的大拇指和食指，将患儿的五指顺次扣拨，同时用右大拇指也顺次拨弄左手腕背面与指相通的筋。

第十一式：操作者用右手握住患儿的左手无名指和小指，左

手握住患儿的食指和中指，用两手大拇指扣住病人的左手背面，颤抖患儿的左臂，舒其经络。

第十二式：操作者用右手反捏住患儿左手腕，用左手大拇指托住患儿左臂腋下前面的筋，以虎口、食指和中指托住左腋下全部及后面的筋，用右手将患儿左臂向后反背过腰至右边软肋为止，反复做3~5次。但切不可勉强，能背到何处就背到何处。

第十三式：操作者左手握住患儿左手腕，用右手大拇指扣住患儿的肩井部位，食、中指按住患儿的肩胛骨，将肩胛向上拔起，然后从胸前循右上方，将患儿左臂卷起，使手掌微仰微抬，从胸前循右上方，即将患儿的手掌向外翻，向外绕，循左下方徐徐绕至肋下间，随即顺其势，经胸前向上方反复旋绕做环形运动，如此反复3~5遍。

第十四式：操作者仍用左手握住患儿左手腕，向右前方扬起，用右手掌按住患儿脊椎骨第一椎旁左边的大筋，慢慢往下推按至第十四椎旁左肾俞为止，做1次或3次均可。

第十五式：操作者用右手扣住患儿左肩头，左手托捏腋下的筋，患儿将左臂扬起，从头顶摸向右耳，反复3~5次。此式用于左臂上举不正常者。

2. 右臂分筋法同左臂分筋法手式相同。操作者站在病人的右外侧，握住病人的手腕，依照左臂分筋法的手式进行操作。

（二）下肢分筋法

1. 右腿分筋法

患儿仰卧，左腿平伸，右腿屈起，足趾往里靠合，足跟与大腿后侧相对，操作者站在病人的右侧。按以下各式施治。

第一式：操作者用两手大拇指扣住右膝盖两膝眼穴，两手食指、中指及无名指扣入右膝后两边的筋，向左侧缓缓拨动3~5次。

第二式：患儿右腿屈起，操作者用右手大拇指按住膝盖，中指和无名指扣住阴陵泉，用左手食指和中指扣住膝盖下面的大筋，大拇指扣住膝后，食指和中指拨膝下的筋，缓缓向前拨动至臀部。

第三式：操作者用右手掌按在患儿膝上，右手中指和无名指扣住膝盖，左手大拇指扣住膝后侧的大筋，缓缓向前拨至环跳穴。

第四式：操作者用左手掌按住患儿膝上，用右手中指和无名指扣住膝面，大指扣住后内侧大筋，缓缓向前拨动3~5次。

第五式：患儿右腿屈起，操作者用右手食指和中指扣住膝部里侧阴陵泉的大筋，大拇指扣在膝上，用左手大拇指扣住右膝盖上端，食指和中指扣住委中的筋，向下缓缓拨动，揉到承山穴为止，往返3~5次。

第六式：操作者用左手扣住患儿脚腕，用右手中、食指按在膝下内侧，大拇指扣住右足三里的筋，顺其筋势，向下缓缓拨至悬钟穴，往返3~5次。

第七式：患儿右腿屈起，操作者用右手大拇指扣住足三里部位的筋，食指和中指扣住小腿后面的筋，同时左手食指和中指扣住右足跟，大拇指分拨脚腕的筋，自右足内踝起，经解溪（在足背的踝关节横纹中点凹陷处）至外踝止，将其筋往后拨动3~5次。

第八式：操作者右手仍如前式，位置不变，用右手大拇指拨动脚背前面的筋，反复拨动3~5次。

第九式：患儿右腿蜷起，右脚外侧压在左膝上，操作者用左手中指和无名指扣住右膝后内侧阴陵泉部位的筋，左手大拇指扣在膝上。用右手大拇指指端，分拨右三阴交的筋。

第十式：左手中指和无名指仍扣住右阴陵泉的筋（与第九

式相同)，右手握住右足内踝和外踝，屈伸振动 3~5 次。

第十一式：接上式将右腿蜷起，足跟靠股间，足趾微往里合，操作者用右手大拇指扣住右踝外侧大筋，食指和中指按住后足外踝及足跟，用右手掌按在右肢上，向左侧缓缓下按 3~5 次。

第十二式：操作者右手仍然不动，位置不变，但向左侧面压按至左腿。左手叉开，在右环跳部位揉推 3~5 次后，改顺胯后推至肾俞穴，左手随即改成钳形，将两肾俞穴扣住拨 1~2 次为止。

第十三式：手法与第一式相同。

第十四式：两腿合治。患儿将两腿同时屈起，操作者将右腿蜷起压在患儿足腕之上，使其足不能前伸，以便校正。此法为两腿合治法，其手式是两手各按两腿膝上，先后将腿向前及左右摇拨，以校正两腿各部的筋。两手交叉扣住两膝，再向怀内校正，以校正腰腿部的筋。

2. 左腿分筋法与右腿分筋法相同。

附录三 推拿三字经及注释

推拿三字经

徐谦光	奉萱堂	药无缘	推拿恙
自推手	辨诸恙	定真穴	画图章
上疗亲	下救郎	推求速	惟重良
独穴治	有良方	大三万	小三千
婴三百	加減良	分岁数	轻重当
从吾学	立验方	宜熟读	勿心慌
治急病	一穴良	大数万	立愈恙
幼婴者	加減良	治缓症	各穴良
虚冷补	热清当	大察脉	理宜详
浮沉者	表里恙	迟数者	冷热分
辨内外	推无恙	虚与实	仔细详
字廿七	脉诀讲	明四字	治诸恙
小婴儿	看印堂	五色纹	细心详
色红者	心肺恙	俱热症	清则良
清何处	心肺当	退六腑	即去恙
色青者	肝风张	清则补	自无恙
平肝木	补肾脏	色黑者	风肾寒
揉二马	清补良	列缺穴	亦相当
色白者	肺有痰	揉二马	合阴阳
天河水	立愈恙	色黄者	脾胃伤

若泻肚	推大肠	一穴愈	来往忙
言五色	兼脾良	曲大指	补脾方
内推补	外泻良	大便闭	外泻良
泻大肠	立去恙	兼补脾	愈无恙
若腹痛	窝风良	数在万	立无恙
流清涕	风感伤	蜂入洞	鼻孔强
若洗皂	鼻两旁	向下推	和五脏
女不用	八卦良	若泻痢	推大肠
食指侧	上即上	来回推	数万良
牙痛者	骨髓伤	揉二马	补肾水
推二穴	数万良	治伤寒	拿列缺
出大汗	立无恙	受惊吓	拿此良
不醒事	亦此方	或感冒	急慢恙
非此穴	不能良	凡多汗	忌风扬
霍乱病	暑秋伤	若止吐	清胃良
大指根	震艮连	黄白皮	真穴详
凡吐者	俱此方	向外推	立愈恙
倘肚泻	仍大肠	吐并泻	板门良
揉数万	立愈恙	进饮食	亦称良
瘟疫者	肿脖项	上午重	六腑当
下午重	二马良	兼六腑	立消亡
分男女	左右手	男六腑	女三关
此二穴	俱属凉	男女逆	左右详
脱肛者	肺虚恙	补脾土	二马良
补肾水	推大肠	来回推	久去恙
或痘疹	肿脖项	仍照上	午别恙
诸疮肿	明此详	虚喘嗽	二马良

兼清肺	兼脾良	小便闭	清膀胱
补肾水	清小肠	食指侧	推大肠
尤来回	轻重当	倘生疮	辨阴阳
阴者补	阳清当	紫陷阴	红高阳
虚欠者	先补强	诸疮症	兼清良
疮初起	揉患上	左右旋	立消亡
胸膈闷	八卦详	男女逆	左右手
运八卦	离官轻	痰壅喘	横纹上
左右揉	久去恙	治歉症	并癆伤
歉弱者	气血伤	辨此症	在衣裳
人着裕	伊着棉	亦咳嗽	名七伤
补宜多	清少良	人穿裕	他穿单
名五癆	肾水伤	分何脏	清补良
在学者	细心详	眼翻者	上下僵
揉二马	捣天心	翻上者	捣下良
翻下者	捣上强	左捣右	右捣左
阳池穴	头痛良	风头痛	蜂入洞
左旋右	立无恙	天河水	口生疮
遍身热	多推良	中气风	男左逆
右六腑	男用良	左三关	女用强
独穴疗	数三万	多穴推	约三万
遵此法	无不良	遍身潮	分阴阳
拿列缺	汗出良	五经穴	肚胀良
水入土	不化谷	土入水	肝木旺
小腹寒	外劳官	左右旋	久揉良
咀唇裂	脾火伤	眼胞肿	脾胃恙
清补脾	俱去恙	向内补	向外清

来回推	清补双	天门口	顺气血
五指节	惊吓伤	不计次	揉必良
腹痞积	时掇良	一百日	即无恙
上有火	下有寒	外劳宫	下寒良
六腑穴	去火良	左三关	去寒恙
右六腑	亦去恙	虚补母	实泻子
日五行	生克当	生我母	我生子
穴不误	治无恙	古推书	身手足
执治婴	无老方	皆气血	何两样
数多寡	轻重当	吾载穴	不相商
老少女	无不当	遵古推	男女分
俱左手	男女同	余尝试	并去恙
凡学者	意会方	加减推	身歉状
病新久	细思详	推应症	无苦恙
传后世	救人良		

推拿三字经注释

徐谦光 徐宗礼的别名。

奉萱堂 母亲患病不能服药，于是习练推拿。

药无缘 服药即吐，无法治疗。

推拿恙 患病的母亲接受推拿后不药而愈。按母亲之意这样做是尽孝。

自推手 从此以推拿作为治病的方法。

辨诸恙 辨别疾病的性质、类型，然后决定使用的手法。

定真穴 找出有效的穴位。

画图章 摸清人身上的穴位，并画出图表，以备忘记。

上疗亲 在上治疗亲属、朋友或高贵人的疾病。

下救郎 在下解救贫民百姓的疾苦。

推求速 推大人速度要快，手法要重。速度快可以使气血循行加快，驱除外邪，推小儿速度也要快，但手法要轻。

惟重良 推拿就像采用其他良方一样，只要弄清什么病，辨明什么穴，依法推拿，立即见效。

独穴治 独穴是指一个穴位而言。推拿时速度要快，时间要长。

有良方 只要配穴适当，无不应手而愈。良方是指用后立刻见效。

大三万 自16岁至100岁为大。此时小孩血气强，所以推拿次数要多，不能拘于死数。

小三千 自5岁至10岁为小。男则气血未强，女则天癸未至（还不成熟），所以推拿次数要少。

婴三百 1岁以内为婴儿，血气细弱，所以推拿次数更要减少。

， 加減良 人的身体有强弱之分，年岁大小不等，病情有轻重差异，临床推拿时要酌情施治。

分岁数 分清病人的年龄大小。

轻重当 依据病的轻重，施治恰当。

从吾学 学习只要熟读，善于思考，即求学可成。

立验方 不断总结有效的穴位，确立有效的治病方法。

宜熟读 要认真读书，不熟读就不能灵活应用。

勿心慌 粗心大意学不好推拿，应该认真踏实。

治急病 治疗急性病。

一穴良 只要认准拿，一穴就能治愈。

大数万 大人需推拿数万次。

立愈恙 只要选穴准确，病能立愈。

- 幼婴者 1~3 岁的小儿。
- 加減良 根据岁数的大小和病的轻重确定推拿次数的多少。
- 治緩症 多指病久不能自愈的癆伤、外感或内伤等症。
- 各穴良 选好穴位，认真操作，无不奏效。
- 虛冷补 虛冷者为寒氣亏，当用补法治疗。
- 热清当 热病当用泻法治疗。
- 大察脉 大人要察看脉象，分清色泽，要弄清何色与何脏腑有关。
- 理宜详 病因病理要详细分析。
- 浮沉者 浮主表证，轻手可得；沉主里证，推时手法要重。
- 表里恙 要辨别是表证还是里证。
- 迟数者 视脉的快慢，辨别寒热。
- 冷热分 分清病是由内因还是外因引起的。
- 辨内外 外因感受于外邪，内因病发于内脏。
- 推无恙 只要辨明何病，分清表里、冷热，有些病推之可愈。
- 虚与实 通过脉象辨别疾病的虚实。
- 仔细详 脉的虚实，要仔细推详。
- 字廿七 脉有二十七种。
- 脉诀讲 治病虽讲脉诀，但也有脉与病不相符者，应细心体会。
- 明四字 先弄清脉的浮、沉、迟、数四种常见脉象。
- 治诸恙 诸病不外四脉，一般病多伴有此四脉。
- 小婴儿 三岁以下的婴幼儿。
- 看印堂 小儿脉短小，不如看印堂为宜。
- 五色纹 即红、青、黄、白、黑五种肤色。
- 细心详 印堂穴处，用水洗净，观之分清红、青、黄、白、

黑五色，以何色分何病。

色红者 在两目中间，睛明之上辨之色红者，是心与肺同受邪所致。

心肺恙 因肺与心相连，凡有红筋，多是心肺病引起。

俱热症 凡属热性病证。

清则良 热者清之，清者泻也，实则泻之，虚则补之，热病必用泻法。

清何处 看小儿印堂五色纹，则知当清何穴。

心肺当 清肺、清心必应视之准确，如需清心以天河水代之。

退六腑 色紫者，是热之甚，必须大清六腑穴。

即去恙 推至热退病愈为止。

色青者 一般是肝热或受惊引起。

肝风张 若色有青者，多有肝风内动或惊吓所致。

清则补 清补者必需辨明虚实，虚则补之，实则清之，虚实夹杂的要攻补兼施。

自无恙 清补得宜，自能去病。

平肝木 肝为将军之官，可平不可补。虚则补其母，即补肾水。

补肾脏 补肾即补肝，肾为肝之母，古言水生木，即指此而言。

色黑者 色黑一般说是风盛，指肾中有寒。

风肾寒 风入肾经，其色必黑，病必寒证。

揉二马 二马为穴名，此穴如似八味地黄丸，大补肾中水火而去寒。

清补良 若上热下寒，必须清上温下。

列缺穴 诸风、诸惊，必须拿列缺穴，肾寒久拿出汗，风邪

则散。

亦相当 列缺穴，寒水能解，是效穴。

色白者 色白一般是指肺病的表现。

肺有痰 印堂色白者，一般认为肺中有痰。

揉二马 此穴属肾经穴，先揉此穴取热。

合阴阳 自阴阳处往总筋合，即向内合之。

天河水 此穴能清上焦之热，重推可去痰。

立愈恙 推之恰当，病能很快治好。

色黄者 印堂皮色黄者为脾胃之病。

脾胃伤 小儿只有脾胃症状而印堂处发黄者，多见食瓜果不节而损伤脾胃。

若泻肚 如果小儿发生腹泻，多因胃肠功能失调所致。

推大肠 大肠与肺相表里，其在食指外侧，腹泻者推大肠穴。

一穴愈 用一穴即能治好病，是经实践总结出的经验。

来往忙 必须往来多推，效果才佳。

言五色 指红、青、黄、白、黑五色。

兼脾良 脾为肺之母，因小儿饮食不节，无不伤脾胃。

曲大指 大指属脾，若补，必须屈拇指推之。

补脾方 脾为万物之母，乃后天之本也，主治消化道疾病。

内推补 屈指向内推为补。

外泻良 正指向外推为泻，来回推为清补。

大便闭 若便闭不行，是脾燥或积滞所致。

外泻良 伸直大指，向外推为泻脾，泻之气则下降。

泻大肠 大肠与肺相表里，肠结是肺燥所致，而肺燥大肠亦燥而脾又为肺之母。故必须泻之。

立去恙 脾肺为母子关系，若肺燥肠结用泻法，则可去病复

康。

- 兼补脾 脾为后天之本，补脾可促进人体强壮。
- 愈无恙 用推法补脾，治愈者一般无反复。
- 若腹痛 如见小儿腹痛，多因寒邪或伤食所致。
- 窝风良 用一窝风可取得良好疗效。
- 数在万 一窝风穴专治下寒，尤其止腹痛，多推应手而愈。
- 立无恙 除病痛，可以很快获效。
- 流清涕 鼻流清涕者，多因风寒所致，多揉一窝风可愈。
- 风感伤 因外感风寒而伤风感冒。
- 蜂入洞 用中、食二指入鼻孔，上下推黄蜂入洞穴。
- 鼻孔强 鼻乃肺之窍，位居于脾，推之可去风寒。
- 若洗皂 用中、食指如洗皂式。
- 鼻两旁 洗皂在鼻两旁。
- 向下推 屈中、食指向下推之。
- 和五脏 调和五脏之气。
- 女不用 女子不用此穴。
- 八卦良 运八卦调和五脏之气，亦可获良好效应。
- 若泻痢 若见腹泻、痢疾病症。
- 推大肠 推大肠穴效果好。
- 食指侧 食指外侧乃大肠真穴。
- 上即上 食指外侧上节上，即第二穴位，似豆粒大小。

（注：后人认为此穴从指根到指尖）

来回推 平力来回推之，其数可根据病的轻重变化确定。

数万良 病重者推的时间要长。

牙痛者 出现牙痛病症的患者。

骨髓伤 由于牙为骨之余，骨乃髓之腑，肾主骨生髓，当肾精耗损，水不济火，虚火上炎致使牙疼。

揉二马 此穴如服八味地黄丸，大补肾中水火，久揉则阴阳双补。

补肾水 补肾水能滋水潜阳。

推二穴 推二马、肾水穴。

数万良 凡治下元与用药相同，少则不验，必须多推。

治伤寒 伤寒汗出即解，自感冒日起不治，久则传里。

拿列缺 重推此穴，毛孔俱开，汗出而解，力拿双手亦可。

出大汗 用力久拿，必出大汗，自头至足，方可为佳。

立无恙 汗出而病解。

受惊吓 小儿受惊先掐五指节，里外每节各掐七下。

拿此良 然后拿列缺即愈。

不醒事 大小老少倘不醒人事，穿衣来不及者力拿此穴，能救半刻钟。

亦此方 神志昏迷闭口紧者，拿此穴必醒之。

或感冒 即伤风、伤寒等一切外感表证。

急慢恙 急、慢惊风等症。

非此穴 非拿此列缺穴，不能爽快，故称仙掌奇穴。

不能良 凡遇怪病，非拿此穴不能治愈。

凡出汗 凡是出汗的病症。

忌风扬 汗后忌风，以防风邪乘汗孔开泄而入。

霍乱病 即指上吐下泻的急性胃肠道疾病。

暑秋伤 发病于暑后秋前，因中暑气又中寒气所致。

若止吐 上吐者为阳霍乱及受暑过重，胃气不降所致。

清胃良 止吐以清胃为主。

大指根 大鱼际的外侧缘（从手腕到大拇指跟）。

震艮连 是八卦穴当中的两方位。

黄白皮 胃穴上为黄白之皮肤时，自艮向外推为清。

真穴详 赤白肉际外为胃的真穴。

凡吐者 凡是呕吐病人都要从里向外推，不仅指霍乱病。

俱此方 病之吐为胃气上逆而不下行所致，故用此法治疗。

向外推 凡治气逆者泻之则气下降，补之则气上升。

立愈恙 脾胃之气，升降适宜，而不上逆，故能很快治愈。

倘肚泻 如果是单纯性腹泻者为脾胃不和，感受暑热寒邪所

致。

仍大肠 仍来回清补大肠，利小便，而止大肠之泻。

吐并泻 又吐又泻的病人可见于霍乱，此病多为感受疫疠之

邪引起。

板门良 此穴亦属胃经，盖脾虚作泻，胃虚作呕，此穴能通
达上下之气。

揉数万 根据病的轻重，决定推数多少，本病以多揉为效。

立愈恙 一穴重揉而能立刻见效，多见于急病。

进饮食 经推拿后能进饮食。

亦称良 此板门穴属胃经，能治心口痛，又能治上吐下泻，

故称良穴。

瘟疫者 瘟疫伤寒，两脉细而数，虽汗不解为瘟疫。

肿脖项 即指腮腺炎而言，故人称痧腮，如治疗不及时男孩
可并发睾丸炎。

上午重 一般上午发热重，肿块以耳垂下为主，疼痛、发
胀，有囊性感。

六腑当 重推六腑以愈为止，此穴大凉，犹如生石膏的寒
性。

下午重 下午属阴分，阴在血分，故多为寒证。

二马良 重推二马穴以愈为止，此穴大热去寒。

兼六腑 兼退六腑之穴以清热解毒。

立消亡 只要时间掌握得好，穴位选得准，推之能见效。

分男女 治病当分男女之手，这是古人所说。

左右手 必须男用左手，女用右手。

男六腑 男孩多推六腑。

女三关 女孩多推右三关。

此二穴 虽说男左女右，但作用相同，效果一样。

俱属凉 左六腑，右三关，男女相反而穴相同。

男女逆 根据病的寒热不同，采用的穴位可有变化。

左右详 左右手的穴，必须详细辨别取穴。

脱肛者 直肠脱出肛门的患者是脾肺气虚所致。

肺虚恙 因肺虚引起的疾病。

补脾土 脾土生肺金，虚则补其母，脾土不能生肺金，故当用补法，即为上虚而补其母，脾为肺之母。

二马良 二马治阴寒而滋补肾水，下寒者揉此穴，似八味地黄丸，有补肾壮阳之功。

补肾水 补肾水即是滋补肾阴，水旺而能生肝木，肝气调达，不克脾而脾健四季不受邪。

推大肠 大肠乃肺之表腑，若阳虚而不能升提，下陷之气使肛门脱出难愈。今用推补法，肠健则肺气旺盛，肺旺则能升提下陷之气，而病痊愈。

来回推 来回推大肠穴，能固大肠而利小便，和血顺气，故湿痢、脱肛者皆可。

久去恙 此病恢复慢，推的时间亦长。

或痘疹 一般来说疹出于腑，痘出于脏，疹在气分，虚者可用人参治疗；痘在血分，虚者可用当归治疗，这样可驱除毒邪。

肿脖项 疹痘结于项间，必须男推六腑，女推右三关。

仍照上 依照腮腺炎的治疗法。

午别恙 根据上下午得病辨别是阳证，还是阴证。

诸疮肿 诸疮症也有阴阳之分，阳清凉，即阳证用寒药，阴温补，即寒证用温药，半阴半阳，用清补。

明此详 一定要辨别发病的时间，然后选择推拿时间的长短。

虚喘嗽 这里是指肾虚，肾不纳气之喘嗽，或脾肺气虚咳声无力而言。

二马良 肾阳虚必有寒，用二马补肾壮阳效果显著，可使命门水火俱旺。

兼清肺 肺虚则气必逆，故兼用清肺。

兼脾良 补脾土即补肺金，土能生金，是虚则补其母的道理。

小便闭 小便不解，是膀胱气化不利，肾阳虚温化失调所致。

清膀胱 以利尿洁腑，使小便通畅。

补肾水 肾水得补而气壮，气壮能出胞胎之脉，以行心肾之交，此所为水火相济。补肾水以壮阳，补肾增强温化的作用。

清小肠 小肠为心之腑，为分清降浊的机关，浊者归大肠，清者归膀胱，分利有条，小便自利无阻。

食指侧 食指外侧是大肠的穴位。

推大肠 直肠又属大肠之末节，下连肛门，皆大肠也。

尤来回 小肠下口分别清浊水液，渗入膀胱，渣移入大肠，来回推，能分别清浊。

轻重当 手法轻重要适当，力量要均匀，快慢求一致。

倘生疮 若身体生疮。

辨阴阳 必须辨明阴阳之候。

阴者补 阴证者当用补法。

- 阳清当 阳证者当用清法。
- 紫陷阴 凡生疮平塌，白或紫色而陷者当为阴证。
- 红高阳 疮色红而高肿，烦疼者为阳证。
- 虚歉者 虚歉者为冷寒所致，是阳毒盛，不能外越，寒极生热现象。
- 先补强 先补者为佳，使邪外出，不盘踞于内。
- 诸疮症 各种疮类或纯阴或半阴俱有，均先补为要。
- 兼清良 补后再用清法使阴邪渐去。
- 疮初起 疮的初起，不分阴阳，大都是气血瘀滞。
- 揉患上 重揉疮顶之上。
- 左右旋 左旋一百，右旋一百，不可偏数，但咳嗽病人不能用平均推数。
- 立消亡 疮顶硬，旋揉后，可很快消亡，若脓血盛不可揉。
- 胸膈闷 肝在膈下，肺在膈上，胸肺相连，若五脏之气不调，必然胸膈堵闷不舒。
- 八卦详 推八卦能和血脉，调和五脏之气。
- 男女逆 凡运八卦，要分清：男左掌顺运，女右掌逆运。
- 左右手 男女逆推分左右手，因阴阳不同，穴位亦相反。
- 运八卦 男自左手乾起自兑字止，为一运；女右手起相反，故为逆也。
- 离宫轻 五行学说中火的方位为南方属火，运八卦时，离宫在南，属火，宜轻按。
- 痰壅喘 痰涎壅滞，气血不和而喘。
- 横纹上 重揉四横纹，和血顺气而止喘。
- 左右揉 来回推数百次。
- 久去恙 凡虚证日久非立刻能愈，必须按揉数多，方可效佳。

- 治歉症 气虚为歉，血亏为癆，虽不咳为癆症。
- 并癆伤 癆在五脏，故有五癆。
- 歉弱者 歉者气亏血弱，力不足而为歉证。
- 气血伤 辨气血之证，看脉准不准，以观其形体状态如何。
- 辨此症 一般气亏作冷，血亏作热。
- 在衣裳 以衣裳辨之，即知不用问。
- 人着衿 人穿着衣时，他穿而仍冷者为气虚。
- 伊着棉 病人穿着棉衣，仍觉寒冷，为阳气虚，虚则阳退，不耐冷。
- 亦咳嗽 咳嗽不愈，伤于癆症，又名亏癆，是气血双亏。
- 名七伤 此症指七情所伤。
- 补宜多 歉者兼内伤，是饥饱癆后所伤，必须多用补法。
- 清少良 补多清少为佳。
- 人穿衿 寒热穿衣要适当，常人穿衿时，而病者着单衣。
- 他穿单 病者虽穿单衣，还觉烦热。
- 名五癆 咳嗽无时，名曰五癆，为血亏不能制气。
- 肾水伤 水停不能制火故热而不冷也。
- 分何脏 癆症有五种，须辨明何脏，为哪种癆证。
- 清补良 必须多清少补，而与病情恰当为好。
- 在学者 细心详察，认真研究病情的操作者。
- 细心详 详细辨证，选穴恰当。
- 眼翻者 肝开窍于目，在急、慢惊风时两眼可上视或斜视。
- 上下僵 上下左右翻而不动，为两目直视。
- 揉二马 揉此穴犹如八味地黄丸，大补肾中水火。
- 捣天心 在大小鱼际交叉点用捣法。
- 翻上者 两目上视。
- 捣下良 向上视者自小天心往下捣。

- 翻下者 两目下视。
- 捣上强 下视者自天心穴往上捣。
- 左捣右 眼往左斜视者向右捣，若对眼者往两旁捣之。
- 右捣左 向右斜视者向左捣，向两侧斜视者从两旁向天心捣。
- 阳池穴 此穴能疏风解表。
- 头痛良 头痛者左右推之，以愈为止。
- 风头痛 因风头痛者乃外感风寒所致。
- 蜂入洞 选黄蜂入洞穴施治。
- 左旋右 由左旋转向右推，不必拘数。
- 立无恙 如此推法立刻去病。
- 天河水 天河水为通心火，若心火旺极，此穴能清心泻火。
- 口生疮 多由心脾之火所致，故用天河水清热泻火。
- 遍身热 脾生肉，心生火，手热者即心脾火旺，故清心补脾，清天河水即能清心。
- 多推良 凡口生疮，遍身热之证，多推天河水为良。
- 中气风 中气风皆因内伤，而外感风邪亦气虚而生痰。
- 男左逆 逆推即为男用右手，女用左手。
- 右六腑 手六腑之穴，能去风开郁祛痰。
- 男用良 推则至效，立愈无犯。
- 左三关 左手用三关之穴属热，去风开郁化痰，必须逆用，方有效。
- 女用强 男女逆用为佳。
- 独穴疗 凡独穴而不可用二穴，用则有害，即互相牵制影响疗效。
- 数三万 凡独穴必须推3万数，少则不验。
- 多穴推 对病情重而选穴多的首先要弄清主次穴位，不可无

法。

约三万 对于慢性病推的时间要长，约3万次。

遵此法 诸症遵此推法，不可妄为加减。

无不良 诸病能愈，不可妄用它穴。

遍身潮 遍身潮热，而皮肤滑腻感觉是汗脉运动在一起。

分阴阳 以两大拇指从总筋向两侧分其阴阳。

拿列缺 重拿列缺穴。

汗出良 汗出即愈。

五经穴 即五指根纹，来回推之，能开脏腑寒火而腹中和

平。

肚胀良 故肚胀能愈。

水入土 运水入土，土者脾胃，水者肾水也。

不化谷 五谷不化用运水入土穴，则脾胃和土气不下陷。

土入水 运土入水。

肝木旺 祖国医学认为肝木旺极必来克土，所以运则补土，

而木不能克土。

小腹寒 凡受风寒冷气，则小腹疼痛。

外劳宫 此穴属热穴，能祛风散寒，冷气皆消。

左右旋 握者屈小指左右旋转，无偏为要。

久揉良 揉的次数要多或揉的时间长些为好。

咀唇裂 脾开窍于口，脾伤则唇裂，而肿或疼或口外生疮，

皆为脾症。

脾火伤 因脾火太盛而伤。

眼胞肿 上眼皮肿属脾，下眼皮肿属胃，眼胞肿而脾胃火

盛。

脾胃恙 虽属脾胃之火，但与肝肾有关。

清补脾 以上病症非寒即热，非实则虚，故定清补之火，虽

口眼歪斜治之则愈。

俱去恙 以上之症均能治愈。

向内补 向内推为补。

向外清 向外推为清。

来回推 凡穴来回推者和血顺气，虚中夹实用之。

清补双 故清补为双治法，即攻补并用。

天门口 此穴乃天门入虎口。

顺气血 和气顺血。

五指节 此穴可和血舒筋，属肝经主风症，推完必节节掐。

惊吓伤 小儿惊吓伤于肝胆，久则肝克脾土，吐泻并见。

不计次 不必计次数和顺序。

揉必良 或揉或掐都能治好。

腹痞积 小儿腹有痞积之症，或在左，或在右，或绵软，或成块。

时撮良 每日按时推拿，可使痞积得消。

一百日 坚持推一百日。

即无恙 只要用此法一定能治愈。

上有火 上有火者，下焦必寒。

下有寒 下有寒者，上焦必热。

外劳宫 此穴在手背中属大热，能去寒风冷气。

下寒良 下部有寒症，推此穴，必能温下元，去虚寒。

六腑穴 左手六腑之穴大凉，推之能去上焦之火。

去火良 若上火下寒之症，必须兼推此穴。

左三关 左手三关之穴，亦属大热。

去寒恙 推上三关能去上焦之寒。

右六腑 右手六腑穴。

亦去恙 也能治疗疾病。

虚补母 虚证补其母，如肺为脾之子，脾为肺之母，如肺虚则可补脾。

实泻子 实证可泻其子，如脾胃实热，可兼泻肺经，以取泻热之目的。

日五行 一昼夜 24 小时，都有五行存在。

生克当 正常情况下，相克相生有一定的规律。

生我母 生我者为母，如木生火，木为母，火为子；火生土，火为母，土为子。

我生子 我生者为子，如火生土，土为子。

穴不误 辨证准确，选穴精当，不可盲目取穴。

治无恙 只要选穴正确，就能治愈疾病。

古推书 古代推拿的书。

身手足 是经过在人体各个部位反复实践得出的经验记载。

执治婴 掌握它，用来治疗小儿疾病。

无老方 没有固定的穴位，要根据辨证取穴。

皆气血 都是气血。

何两样 不分老少。

数多寡 分岁数以定推数多少。

轻重当 而量其手法轻重。

吾载穴 我载的穴位与古人不同，大多以独穴为主。

不相商 经验多次，验之有效。

老少女 凡年少年老及女子皆可推之。

无不当 不论男女老少，凡病用推拿治疗。

遵古推 若遵循古人推拿法。

男女分 古法分男女，男左分女右。

俱左手 男女俱推左手。

男女同 同是一样去病。

- 余尝试 通过自己临床实践，并无左右之异。
- 并去恙 一样可以去病。
- 凡学者 希望想学推拿者，细心研究，精心体会。
- 意会方 弄清实质，则变化无穷。
- 加减推 凡病当加则加，当减则减，经辨证虚实寒热，再加
减用之。
- 身歉状 人身气血，歉状之症，轻重次数多少。
- 病新久 病有新久、轻重之分，看准要害，正确施治。
- 细思详 要细心思量，详细辨证。
- 推应症 所推之穴应与症相符，才能取得良效。
- 无苦恙 首先要认清病的轻重，与推穴手法适当，决无痛苦
等副作用。
- 传后世 将此推拿法传至后世。
- 救人良 救济人民为天良之心。

参 考 文 献

1. 靳文龙, 林惠芳, 王淑翠. 睡前小儿按摩 10 分钟. 石家庄: 河北科学技术出版社, 1995
2. 金义成. 小儿推拿. 上海: 上海科学技术文献出版社, 1981
3. 焦平. 小儿家庭保健推拿. 北京: 中国广播电视出版社, 1990
4. 漆浩. 中国神奇手疗大全. 北京: 农村读物出版社, 1992
5. 北京按摩医院. 中国按摩全书. 北京: 华夏出版社, 1993